	IDENTIFICACION 402454	DIA/MES/AÑO 29/09/2015

APELLIDO	NOMBRE		
CUCHASKY	MARGARITA		
SEXO	ESTADO CIVIL	FECHA DE NACIMIENTO	NACIONALIDAD
Femenino	Soltero/a	12/03/1943	Argentina
DOCUMENTOS	DOMICILIO		TELEFONO
DNI	MOZART 610		46827559
ID506485	LOCALIDAD		
	CABA		

OBRA SOCIAL
PAMI 150163 040501/00 LC: 62140

PERSONA A NOTIFICAR EN CASO DE EMERGENCIA
Nicolás H. Kosciuk cel: 1558104763

RESUMEN DE DIAGNOSTICOS

FECHA DE INGRESO	SERVICIO	INTERNACION	CODIGO	FECHA DE EGRESO	FIRMA ACLARADA DEL PROFESIONAL
29/09/2015	GUARDIA	DIAGNOSTICO			
		Sindrome coronario Agudo. Toracodinia en estudio a descartar NAC. → PANCREATITIS			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			

Agustín Pablo Seijo
MD U.B.A
M.N. 142256

		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			

(2)

Agustín
MD U.B.A.
M.N. 142251

3

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Resolución 0356/MSGC/09 - Ley N° 153 - Decretos N° 208/01 y N° 2316/03

HOSPITAL: GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"

H. Clinica N°

D	M	A
29	9	15

Datos del paciente

A Nombre y apellido: MARGARITA CUCHASKY

Documento de Identidad: DNI ID506485

LEER CON ATENCION

Este formulario contiene la información que suministra al médico sobre el estado de salud del paciente (el diagnóstico presunto o de certeza), el tratamiento que se aconseja o indica y los beneficios buscados; los riesgos que presenta este tratamiento, algún otro tratamiento o ningún tratamiento; finalmente la aceptación de la propuesta y su autorización para llevarlo a cabo o su rechazo. El presente formulario ser{a firmado por el paciente, si no pudiera, el pariente más cercano o persona autorizada. En el reverso se encuentran las instrucciones para completar los espacios.

B **Diagnóstico:**

TORACODINIA PANCREATITIS

C **Tratamiento y/o práctica propuestos:**

PHP
ANALGESIA
ATB OXIGENO

D **Beneficios buscados:**

MEJORIA DEL CUADRO

E **Riesgos típicos del tratamiento o práctica propuestos:**

EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES COLATERLES

F **Alternativas al tratamiento o práctica propuestos:**

NO

G Manifestación de aceptación o rechazo: HE COMPRENDIDO LA EXPLICACION Y ACEPTO-
RECHAZO EL TRATAMIENTO (tachar lo que no corresponde).

Firma y Aclaración: Nicolás H. Kosciuk NICOLAS H. KOSCIUK DNI 28731776

H Observaciones y preguntas:

MARIANGELES JUSTY
MEDICA - U.B.A
MN 138435

I Firmas : (aclarando nombre y apellido):

Paciente o Familiar | Testigo-DNI | Medico del equipo Tratante N° de Matricula | Jefe de Servicio N° de Matricula

MARIANGELES JUSTY
MEDICA - U.B.A
MN 138435



INSTRUCCIONES PARA LLENAR LOS ESPACIOS DE ESTE FORMULARIO

La confección del presente formulario quedará cumplida con las firmas de los intervinientes

Para el médico tratante:

1 Deberá escribir con letra clara todos los espacios, consignando en B diagnóstico los datos patológicos relevantes disponibles relacionados con su diagnóstico y tratamiento.

Si Utiliza abreviaturas, deberá aclararlas; las enmiendas o raspaduras, deberán ser salvadas.

2 Indicará el procedimiento diagnóstico o terapéutico de elección.

3 Deberá ofrecer las alternativas diagnósticas o terapéuticas, a las afecciones que padece el paciente.

4 Describirá los riesgos tipicos del procedimiento propuesto y las consecuencias seguras. Se autoriza a agregar anexo con las posibles complicaciones u otros riesgos, en cuyo caso se hará constar su inclusión en el punto E).

5 Contestará todas las preguntas que el paciente formule, en caso de no haber ninguna, escribirá NINGUNA.

6 Dejará asentado en la Historia Clínica que se firmó el Consentimiento Informado, y que se adjunta.

7 En caso de no confeccionarse el Consentimiento Informado por negativa del paciente, lo dejará asentado en la Historia Clinica (según indican los Decretos Nro. 208/2001 y Nro. 2316/2033).

Para el paciente o autorizante:

1 Tiene el derecho a preguntar todas las caracteristicas de la afeción y de los tratamientos que se consideran en esta ocasión. De no haber pedidos de aclaración, se considera que entiende completamente de que se trata.

Si ha comprendido toda la explicación de la práctica, los riesgos y sus tratamientos, se deberá tachar lo que no corresponda (ACEPTO o RECHAZO), firmando y aclarando firma.

3 Deberá firmar y aclarar su nombre, presentando su documento al médico, ante la manifestación de no poseerlo se le tomará impresión digito pulgar.

Para el Jefe de Servicio:

1 Deberá observar que se cumpla con el procedimiento indicado para este formulario.

2 Constatará que el formulario haya sido adjuntado a la Historia Clínica correspondiente.

OBSERVACIONES FINALES (exclusivo para el Jefe de Servicio)

Fecha: Jefe de Servicio:

Se firman dos ejemplares: uno para la Historia Clínica y otro para archivo del Hospital

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

(5)

Identificación		**HC N° 402454**			**CAMA BB SHOCK**
Apellido y nombre		**CUCHASKY, MARGARITA**			
Sexo	**Femenino**	Edad	**72 años**		
Obra Social	**PAMI**			Documento Tipo y Nro	**DNI ID506485**
Fecha de nacimiento		**03/12/1943**		Nacionalidad	**Argentina**
Domicilio	**MOZART 610**			Teléfono	
Estado Civil	**Sin datos**				
Día de ingreso al hospital		**29/09/2015**			

MOTIVO DE INGRESO
sindrome coronario agudo

ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente de 72 años de edad es traida por ambulancia del SAME por presentar dolor precordial tipico de 1 hora de evolucion cuando es evaluada por SAME en domicilio.
Al examen fisico
TA 140/90 Fc 90 FR 20 sat 98% afebril vigil globalmente orientada sin foco neurologico, bien perfundida sin edemas sin falla de bomba aguda. BMV con hipoventilacion bibasal. abdomen blando depresible indoloro. rha+.
Se ingresa a shockroom se coloca via periferica, se indica 500mg de Aas, se toman muestras para laboratorio con enzimas cardiacas. Se
realiza ECG con Ritmo regular sinusal Fc 70, Pr 0.16 Qrs angosto sin supraST, buena progresion de R en precordiales.
HGT 190.
Rx torax mala tecnica impresiona infiltrado con broncograma en base derecha.
continua control por guardia entrante.

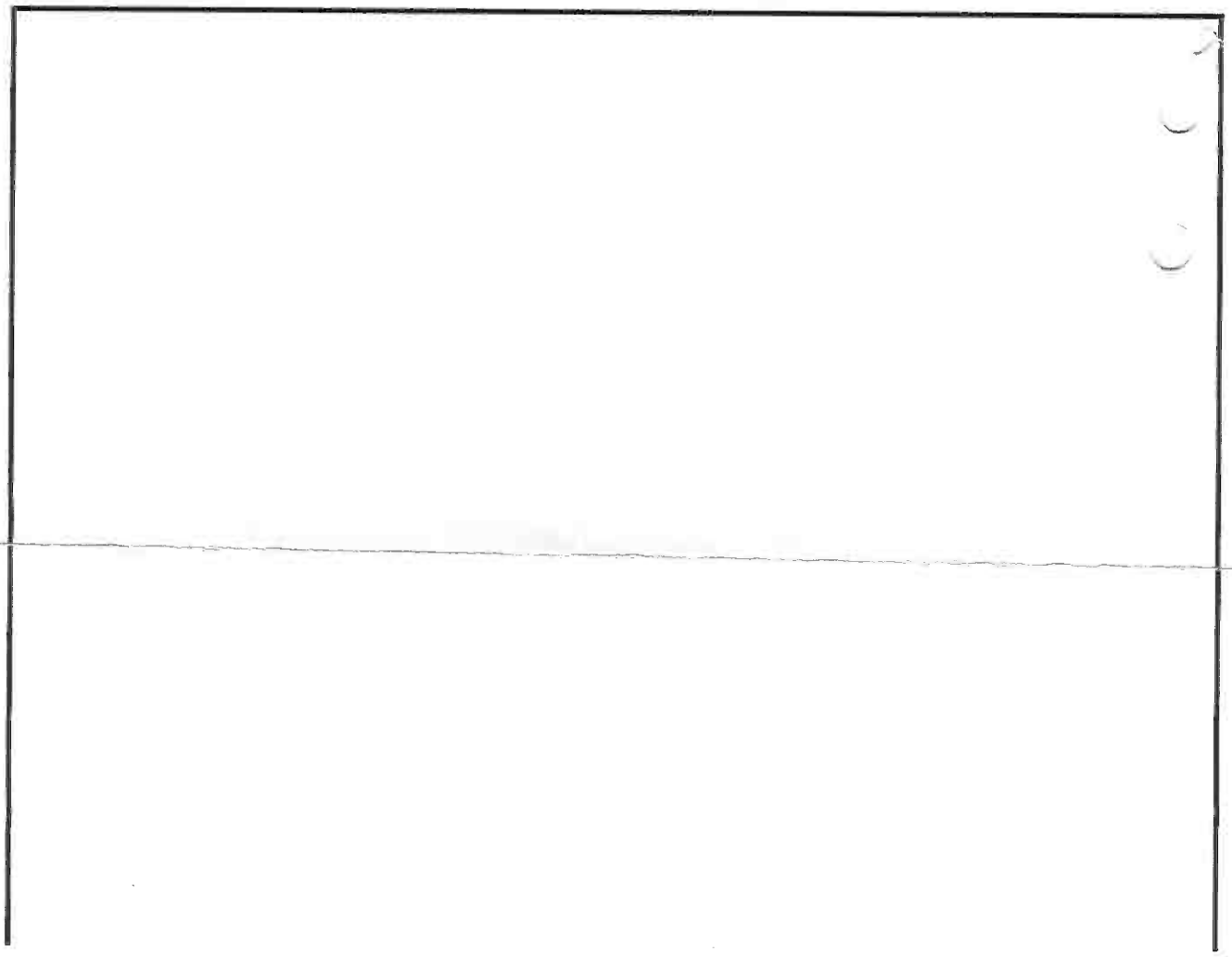
ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD ACTUAL
TVP anticoagulada
Osteoporosis
Deterioro cognitivo?

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:
Sindrome coronario Agudo.
Toracodinia en estudio a descartar NAC.

TRATAMIENTO:
DR.YURQUINA, CESAR (UTI) MN 120.270

IDPACIENTE: 506485/IDG: 6323 29/09/2015 07:36:21 a.m.

Agustin Pablo Seijo
MD U.B.A
M.N. 142256



Hospital General de Agudos PARMENIO T. PIÑERO

Laboratorio de Guardia

(6)

Apellido: KUCHASKY Nombre: MARGARITA

Núm. Petición: 1552948 SALA DE GUARDIA Origen: GUARDIA

Fecha Petición: 29/09/2015 72 Historia Clinica: **4214110**

GUARDIA QCA. CLÍNICA

GLUCOSA		108	mg/dl	[70 - 110]
UREA		19	mg/dl	[10 - 50]
CREATININA		0.6	mg/dl	[0.5 - 0.9]
CK		77	UI/l	[24 - 190]

GUARDIA HEMATOLOGÍA

HEMATOCRITO	*	35	%	[36 - 53]
LEUCOCITOS		6.60	x10e9/L	[4.50 - 11]

GUARDIA COAGULOGRAMA

R.I.N	*	3.99		[0.9 - 1.2]
KPTT	*	38	seg	[21 - 34]

GUARDIA IONOGRAMA

SODIO		140	mEq/l	[135 - 145]
POTASIO		4.0	mEq/l	[3.5 - 5.2]
CLORO		98	mEq/l	[90 - 110]

TP
HEPARINA
- FAL
- AMUSA

Fecha: 29/9/2015 *Hora:* 11:43

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

Nombre y Apellido	**CUCHASKY, MARGARITA**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**29/09/2015**	Cama:	**BB SHOCK**	Días Int.	

DIAGNOSTICO:
Sindrome coronario Agudo.
Toracodinia en estudio a descartar NAC.

14:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: PTE LUCIDA O EN T Y E HD ESTRABLE AUSENCIOA DE SIGNOS DE FALLA DE BOMBA MOVILIZA 4 MIEMBROS Y SE ENCUIENTRA CON GLASGOW 15/15. PERSISTENCIA DE DOLOR POR DEBAJO DE LAS COSTILLAS, SE INTERPRETA Y LO SEÑALA COMO EN BARRA. RESTO DEL EXAMEN FISICO SIN VARIANTES.
SE REALIZA ECOGRAFIA, VESICULA SIN LITIASIS,, CON ABUNDANTE METEORISMO Y CON REFERENCIA A ALA CABEA DEL PANCREAS COM AGRANDADA RESULTADO DE L ATROPONINA NEGATIVO SI PRESENTA AMILASEMAI A DE 3198 CON F ALCALINA DE 108, TGO 1925 GPT 127, RIN 4.05 Y KPTT 35.
SOLICITO TAC DE ABDOMEN E IC CON CIRUGIA. REPITO COAGULOGRAMA.
SOLICITO SU DERIVACION A UTI.
SELLO: DR. LUIS ALBERTO ANGULO ROSAS (MEDICO CLINICO MN 86599)

IDPTE506485IDG6323 IMPRESO EL 29/09/2015 02:26:33 p.m.

LUIS A. ANGULO ROSAS
MEDICO
M.N. 86599 - M.P. 3818

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

Nombre y Apellido	**CUCHASKY, MARGARITA**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**29/09/2015**	Cama:	**BB SHOCK**	Días Int.	

DIAGNOSTICO:
Sindrome coronario Agudo.
Toracodinia en estudio a descartar NAC.
PANCREATITIS AGUDA

17:30 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: PACIENTE DE 72 AÑOS CON ANTECEDENTES DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN MIEMBRO DERECHO EN SEGUIMIENTO DESDE 2012, CON ECODOPPLER DE MIEMBRO INFERIOR EN 2013 , 2014 Y 2015 TRAIDOS POR LA PACIETNE Y QUE SE ADJUNTAN EN ESTA HISTORIA CLINICA, CON EVIDENCIA DETROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN MIEMBRO INFERIOR, ANTICOAGULADA CON WARFARINAS(SINTRON) 2MG /DIA DESDE 2012 EN CONTROL POR HEMATOLOGIA CON GRILLA.
ECG RITMO SINUSAL SIN ALTERACIONES DEL ST. RX TORAX IC MENOR A 0.5, BOTON AORTICO DESENROLLADO. ANGULOS COSTODIAFRAGMATICOS Y COSTOFRENICO LIBRES.
TAC DE ABDOMEN SIN CONTRASTE. COMPATIBLES CON AUMENTO DE TAMAÑO DEL PANCREAS, DILATACION DEL CONDUCTO DE WIRSUNG, DILATACION DEL COLEDOCO, COMPROMISO DE LA GRASA PERIPANCREATICA.
LABORATORIO SE RECIBE TROPONINA NEGATIVA . LDH 395
CRITERIOS DE RANSON AL INGRESO PARA PANCREATITIS NO BILIAR EDAD MAYOR A 55 AÑOS, GB13500, LDH MAYOR 350, GOT MAYOR A 120. 4 CRITERIOS DE 5 AL INGRESO.
SE SOLICITA DERIVACION POR SAME A UTI.
SELLO: DRA. MARIANGELES JUSTY MEDICA DE GUARDIA MN: 138435

IDPTE506485IDG6323 IMPRESO EL 29/09/2015 06:21:56 p.m.

MARIANGELES JUSTY
MEDICA - U B.A
MN 138435

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

Nombre y Apellido	**CUCHASKY, MARGARITA**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**29/09/2015**	Cama:	**BB SHOCK**	Días Int.	

DIAGNOSTICO:
Sindrome coronario Agudo.
Toracodinia en estudio a descartar NAC.
PANCREATITIS AGUDA

18:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: SE LLAMA A SAME PARA PEDIR DERIVACION A UTI, (PACIETNE PAMI 150143040501/00) RECHAZO OP 302 DR. EBOLI.
SELLO: DRA. MARIANGELES JUSTY MEDICA DE GUARDIA MN: 138435

IDPTE506485IDG6323 IMPRESO EL 29/09/2015 06:49:38 p.m.

MARIANGELES JUSTY
MEDICA - U.B.A
MN 138435

(10)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

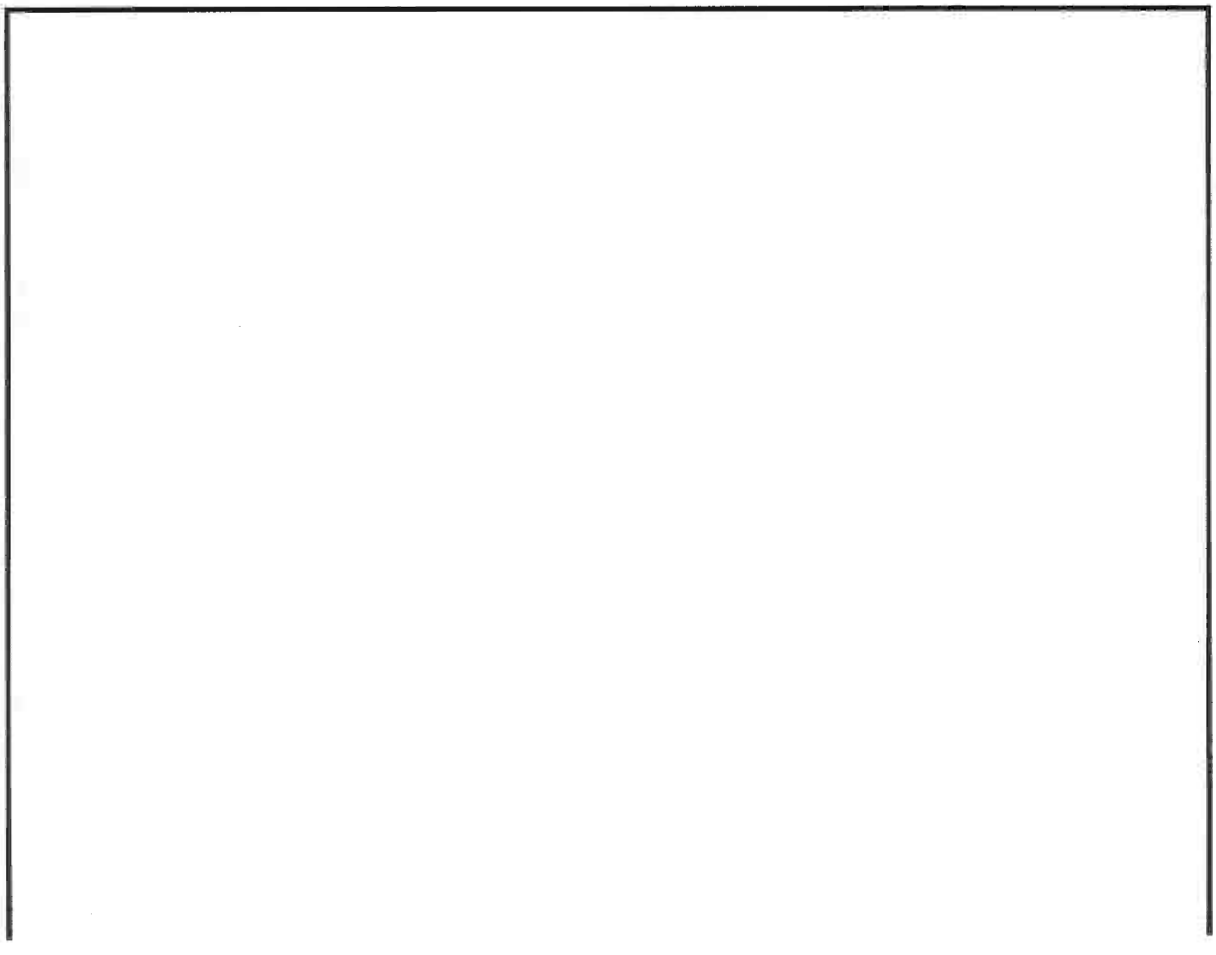
Nombre y Apellido	**CUCHASKY, MARGARITA**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**29/09/2015**	Cama:	**BB SHOCK**	Días Int.	

DIAGNOSTICO:
Sindrome coronario Agudo.
Toracodinia en estudio a descartar NAC.

14:20 ESPECIALIDAD: CIRUGIA
EVOLUCION: PACIENTE INTERNADA EN SHOCK ROOM POR CUADRO PRESUNTIVO DE DOLOR TORACICO A DESCARTAR NEUMANIA AGUDA DE LA COMUNIDAD VS. SINDROME CORONARIO AGUDO. AL EXAMEN FISICO PRESENTA ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE, LEVEMENTE DOLOROSO A NIVEL DE CENTRO ABDOMEN. SIN REACCION PERITONEAL AL MOMENTO DEL EXAMEN. SNG CON DEBITO NEGATIVO. AMILASEMIA 3198 CON FAL 108, LDH NO SE SOLICITO, GLUCEMIA 109, TGO 192, EDAD 72 AÑOS. SE SOLICITA LDH. AL MOMENTO SE INTERPRETA COMO PANCREATITIS AGUDA ALITIASICA (ECO NEGATIVA PARA LITIASIS). SE SUGIERE INVESTIGAR HIPERTRIGLICERIDEMIA.
SELLO: DR. ARMANDO VILLARROEL MEDICO CIRUJANO MP 107.187

IDPTES06485IDG6323 IMPRESO EL 29/09/2015 02:56:25 p.m.

Dr. J. Armando Villarroel
Médico Univ. Bs. As.
Especialista en Cirugía General
M.N. 107.817 / M.P. 331.778



11

HTAL PIÑERO 029/09/15 GUARDIA

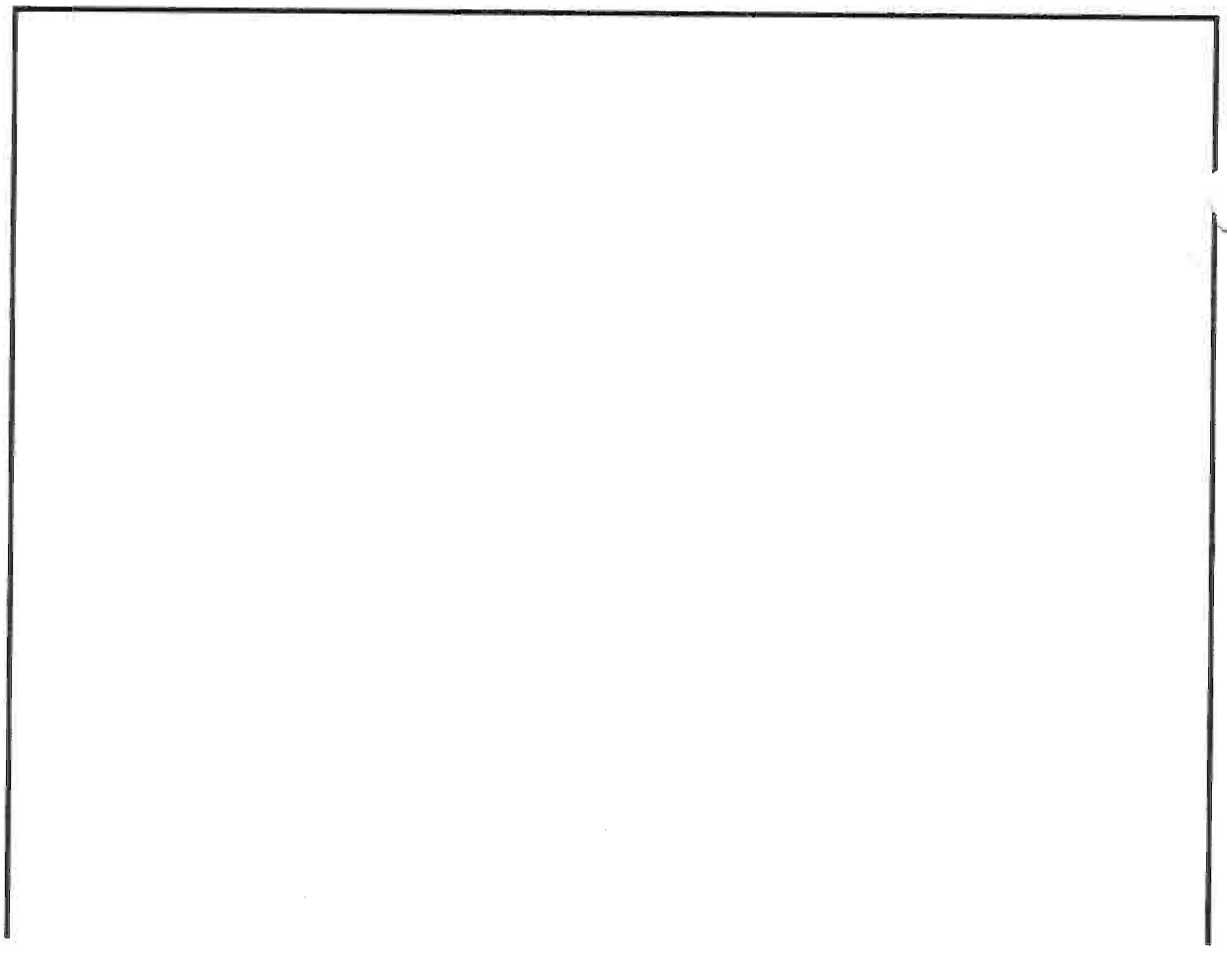
CUCHASKI, MARGARITA 72 AÑOS

PAMI 150143040501/00

SE ENTREGA DOCUMENTACION PARA TRASLADO A SANATORIO NUEVO PALERMO

1. TRES ECODOPPLER DE MIEMBROS INFERIORES TRAIDOS POR LA PACIENTE
2. RUTINAS DE LABORATORIO 3 FOJAS
3. ECG
4. ECOGRAFIA ABDOMINAL
5. TAC DE ABDOMEN 2 HOJAS





ANEXO V

(12)

"Consentimiento Informado para uso de documentación médica en el marco de la Ley 2808"

Efector: **HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO**

Nombre y Apellido del Paciente: MARGARITA CUCHASKY
Exhibe documento acreditativo de identidad? **SI**
Tipo: DNI Nº: ID506485
Ente de Cobertura de Salud al que manifiesta afiliación:

Nº de afiliado

Acompaña fotocopia de credencial: **SI - NO** (Tachar lo que no corresponda)
Quien suscribe MARGARITA CUCHASKY en su carácter de afiliado a PAMI, manifiesta por medio de la presente su expresa conformidad con el uso de antecedentes médicos que obraran en el Efector, estudios realizados y toda otra documentación relacionada con las prestaciones realizadas a los únicos fines de obtener el reintegro de los gastos por parte del ente de cobertura de salud que corresponda

SI - NO (Tachar lo que no corresponda) MANIFIESTO MI CONFORMIDAD

FIRMA

ACLARACION

FECHA

NOTA: Si es que suscribe es el representante legal completar

Nombre y Apellido del que suscribe

Tipo de representación (madre, padre, tutor, curador, etc.)

En caso de tratarse de tutores/curadores especificar carátula del expediente judicial donde se dirimió la tutela/curatela y juzgado actuante:

Infojus
SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURÍDICA

13

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

INFORME ESTADÍSTICO DE HOSPITALIZACIÓN

Hist. Clínica Nº:
Nº de Informe:

Establecimiento: **HOSPITAL PIÑERO** Cód. establecimiento: **1261**

Apellido y nombre del paciente:		
Documento:		Sexo
Fecha de nacimiento:	Edad al ingreso:	Doc. De la madre:

Residencia habitual

Calle:	
Localidad:	
Partido:	
Provincia	Pais: **Argentina**

Pertenece o está asociado a:	Situación laboral:
Ocupación habitual:	Nivel de instrucción:

Hospitalizado por:

Fecha de ingreso	Servicio	Cama
	GUARDIA	

Fecha de egreso:	Hora de egreso:	Días de estada:	Tipo de egreso
			Alta medica 1 ___ Defuncion 3 ___ Otros 5 ___ Traslado 2 X Retiro Voluntario 4 ___

Procedimientos quirúrgicos u obstétricos	Fecha de operación:	Días de preoperatorio:

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL AL EGRESO	CÓDIGO
Pancreatitis aguda	**K85**
OTROS DIAGNÓSTICOS	CÓDIGO

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y OBSTÉTRICOS:	CÓDIGOS

OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROLONGAN LA INTERNACIÓN:	Fecha de inicio	Días por otras circunst:
	☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐	

CAUSA EXTERNA DE TRAUMATISMO, ENVENENAMIENTO Y OTROS EFECTOS ADVERSOS

Producido por		Lugar donde ocurrio	
1.___ Accidente	3.___ Agresiones	1.___ Domicilio	3.___ Lugar de Trabajo
2.___ Lesiones autoinflingidas	4.___ Se ignora	2.___ Via Publica	4.___ Otros

Describir las circunstancias o situación en que aconteciño el hecho, por ejemplo: caída de un andamio, herido por arma de fuego, intoxicación por agroquímicos, etc.:

CODIGO: ☐☐☐☐

Paciente de 72 años de edad es traida por ambulancia del SAME por presentar dolor precordial tipico de 1 hora de evolucion cuando es evaluada por SAME en domicilio.

Al examen fisico

TA 140/90 Fc 90 FR 20 sat 98% afebril vigil globalmente orientada sin foco neurologico, bien perfundida sin edemas sin falla de bomba aguda.

Fecha de terminac. embarazo:	Peso al nacer en	Condición al nacer		Terminación		Sexo		
		Nac. vivo	Def. fetal	Vaginal	Cesárea	Masc.	Fem.	Indeter.

G.C.B.A.

HOSPITAL PARMENIO PIÑERO

HOJA DE EPICRISIS

14

Paciente CUCHASKY, MARGARITA		**HC Nº**	402454
Servicio de Egreso DEPARTAMENTO DE URGENCIAS			
Cama BB SHOCK	**Fecha de Ingreso**	**Fecha de Egreso**	**Días**
	29/09/2015	29/09/2015	0

PACIENTE: CUCHASKY, MARGARITA HC N°: 402454 CAMA: BB SHOCK
FECHA DE INGRESO: 29/09/2015 FECHA DE EGRESO: 29/09/2015 DIAS DE INTERNACION: 0

MOTIVO DE INTERNACION:
sindrome coronario agudo

ENFERMEDAD ACTUAL:
Paciente de 72 años de edad es traida por ambulancia del SAME por presentar dolor precordial tipico de 1 hora de evolucion cuando es evaluada por SAME en domicilio.
Al examen fisico
TA 140/90 Fc 90 FR 20 sat 98% afebril vigil globalmente orientada sin foco neurologico, bien perfundida sin edemas sin falla de bomba aguda. BMV con hipoventilacion bibasal. abdomen blando depresible indoloro. rha+.
Se ingresa a shockroom se coloca via periferica, se indica 500mg de Aas, se toman muestras para laboratorio con enzimas cardiacas. Se
realiza ECG con Ritmo regular sinusal Fc 70, Pr 0.16 Qrs angosto sin supraST, buena progresion de R en precordiales.
HGT 190.
Rx torax mala tecnica impresiona infiltrado con broncograma en base derecha.
continua control por guardia entrante.

ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD ACTUAL:
TVP anticoagulada
Osteoporosis
Deterioro cognitivo?

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:
Sindrome coronario Agudo.
Toracodinia en estudio a descartar NAC.
PANCREATITIS AGUDA

MARIANGELES JUSTY
MEDICA - U.B.A
MN 138435

FIRMA:
DRA. MARIANGELES JUSTY MEDICA DE GUARDIA MN: 138435

EGRESO COMO: TRASLADADO A OTRA INSTITUCIÓN

DRA. MARIANGELES JUSTY MEDICA DE GUARDIA MN: 138435

EPICRISIS IMPRESA EL DÍA: 30/09/2015 09:09:11 a.m.IDPTE:506485IDHCG:6323

	U4C1 **IDENTIFICACION** 24143 GUARDIA **416191**		DIA/MES/AÑO **20/1/2020**

APELLIDO **KUCHASKY**		NOMBRE **MARGARITA LEONOR** (15)	
SEXO **Femenino**	ESTADO CIVIL	FECHA DE NACIMIENTO **12/5/1943**	NACIONALIDAD **Argentina**
DOCUMENTOS **DNI**	DOMICILIO		TELEFONO 4682-7559
4214110	LOCALIDAD **CABA**		

OBRA SOCIAL
PAMI

PERSONA A NOTIFICAR EN CASO DE EMERGENCIA

UE SIN DEJAR DATOS 4 1524020854 Nicolás (hijo).

RESUMEN DE DIAGNOSTICOS

FECHA DE INGRESO	SERVICIO		INTERNACION	CODIGO	FECHA DE EGRESO	FIRMA ACLARADA DEL PROFESIONAL
20/1/2020	GUARDIA	DIAGNOSTICO				DRA. BEDINZ. MEDICA M.N. 115.046
		DETERIORO COGNITIVO CRONICO				
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA				
		DIAGNOSTICO				
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA				
		DIAGNOSTICO				
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA				

		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			
		DIAGNOSTICO			
		INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA			

(16)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

INFORME ESTADÍSTICO DE HOSPITALIZACIÓN

Hist. Clínica Nº: **402454**
Nº de Informe:

Establecimiento: **HOSPITAL PIÑERO** Cód. establecimiento: **1261**

Apellido y nombre del paciente: **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			
Documento: **4214110**			Sexo **Femenino**
Fecha de nacimiento: **12/05/1943**	Edad al ingreso: **76**		Doc. De la madre:

Residencia habitual

Calle: **MOZART 610**	
Localidad: **CABA**	
Partido:	
Provincia	Pais: **Argentina**

Pertenece o está asociado a: **PAMI**	Situación laboral:
Ocupación habitual:	Nivel de instrucción:

Hospitalizado por: **sindrome confusional**

Fecha de ingreso	Servicio	Cama
2020-01-22	**GUARDIA**	**18**

Fecha de egreso:	Hora de egreso:	Días de estada:	Tipo de egreso
2020-04-28		**97**	Alta medica 1 ___ Defuncion 3 X Otros 5 ___ Traslado 2 ___ Retiro Voluntario 4 ___

Procedimientos quirúrgicos u obstétricos	Fecha de operación:	Días de preoperatorio:

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL AL EGRESO	CÓDIGO
Otras infecciones locales piel y tejido subcutaneo	**L08**
OTROS DIAGNÓSTICOS	CÓDIGO

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y OBSTÉTRICOS:	CÓDIGOS

OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROLONGAN LA INTERNACIÓN:	Fecha de inicio	Días por otras circunst:
	☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐	

CAUSA EXTERNA DE TRAUMATISMO, ENVENENAMIENTO Y OTROS EFECTOS ADVERSOS

Producido por	Lugar donde ocurrio
1.___ Accidente 3.___ Agresiones	1.___ Domicilio 3.___ Lugar de Trabajo
2.___ Lesiones autoinflingidas 4.___ Se ignora	2.___ Via Publica 4.___ Otros

Describir las circunstancias o situación en que aconteciño el hecho, por ejemplo: caída de un andamio, herido por arma de fuego, intoxicación por agroquímicos, etc.:

CODIGO: ☐☐☐☐

AILEN MARTIARENA
MEDICA U.B.A.
M.N. 153.107

Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP anticoagulada con sintron, deterioro cognitivo, gastritis crónica, esquizofrenia. Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clinica. Ingresa a guardia externa el 20/01, traida desde su domicilio acompañada por familiar por presentar un síndrome confusional hipoactivo. Familiar refiere no poder hacerse cargo del cuidado de su madre, por lo que se encuentra en búsqueda de un geriátrico, por PAMI para un tercer

Fecha de terminac. embarazo	Peso al nacer en gramos	Condición al nacer		Terminación		Sexo		
		Nac. vivo	Def. fetal	Vaginal	Cesárea	Masc.	Fem.	Indeter.
		1	2	1	2	1	2	3

G.C.B.A.

HOSPITAL PARMENIO PIÑERO

HOJA DE EPICRISIS

(17)

Paciente KUCHASKY, MARGARITA LEONOR		**HC Nº**	402454
Servicio de Egreso UNIDAD 1 DE CLINICA MEDICA			
Cama 18	**Fecha de Ingreso** 22/01/2020	**Fecha de Egreso** 28/04/2020	**Días** 97

PACIENTE: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR HC N°: 402454 CAMA: 18
FECHA DE INGRESO: 22/01/2020 FECHA DE EGRESO: 28/04/2020 DIAS DE INTERNACION: 97

ANTECEDENTES:
demencial, esquizofrenia, VGI previo a internacion: anciana geriatrica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

DIAGNÓSTICO AL INGRESO:
sindrome confusional

INTERCURRENCIAS:

*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 dias.
*16/04: ITU bacteremica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajsutado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina. Finaliza en el dia de la fecha PTZ, continua con vancomicina.

DIAGNOSTICO DE EGRESO (1):
L08-Otras infecciones locales piel y tejido subcutaneo

COMENTARIOS:
Paciente que presentaba mal estado general, VGI previa: geriátrica, en estado de abandono, con multiples sindromes geriatricos, comorbilidades. Internacion prolongada de causa social, con intercurrencias de indole infecciosa por germenes resistentes, la ultima de ellas por una infección de piel y partes blanda, bacteremica por SAMR, con mala evolución pese a tratamiento especifico con antibioticoterapia.
Siendo las 00:30 del dia 28 de abril de 2020, se constata óbito de la paciente.
Se intento comunicación telefónico con numero de contacto(familiar-hijo) que no se hizo efectivo, se dejo mensaje en buzon de llamadas.
Se completaron formularios pertinentes, se traslado cuerpo a la morgue.

EGRESO COMO: ÓBITO

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

EVOLUCIÓN IMPRESA EL DÍA: 28/04/2020 09:07:52 a.m.IDPTE:506485IDCM1:7135

AILEN MARTIARENA
MEDICA U.B.A.
M.N. 153.107

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE SALUD
PROGRAMA SIDA

En cumplimiento del Art. 6° de la Ley 23.798 (Decr. Reglam. 1244/91), el profesional actuante debe completar el siguiente formulario cada vez que solicite laboratorio para la identificación de infección por HIV

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO	**Adjuntar el presente consentimiento informado a la Historia Clinica del paciente.**

Declaro que he sido informado sobre la necesidad de someterme a las pruebas diagnósticas para la detección de HIV (Virus del SIDA), que se me ha asegurado la confidencialidad de los resultados, asi como el asesoramiento pertinente. Por lo expuesto, consiento expresamente a que se me efectúe dicha prueba diagnóstica.

(SI) (NO)

Embarazo: NO Unidad: C.MEDICA UNIDAD 4 Cama: 4

Domicilio: MOZART 610 Teléfono: 46827559 Fecha: 22/1/2020

Historia Clínica Nº: 402454 Documento (Tipo y N°): DNI 4214110

Firma del Paciente

Aclaración

(20)

285

Dra. SILVIA PLATAS
AUDITOR INTERNO TITULAR
MINISTERIO DE SALUD G.C.A.B.A.

Viernes 28 de Febrero de 2020

SR DIRECTOR: VENGO a reclamar porque me es imposible conseguir la historia clinica de mi madre (unidad 4, cama 4, esta internada actualmente). El pedido es porque segun los medicos la demencia ha hecho desaparecer todas las enfermedades y todo es inventado. "No se puede saber si inven o no" dicen. Pues veamos y listo.

Concretamente el Dr Copani me dijo que vaya a Direccion Medica, nunca pude encontrar eso. En admision y egreso me dicen que pueden tomar el pedido pero la historia clinica no les va a llegar hasta e alta. Entonces me tienen boludeando de aca para allá.

Le doy un ejemplo, mi mama se queja desde hac varios dias que le duele el ano. El doctor dice que inventa, pero eso era que ya pasaba en casa, incluso hubo veces en que se saco la mierda con la mano!!!

Disculpe mi lenguaje pero no soy medico y por tanto mi comprension de las cosas es muy limitada. Casi rozando el analfabetismo.

Le solicito interceda para conseguir la historia.

Nicolas M. Kosinik

DNI 28731776

15-2402-0854

U4C4 Note Dr. Cipriani

21

Buenos Aires, 04 de Marzo de 2020

A Dirección Hospital Piñero

Dr. Daniel Rivero

Asunto : Respuesta reclamo Paciente Kuchasky Margarita

En relación a la nota presentada por el hijo de la paciente , se informa que el mismo se presentó en forma agresiva el día 28 de Febrero en la Unidad 4 con improperios , me presento ante el preguntándole que era lo que necesitaba , respondiendo el mismo que la madre no era atendida y que solicitaba copia de la historia clínica , se le explico que la misma no podía ser entregada desde el servicio a el ya que la paciente se encontraba internada y a espera de derivación a III nivel por la Obra social Pami (NO INICIADA EL HIJO NO SE PRESENTO A FIRMAR EL PEDIDO) y que le ofrecía un resumen de la situación actual de la misma .

La paciente tiene diagnóstico de Deterioro cognitivo severo con un AVD 0/6 , postrada , antecedentes de gastritis crónica previa a la internación en tratamiento con Ranitidina (fármaco que recibía antes del ingreso) , TVP no controlada decidiéndose riego beneficio la suspensión de la misma además de no tener indicación dado el tiempo transcurrida de la misma , Ingresa al Servicio de Clínica Medica el 23/1 con Diagnostico de Neumonía de probable mecanismo espirativo , cumple tratamiento para tal fin , encontrándose de alta al día de la fecha , dado la imposibilidad de retorno al domicilio por Causa Social , permanece en la Unidad 4 Cama 4 con aislamiento de contacto por KPC en día 42 de internación . En relación al dolor anal que manifiesta, la paciente se encuentra postrada con medidas anti escaras, colchón de aire, rotación, no presentando UPP hasta el día de la fecha, actualmente con dermatitis del pañal tratada e Interconsultada a Dermatología en tratamiento con cremas con esteroides.

Por ultimo cabe mencionar que la paciente se encuentra la mayor parte del día sin compañía de su hijo, ni aun en los horarios alimentación (desayuno, almuerzo, merienda y cena) cumplimentando muchas veces esa tarea el personal de salud de la sala, asimismo cuando concurre siempre con conductas agresivas hacia el personal, medicando a la paciente por su cuenta y exigiendo cosas como las que manifiesta en la nota presentada.

Sin más saludo atentamente y a disposición a lo que se solicita a dicha Unidad de Internación Clínica.

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M.N. 96674
HOSP. GRAL. AGUDOS P. PIÑERO

Daniel Kaiup 4/3/2020

22

Buenos Aires, 04 de Marzo de 2020

A Dirección Hospital Piñero

Dr. Daniel Rivero

Asunto : Respuesta reclamo Paciente Kuchasky Margarita

En relación a la nota presentada por el hijo de la paciente , se informa que el mismo se presentó en forma agresiva el día 28 de Febrero en la Unidad 4 con improperios , me presento ante el preguntándole que era lo que necesitaba , respondiendo el mismo que la madre no era atendida y que solicitaba copia de la historia clínica , se le explico que la misma no podía ser entregada desde el servicio a el ya que la paciente se encontraba internada y a espera de derivación a III nivel por la Obra social Pami (NO INICIADA EL HIJO NO SE PRESENTO A FIRMAR EL PEDIDO) y que le ofrecía un resumen de la situación actual de la misma .

La paciente tiene diagnóstico de Deterioro cognitivo severo con un AVD 0/6 , postrada , antecedentes de gastritis crónica previa a la internación en tratamiento con Ranitidina (fármaco que recibía antes del ingreso) , TVP no controlada decidiéndose riego beneficio la suspensión de la misma además de no tener indicación dado el tiempo transcurrida de la misma , Ingresa al Servicio de Clínica Medica el 23/1 con Diagnostico de Neumonía de probable mecanismo espirativo , cumple tratamiento para tal fin , encontrándose de alta al día de la fecha , dado la imposibilidad de retorno al domicilio por Causa Social , permanece en la Unidad 4 Cama 4 con aislamiento de contacto por KPC en día 42 de internación . En relación al dolor anal que manifiesta, la paciente se encuentra postrada con medidas anti escaras, colchón de aire, rotación, no presentando UPP hasta el día de la fecha, actualmente con dermatitis del pañal tratada e Interconsultada a Dermatología en tratamiento con cremas con esteroides.

Por ultimo cabe mencionar que la paciente se encuentra la mayor parte del día sin compañía de su hijo, ni aun en los horarios alimentación (desayuno, almuerzo, merienda y cena) cumplimentando muchas veces esa tarea el personal de salud de la sala, asimismo cuando concurre siempre con conductas agresivas hacia el personal, medicando a la paciente por su cuenta y exigiendo cosas como las que manifiesta en la nota presentada.

Sin más saludo atentamente y a disposición a lo que se solicita a dicha Unidad de Internación Clínica.

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M.N. 86674
HOSP. GRAL. AGUDOS P. PIÑERO

PAMI
INSSJP

287537

23

U. A. DR. CESAR MILSTEIN	APELLIDO Y NOMBRES **KUCHASKY MARGARITA** PAMI - 150143040501-00

Datos Personales

Fecha de Nacimiento: **12/05/1943**
Sexo: **FEMENINO**
Identificación Estado Civil: **CASADO**

Documento: **Libreta Cívica 04214110**
Contactar Nacionalidad: **ARGENTINA**

Domicilio: **MOZART 610**
(1407) CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL
Teléfonos: **46827559**
e-mail:

Impresión: 21/12/2016 13:18

Recuerde que toda Historia Clínica es un DOCUMENTO y por tal motivo NO DEBE ser retirado de esta Institución. Según Ley 26529 Art.18, este Instituto tiene a cargo su guarda y custodia.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

Identificación	**HC N° 416191**		**CAMA 04 INTERNACION**
Apellido y nombre	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**		
Sexo **Femenino**	Edad **años**		
Obra Social **PAMI**		Documento Tipo y Nro	**DNI 04214110**
Fecha de nacimiento	**5/12/1943**	Nacionalidad	**Argentina**
Domicilio		Teléfono	
Estado Civil			
Día de ingreso al hospital	**20/1/2020**		

MOTIVO DE INGRESO
DETERIORO COGNITIVO

ENFERMEDAD ACTUAL
PACIENTE DE 75 AÑOS CON ANTECEDENTES DE GASTRITIS, ANTICOAGULADA, ESQUIZOFRENICA,DETERIORO COGNITIVO CRONICO, ARTROSIS, TVP, ANTICOAGULADA EN TTO CON PANTUS, CALMADOR, SINTRON, QUETIAPINA, QUE INGRESA A GUARDIA ACOMPAÑADA POR HIJO POR PRESENTAR CUADRO CONFUSIONAL. FAMILIAR REFIERE QUE NO LA PUEDE CUIDAR. SE LE SOLCITA LABORATORIO COMPLETO, RX TORAX, TAC DE CEREBRO. FAMILIAR SE RETIRA, SIN DEJAR DATOS .

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:
DETERIORO COGNITIVO CRONICO

TRATAMIENTO:
DRA. BEUNZA, GRETEL (MEDICA CLINICA MN 113.040)

IDPACIENTE: 523073/IDG: 19303 20/1/2020 02:43:07

GRETEL A. BEUNZA
MEDICA
M. N. 113.040

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**		HC Nº	**402454**	
Fecha:	**20/1/2020**	Cama:	**3 INTERNACIO**	Días Int.	

DIAGNOSTICO:
DETERIORO COGNITIVO CRONICO

03:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: SE RECIBE LABORATORIO HTO 30, GB 5.22, HB 10, PLAQ 219, GL 96, UR 30, CREAT 0.81, RESTO HEMOLIZADA
SEDIMENTO URINARIO CELULAS ESCASAS CANTIDAD, LEUCO 2-3, HEMATIES 6-10
RX TORAX NO IMORESIONA INFILATRADDOS PATOLOGICOS
TAC D ECEREBRO LINEA MEDIA CENTRADA, NO IMPRESIONAN IMAGENES PATOLOGICAS
SELLO: DRA. BEUNZA, GRETEL (MEDICA CLINICA MN 113.040)

08:30 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: PACIENTE CON ANTECEDENTES DE TVP, ANTICOAGULADA, GASTRITIS CRONICA, ARTROSIS EN TTO CRONICO CON OMEPRAZOL, SINTRON, TRAMADOL, PREGABALINA QUE INGRESA A GUARDIA POR PRESENTRA PREOGRESION DE SU DETERIORO COGNITIVO. FAMILAIR REFIERE QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE BUSQUEDA DE GERITRICO POR PAMI.
SE HABLA TELEFONICAMENTE CON EL FAMILIAR QUIEN APORTA DATOS.
AL EXAMEN LA PACIENTE S ENCUENTRA VIGIL, ORIENTADA EN PERSONA, DESORIENTADA EN TIEMPO Y ESPACIO, NO COLABORA, SE QUIERE IR, SE LA ENCUENTRA INQUIETA, MOTIVO POR LOQ SE LA CONTIENE. BUENA MECANICA VENTILATORIA SIN RUIDOS AGREGADOS, ABDOMEN DEPRESIBLE INDOLORO. DIURESIS CONSERVADA POR SV.
SE SOLICITA LABORATORIO CONTROL E IC CON NEUROLOGIA
SE AGRGEA HALOPIDOL 0.5 CADA 8 HS
SELLO: DRA. BEUNZA, GRETEL (MEDICA CLINICA MN 113.040)

13:30 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: SE REIBE LABORATORIO HB 10.5, HTO 33.5, GB 7.8, PLAQ 198, RIN 7.96, KPTT 52, GL 101, UR 19, CRAET 0.63, TGO 25, TGP 15, FAL 91, BT 0.24, BD 0.1, NA 143, K 4.1
PACIENTE ANTICOAGULADA , FUERA DE RANGO, SIN SIGNOS DE SANGRADO, SE AGREGA VIT K
SELLO: DRA. BEUNZA, GRETEL (MEDICA CLINICA MN 113.040)

IDPTE506485IDG19303 IMPRESO EL 20/1/2020 15:57:34

GRETEL A. BEUNZA
MEDICA
M. N. 113.040

28

ANEXO V

Consentimiento Informado para uso de documentación de medios en el marco de la Ley 2908

Efector: Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero"

Nombre y apellido del paciente:

KUCHASKY, MARGARITA LEONOR

Exhibe documento acreditativo de identidad **SI - NO** (tachar lo que no corresponda)

Tipo: DNI **N°:** 04214110

Ente de Cobertura de Salud al que manifiesta afiliación:

PAMI

N° de afiliado:

Acompaña fotocopia credencial **SI - NO**

Quien suscribe

en su carácter de afiliado a **PAMI**

manifiesta por medio de la presente su expresa conformidad con el uso de antecedentes médicos que obraren en el Efector, estudios realizados y toda otra documentación relacionada con las prestaciones realizadas a los únicos fines de obtener el reintegro de los gastos por parte del ente de cobertura de salud que corresponda.

SI - NO (Tachar lo que no corresponda)

FIRMA:

ACLARACIÓN:

FECHA:

NOTA: Si el que suscribe es representante legal completar:

Nombre y apellido del que suscribe:

Tipo de representación (madre, padre, tutor, curador, etc.):

En caso de tratarse de tutores/curadores especificar carátula del expediente judicial donde se dirimió la tutela/curatela y juzgado actuante:

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

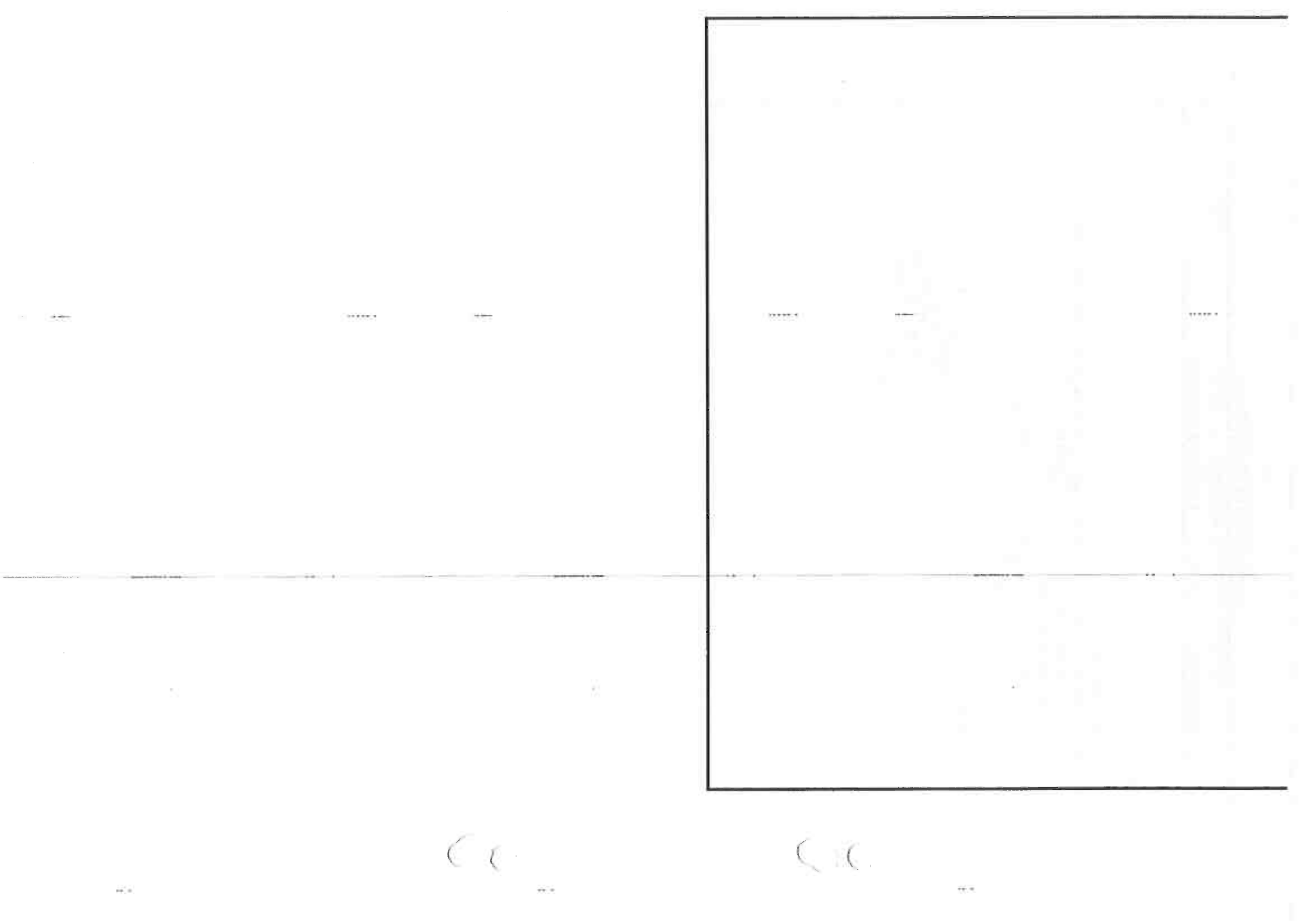
Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**		HC Nº		**416191**
Fecha:	**20/1/2020**	Cama:	**1 INTERNACIO** Días Int.		

DIAGNOSTICO:
DETERIORO COGNITIVO CRONICO

03:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: SE RECIBE LABORATORIO HTO 30, GB 5.22, HB 10, ´PLAQ 219, GL 96, UR 30, CREAT 0.81, RESTO HEMOLIZADA
SEDIMENTO URINARIO CELULAS ESCASAS CANTIDAD, LEUCO 2-3, HEMATIES 6-10
RX TORAX NO IMORESIONA INFILATRADDOS PATOLOGICOS
TAC D ECEREBRO LINEA MEDIA CENTRADA, NO IMPRESIONAN IMAGENES PATOLOGICAS
SELLO: DRA. BEUNZA, GRETEL (MEDICA CLINICA MN 113.040)

IDPTE523073IDG19303 IMPRESO EL 20/1/2020 02:42:08

GRETEL A. BEUNZA
MEDICA
M. N. 113.040



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**		HC Nº	**402454**
Fecha:	**20/1/2020**	Cama:	**3 INTERNACIO**	Días Int.	

DIAGNOSTICO:
MEG + deshidratación

21:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: Paciente de sexo femenino de 75 años de edad con antecedentes de gastritis, TVP, anticoagulada (actualmente RIN 8), esquizofrenia, deterioro cognitivo crónico, artrosis; que cursa internación por MEG + deshidratación.
Al examen físico: CSV: TA: 140/70 mmHg, FC: 95 lpm, SatO2: 95% al 0.21, afebril. Alerta, poco colaboradora, obedece órdenes simples, pupilas isocóricas y reactivas, moviliza 4 miembros, foco neurológico inevaluable. Aceptable mecánica ventilatoria, hipoventilación bibasal, escasos roncus. R1 y R2 en 4 focos, sin edemas periféricos, sin signos de falla aguda de bomba. Abdomen blando, depresible e indoloro, RHA +. Sin signos de sangrado agudo. Pequeños hematomas en miembros. Diuresis parcial por sonda vesical: 500ml en 6 hrs.
Continua control evolutivo.
SELLO: DRA. SAMANTHA PAGANELLI MEDICO DE GUARDIA MN 144956

IDPTE506485IDG19303 IMPRESO EL 21/1/2020 12:48:23

Samantha Paganelli
MÉDICA - U.B.A
M.N. 144.956

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	21/1/2020	Cama:	3 INTERNACIO Días Int.

DIAGNOSTICO:
DETERIORO COGNITIVO CRONICO

06:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: Paciente evoluciona clínica y hemodinámicamente estable, sin intercurrencias durante la noche.
Control evolutivo.
SELLO: DRA. SAMANTHA PAGANELLI MEDICO DE GUARDIA MN 144956

IDPTE506485IDG19303 IMPRESO EL 21/1/2020 07:07:02

Samantha A. Paganelli
MEDICA - U.B.A.
M.N. 144.956

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	HC Nº	402454
Fecha:	21/1/2020	Cama:	3 INTERNACIO Días Int.

DIAGNOSTICO:
MEG + deshidratación

09:30 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: Paciente de sexo femenino de 75 años de edad con antecedentes de gastritis, TVP, anticoagulada, esquizofrenia, deterioro cognitivo crónico, artrosis; que cursa internación por MEG.
Al examen físico: CSV: TA: 110/70 mmHg, FC: 75 lpm, SatO2: 92% al 0.21, 97% con máscara reservorio, afebril. Piel y mucosas secas. Alerta, poco colaboradora, obedece órdenes simples, pupilas isocóricas y reactivas, moviliza 4 miembros, foco neurológico inevaluable. Aceptable mecánica ventilatoria, hipoventilación bibasal, roncus generalizados. R1 y R2 en 4 focos, sin edemas periféricos, sin signos de falla aguda de bomba. Abdomen blando, depresible e indoloro, RHA +. Sin signos de sangrado agudo. Pequeños hematomas en miembros. Diuresis positiva por sonda vesical.
Se solicita laboratorio con EAB. Se realiza HMC x2. Se solicita TAC de torax.
Continua control evolutivo.
SELLO: DRA. SAMANTHA PAGANELLI MEDICO DE GUARDIA MN 144956

Samantha Paganelli
MÉDICA - U.B.A
M.N. 144.956

12:00 ESPECIALIDAD: CLINICA MEDICA
EVOLUCION: Se recibe EAB:
PH: 7.42, PCO2: 39.0, PO2: 72.2, CHCO3: 25, EB: 0.7, SO2: 94.7%, Ac. Láctico: 1.75
Se realiza TAC de tórax que evidencia escaso derrame pleural bilateral.
Se decide iniciar tto ATB empírico.
SELLO: DRA. SAMANTHA PAGANELLI MEDICO DE GUARDIA MN 144956

IDPTE50648SIDG19303 IMPRESO EL 21/1/2020 12:49:56

Samantha Paganelli
MÉDICA - U.B.A
M.N. 144.956

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

(34)

Identificación	HC N° 402454	UNIDAD 4	CAMA 4
Apellido y nombre	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR		
Sexo **Femenino**	Edad **62 años**	Reingreso **NO**	
Obra Social **PAMI**		Documento Tipo y Nro	**DNI 4214110**
Fecha de nacimiento	**5/12/1943**	Nacionalidad	**Argentina**
Domicilio **MOZART 610**		Teléfono	**46827559**
Estado Civil			
Día de ingreso al hospital		Día de ingreso al servicio	**22/01/2020**

MOTIVO DE INGRESO:
sindrome confusional

ENFERMEDAD ACTUAL:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP anticoagulada con sintron, deterioro cognitivo, gastritis crónica, esquizofrenia. Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.
Ingresa a guardia externa el 20/01, traída desde su domicilio acompañada por familiar por presentar un síndrome confusional hipoactivo.
Familiar refiere no poder hacerse cargo del cuidado de su madre, por lo que se encuentra en búsqueda de un geriátrico por PAMI para un tercer nivel. El cual se retira de la institución sin dejar datos de contacto.
A du ingreso se la constata vigil con orientación solo en persona, no se encuentra en historia clínica signos vitales al ingreso a guardia. El resto del examen físico sin particularidades.
Se realiza laboratorio que informa anemia sin criterios de transfusión (hto 33.2 y hb 10.5), alteración del coagulograma con rin 7.96 y kptt 52, por lo que se indica vitamina k, con un sedimento urinario no inflamatorio, se realiza rx de tórax sin infiltrados patológicos, tac de cerebro sin signos de sangrado agudo. No cuenta con ECG.
Evoluciona hemodinamicamente estable y afebril, con hipoventilacion generalizada a la auscultación acompañado de roncus, con ritmo diurético conservado.
El 21/01 evoluciona con roncus generalizados, desaturando al aire ambiente (92%) mejorando con máscara de reservorio (97%), se realiza EAB (se desconoce Fio): 7.42/39/ 72.2/25/0.7/94%/ láctico 1.74, se indica realización de TAC de tórax donde se observa infiltrados intersticiales bilaterales.
Se interpreta el cuadro como una neumonía adquirida de la comunidad, se toman HMC x2 y se inicia tratamiento empírico con AMS.

OTROS:
Hematológicos/Reumatológicos/Psiquiátricos

ALERGIAS:
se desconce

INTERNACIONES PREVIAS:
se desconoce

CIRUGÍAS PREVIAS:
se desconce

ALCOHOL Tipo: se desconoce - Cantidad: - Tiempo de evolución:
DROGAS Tipo: se desconoce - Cantidad: - Tiempo de evolución:
DROGAS Tipo: se desconoce - Cantidad: - Tiempo de evolución:

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
LUGAR DE NACIMIENTO: Argentina PROFESIÓN: se desconoce ESCOLARIDAD: se desconoce VIVIENDA: se desconoce

EXAMEN FÍSICO
PRIMERA IMPRESION: regular estado general ACTITUD: compuesta DECÚBITO: preferencial ESTADO DE HIDRATACIÓN: deshidratada
ESTADO DE NUTRICIÓN: normonutrida PESO: TALLA: BMI: ACCESO VENOSO: periferico SONDA VESICAL: si

SIGNOS VITALES:
TA: 120-70 FC: 82 FR: 18 TC: 36.7 SAT: 92% (0.21) 98 %(cn) ORTATISMO: DIURESIS: conservada por sonda vesical PVC:

SENSORIO:
vigil, orientada en personsa, desorientada en tiempo y espacio

PIEL Y FANERAS:
COLOR: caucasica LESIONES CUTÁNEAS: cicatriz mediana en abdomen VELLO: lampiña ESCARAS: No

SISTEMA VENOSO:
TRAYECTOS VARICOSOS: No HOMANS: No

CABEZA:
TIPO: Normocéfalo CAVIDAD ORAL: mucosas secas DIENTES: Regular estado de conservacion, uso de protesis dentaria

CUELLO:
FORMA: Cilíndrico SIMETRÍA: No TIROIDES: No se palpa

SISTEMA CARDIOVASCULAR
INSPECCIÓN/PERFUSIÓN: Bien perfundida, dos ruidos en cuatro focos, silencios impresionan libres, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decúbito y sin signos de falla aguda de bomba
PALPACIÓN:
PERCUSIÓN:
AUSCULTACION:
SOPLOS:
AUSCULTACIÓN DE CARÓTIDAS:
CARACTERÍSTICAS DEL RADIAL:
PULSOS PERIFÉRICOS
BRAQUIAL DE BRAQUIAL IZ
RADIAL DE RADIAL IZ
FEMORAL DE FEMORAL IZ
POPLÍTEO DE POPLÍTEO IZ
TIBIAL POST DE TIBIAL POST IZ
PEDIO DE PEDIO IZ
MANEJO DE LÍQUIDOS: TOLERA DECÚBIRO: YUGULARES: EDEMAS PERIFÉRICOS:

APARATO RESPIRATORIO
INSPECCIÓN: Buena mecánica ventilatoria, hipoventilacion generalizad por falta de colaboración de la paciente acompañada de escasos crepitantes bibasales y roncus altos.
PALPACIÓN: EXPANSIÓN DE VÉRTICES: VIBRACIONES VOCALES:
PERCUSIÓN: TORAX: COLUMNA:
AUSCULTACIÓN: MURMULLO VESICULAR: RUIDOS AGREGADOS: PECTORILOQUIA:

MAMAS:

ABDOMEN
CATARSIS/RITMO EVACUATORIO:
FORMA: SIMETRÍA: CICATRICES: HERNIAS: CIRCULACIÓN COLATERAL:
PALPACIÓN: SUPERFICIAL: PROFUNDA: HÍGADO: Abdomen globoso, blando, depresible, indoloro a la palpación superficial y profunda, sin defensa ni reacción peritoneal, RHA conservados, catarsis positiva del día de la fecha BAZO
PERCUSIÓN: TRAUBE: ONDA ASCÍTICA: MATIDEZ DESPLAZABLE:
AUSCULTACIÓN DE RHA: TACTO RECTAL:

APARATO GENITOURINARIO
GENITO RENAL: No se palpan PUÑO PERCUSIÓN LUMBAR: Negativo PUNTOS URETRALES: Negativos GENITALES: Normales

SISTEMA LINFOGANGLIONAR
CERVICAL DERECHO: No CERVICAL IZQUIERDO: No
SUPRACLAVICULAR DERECHO: No SUPRACLAVICULAR IZQUIERDO: No
INFRACLAVICULAR DERECHO: No INFRACLAVICULAR IZQUIERDO: No
AXILAR DERECHO: No AXILAR IZQUIERDO: No
EPITOCLEAR DERECHO: No EPITOCLEAR IZQUIERDO: No
INGUINAL DERECHO: No INGUINAL IZQUIERDO: No

SISTEMA NERVIOSO
GLASGOW APERTURA OCULAR: Espontánea(4) RESPUESTA VERBAL: Orientado(5) RESPUESTA MOTORA: Orientado(5) PUNTAJE: 15/15
RESPUESTA A COMANDOS: Si a los 3 comandos LENGUAJE: Conservado y coherente SISTEMA MOTOR: S/p SIGNOS MENÍNGEOS: No
MARCHA: Conservada PUPILAS: Normoisocóricas reactivas MOTILIDAD OCULAR: Extrínseca e intrínseca SENSIBILIDAD: Conservada
REFLEJOS: Conservado OTROS SIGNOS NEUROLÓGICOS: vigil, pupilas isocoricas reactivas, moviliza los cuatro miembros, sins ignos de foco motor agudo ni meningeo

SISTEMA OSTEOARTICULOMUSCULAR
MOTILIDAD: Conservada EXTREMIDADES: S/p COLUMNA: Normal ARTICULACIONES: S/p FUERZA Y TONO MUSCULAR: S/p TROFISMO: S/p

ESTUDIOS REALIZADOS
RX DE TORAX:
No rotulada.
De frente, incompleta, rotada, descentrada, índice cardiotorácico conservado con botón aórtico prominente, senos costo y cardiofrenicos derechos e izquierdo velados, a nivel del parénquima pulmonar presenta infiltrado en base izquierda

OTROS ESTUDIOS:
TAC DE CEREBRO: de corte axial con integridad ósea, línea media centrada, glándula pineal y plexos coroideos clacificados, sin ventriculomegalia, sin signos de sangrado actico

TAC DE TORAX: presenta infartados intersticiales bilaterales

ECG:
Ritmo: regular sinusal Frecuencia: 80 Eje: +30 P: 0.08 PR: 0.12 QRS: 0.12 ST: isonivelado T: sin particularidades Q: QT: QTc: Extrasístoles: no Progresión: regular Conclusiones: ecg sin valor patologico

LABORATORIO:
Hto= 28.6 Hb= 9 GB= 8380 Plaquetas= 160.800 RIN= 1.51 KPTT= 30 Glucemia= 103 Urea= 18 Creatinina= 0.50 TGO= 23 TGP= 15 Fosfatasa alcalina= 73 Bilirrubina total= 0.41 Bilirrubina directa= 0.17 Na Sérico= 141 K Sérico= 3.8 Otros= cloro 104/ lactico 1.41 EAB: Ph = 7.39 PCO2= 41.2 PO2= 77 HCO3= 24.5 EB= -0.4 Sao2= 96

INTERPRETACION DIAGNÓSTICA:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

INDICACIONES:
1) CONTROL DE SIGNOS VITALES POR TURNO
2) CONTROL DE DIURESIS POR SONDA VESICAL
3) PHP A 21 GOTAS X MINUTO ALTERNO Y SUPLEMENTADO FRASCO N° 1,3 CON SF + 2 AMPOLLAS CL K Y FRASCO N° 2 CON DX AL 5% + 2 AMPOLLAS SOMG
4) DIETA GENERAL, BIEN SENTADA ASISTIDA, A 90°
5) CABECERA A 45º
6) OMEPRAZOL DE 20 MG CÀPSULA CADA 24 HORAS VÍA ORAL (8 HS)
7) HEPARINA SODICA DE 5.000 U/ML INYECTABLE X 5 ML CADA 12 HORAS VÍA SUBCUTÁNEA (8 HS 20 HS)
8) CONTROL DE GLUCEMIA CADA PRE DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-CENA SIN CORRECCIÓN AVISAR AL MÉDICO SI SI EL VALOR ES < 80 O > 300
9) OXIGENOTERAPIA: CÁNULA NASAL
10) NEBULIZACION CADA 8 HORAS CON 3 CC DE SOLUCION FISIOLOGICA MAS 20 GOTAS DEL SALBUTAMOL Y 40 GOTAS DE BROMURO DE IPATROPIO
11) AMPICILINA + SULBACTAM1.5 GR CADA 6 HORAS VÍA ENDOVENOSA (6 HS 12 HS 18 HS 24 HS) DIA N° 2
12) QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO CADA 24 HORAS VIA ORAL (22 HS)

EVOLUCIÓN POR GUARDIA:

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	23/01/2020	Cama:	4	Días Int.	1

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
23/1/2020:
dia 1 de internacion en Clinica Medica
Dia 2 de ATB: AMS por NAC de probable mecanismo aspirativo
Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC a probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.
EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 130/70 mmHg, FC 71 FR 20 T° 36.5 SAT 99 (con canuma nasal) Diuresis 300 ml en 3 hs.
N: Vigil, atenta, orientada en persona, desorientada en tiempo y espacio, responde ordenes simples, moviliza 4 miembros en cama, sin foco motor ni meningeo.
A: Globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de caracteristicas normales.
C: 2r en 4 focos, SS 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas ni otro signo de falla cardiaca.
R: Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, escasos crepitantes a predominio basal. Torax y columna sonoras.
OA: Pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII. Pre escara en talon izquierdo.
COMENTARIOS:
1. Paciente que cursa internacion en clinica medica por NAC en conetexto de sindrome demencial con elevado riesgo social.
2. Se realiza entrevista con hijo (Nicolas Horacio) quien aporta datos de antecedentes previos de la paciente y refiere que no cuenta con los recursos para el cuidado de su madre. Por lo antes descripto, se solicita Interconsuta con Servicio Social (PAMI) a fin de realizar tramites de derivacion a tercer nivel una vez resuelto el motivo clinico de internacion.
3. PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo.
* TAC Torax (realizada, pendiente informe)
* Ecocardiograma
* Interconsulta con Geriatria (se aguarda evaluacion)
* Interconsulta con T. Social (PAMI) (realizada)
* Completar esquema antibiotico
* Seguimiento de cultivos (HMC X2, realizados por guardia el dia 20/1/2020)

DRA. SANDRA KRAUS MEDICA PLANTA C.MEDICA MN 110169

iDPTE506485IDCM7135IDCMED110654 IMPRESO EL 23/1/2020 11:50:21

Sandra Kraus
Médica (U.B.A.)
Especialista en Clínica Interna
M.N. 110.169

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**		HC Nº	**402454**
Fecha:	**24/1/2020**	Cama: **4**	Días Int.	**2**

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION EN SALA DE CLINICA MEDICA: 2
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 0

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 120-70/ 83/20/37.6/ 95% (CN)
Diuresis 200 ml en 6 hs

N: Somnolienta, responde al llamado con apertura ocular, no impresiona foco motor ni meningeo.
C: regular perfusion por ritmo diuretico disminuido, 2r en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
R: Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, escasos crepitantes a predominio basal. Torax y columna C: reforas.
A: Globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de caracteristicas normales.
OA: Pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII. Pre escara en talon izquierdo.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y febril que cursa internacion en clinica medica por NAC en conetexto de sindrome demencial con elevado riesgo social.
*se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 23/01/2020
Hto= coagulada Hemo= coagulado Bcos= coagulado Plaq= coagulado KPTT= 24 RIN= 1.15 Fibrin= 637 Gluc= 87 Urea= 14 Creat= 0.52 Colest= 153 LDH= 60 HDL= 66 Prot= 5.2 Albu= 2.9 Bili= 0.42 Bili.Di= 0.20 Bili.In= 0.22 F.Alca= 73 TGO= 20 TGP= 16 Calc= 8 Fosfat= 2.2 Magne= 1.86 Otros= Na= 146 Ka= 3.4 Cloro= 108 HbsAg= nr HCV= nr Chagas= nr VDRL= nr Toxo= nr VIH= nr T4= 1.20 TSH= 3.14 Observaciones= pcr: 148/ ferremia 40/ transferrina 157/ % transferrina157/ vit b12: 465.10/ folico: 16.58
*Por presentar deterioro del sensorio se realiza HMGT 138 y flumazenil positivo registro subfebril, ritmo diuretico disminuido se inicia expansion con cristaloides con una respuesta de 500 ml 1 h con una diuresis parcial 700 ml en 8 hs con balance positivo, se decide realizar HMCx2 , tomar urocultivo con recambio de sonda vesical y escalar esquema antibiotico con PTZ ajustado a funcion renal.
*Se repite laboratorio con EAB: LABORATORIO DEL DÍA: 24/01/2020
Hto= 24.5 Hemo= 8.2 Bcos= 6170 Plaq= 76.300 Otros= Ph= 7.37 PCO2= 43 HCO3= 24.7 BE= -0.5 Observaciones= lactico 0.93
*Se deja laboratorio de central
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Continua control evolutivo por clinica medica

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	30/1/2020	Cama:	4	Días Int.	8

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
30/1/2020:
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 3
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (27/01): 4
Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 140-80/ FC 78/FR 18/ T 36.6/ SAT 96% (0.21)
Diuresis 500 ml en 5 hs con balance positivo 200 ML
PVC= 5 cm
n:N:Atenta. Vigil con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
C: Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Sopio Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
R: Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de características normales.
Piel y ptes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII. Pre escara en talon izquierdo.
Acceso venoso central, sin signos de flogosis

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por NAC de probable mecanismo aspitativo en contexto de sindrome demencial con elevado riesgo social, en tratamiento con PTZ (en dia 3).
*Sin familiar presente al momento del parte medico
*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
* TAC Torax (21/01) (realizada, pendiente informe)
*TAC de cerebro (20/01) (realizada con informe adjunto)
* Ecocardiograma (03/02)
* Interconsulta con Geriatria (se aguarda evaluacion)
* Interconsulta con T. Social (PAMI) (realizada)

SEGUIMIENTO DE CULTIVOS
HMC X2 (20/01): negativo a la fecha
HMC (24/01): negativo a la fecha

UC (24/01): fpm

DRA. SANDRA KRAUS MEDICA PLANTA C.MEDICA MN 110169

IDPTE506485IDCM7135IDCMED110964 IMPRESO EL 30/1/2020 12:46:42



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**31/1/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**9**

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 9
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 4
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (27/01): 4

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia nica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
SFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 120-70/ FC 83/FR 18/ T 37.3/ SAT 97% (0.21)
Diuresis 400 ml en 3 hs con balance neutro
PVC= 5 cm

n:N:Atenta. Vigil con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
C: Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin ujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
A: Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de caracteristicas normales.
Piel y ptes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII. Pre escara en talon izquierdo.
Acceso venoso central, sin signos de flogosis

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por NAC de probable mecanismo aspitativo en contexto de sindrome demencial con elevado riesgo social, en tratamiento con PTZ (en dia 4).
*Por presentar registros subfebriles en forma aislada sin foco aparente con un urocultivo con FPM, se indica recambio de sonda con toma de urocultivo
*Se espera resultado de labroatorio de central
*Con familiar presente al momento del parte medico
*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con urologico, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo (realizado)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**03/02/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**12**

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 12
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 0, por rescate en urocultivo de EVR
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (27/01): 6, se la autoretira el 01/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 120-70/ FC 80/FR 18/ T 37/ SAT 97% (0.21)
Diuresis 200 ml en 3 hs con balance 200 positivo

Vigil, atenta con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de caracteristicas normales.
Piel y ptes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII. Pre

COMENTARIOS:
Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por NAC de probable mecanismo aspirativo en contexto de sindrome demencial con elevado riesgo social, en tratamiento con PTZ (en dia 7) ya finalizado.
En el dia de la fecha, por continuar subfebril con tratamiento suboptimo por perdida de accesos y con rescate de urocultivo de EVR ingresado el dia viernes 29/01 , inicia tratamiento con linezolid (dia 0), se ingresan HMC x2.
*Se solicita colocacion de acceso venoso central por parte de servicio de cirugia, se firma consentimiento infomado y se adjunta en ultimo laboratorio y orden de placa de rx torax control.
*Se espera resultado de labroatorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 31/01/2020
Hto= 26.6 Hemo= 8.5 Bcos= 6110 Plaq= 341.000 KPTT= 25 RIN= 1.26 Fibrin= 717 Gluc= 99 Urea= 7 Creat= 0.41 Colest= 168 Prot= 5 Albu= 2.8 Bili= 0.36 Bili.Di= 0.21 Bili.In= 0.15 F.Alca= 85 TGO= 29 TGP= 32 Calc= 8 Fosfat= 2.3 Magne= 1.49 Otros= Na= 142 Ka= 3.1 Cloro= 103 Eritro= 86 Observaciones= PCR : 154
*Se recibe informe de TAC de torax: NO SE OBSERVAN ADENOMEGALIAS AXIALES. HILIARES NI MEDIASTINALES. MEDIASTINO CENTRADO. DE CONFIGURACION VASCULAR HABITUAL. AREA CARDIACA CONSERVADA. NO SE OBSERVA DERRAME PERICARDICO. VOLUMINOS HERNIA HIATAL. ESCASO DERRAME PLEURAL IZQUIERDO LAMINAR. LOS CORTES CON VENTANA DE PULMON MUESTRAN OPACIDADES SUBPLEURALES Y ACENTUACION DE LA TRAMA INTERSTICIAL A NIVEL DE LOS SEGMENTOS POSTERIORES DE AMBOS LOBULOS INFERIORES. DE PROBABLE ORIGEN PASIVO CONGESTIVO. ABDOMEN SUPERIOR SIN PARTICULARIDADES
*Sinn familiar presente al momento del parte medico
*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
* TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)
*TAC de cerebro (20/01) (realizada con informe adjunto)
* Ecocardiograma (pendiente turno)
* Interconsulta con Geriatria (se aguarda evaluacion)
* Interconsulta con T. Social (PAMI) (realizada)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**04/02/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**13**

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 13
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 1, por rescate en urocultivo de EVR
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 1

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TEP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 130-70/ FC 79/FR 18/ T 36/ SAT 95% (0.21)
Diuresis: 300 ml en 4 horas con balance positivo 100
Catarsis positiva del dia de la fecha
PVC= 5

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias, catarsis positiva de caracteristicas normales.
Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid (hoy dia 1), con HMC negativos a la fecha
*Se coloca acceso venoso central (yugular posterior izquierdo) en quirofano por parte del servicio de cirugia. Se realiza en clinica medica, rx de torax control sin presencia de neumotorax.
*Sin familiar presente al momento del parte medico
*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**05/02/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**14**

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 14
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 2, por rescate en urocultivo de EVR
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 2

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TEP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 120-70/ FC 70/FR 17/ T 35.7/ SAT 95% (0.21)
Diuresis: 200 ml en 3 horas con balance positivo 200
Catarsis positiva del dia de la fecha
PVC= 4

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Buen perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid (hoy dia 2), con HMC negativos a la fech
*Sin familiar presente al momento del parte medico
*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

(46)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

INTERCONSULTA

PACIENTE KUCHASKY, MARGARITA LEONOR **HC Nº** 402454

FECHA **06/02/2020**

SERVICIO QUE SOLICITA UNIDAD 4 DE CLINICA MEDICA

SERVICIO QUE REALIZA Unidad de Geriatria (Cantale, Vicente, El Hage)

INTERCONSULTA

A pedido de medico tratante se evalua a la pte, quien se encuentra cursando internacion por NAC con multiples intercurrencias infectologicas. Quien dado los antecedentes personales, situacion social y estado actual se considera la institucionalizacioon posterior al alta en residencia de larga estancia, solicitando dicha prestacion a PAMI.

Segun la valoracion geriatrica integral se concluye en que se trata de un "Anciano Geriatrico", con Trastorno neurocognitivo mayor, con compromiso de todos los dominios cognitivos, mas dependencia total para las ABVD e Inst. Riesgo social elevado. Multiples sindromes geriatricos: Icompetencia intelectual, Inmovilidad, Incontinencia, malnutricion.

Se consensua con medico tratante en continuar con el pedido de tercer nivel a PAMI

Claudio El Hage
Médico UNLP
MN 126.905

DRA. VICENTE MASANES FRANCISCA
MÉDICA
MN 124347

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	6/2/2020	Cama:	4	Días Int.	15

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 15
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 3, por rescate en urocultivo de EVR
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 3

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TEP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 130-70/ FC 83/FR 17/ T 36.7/ SAT 95% (0.21)
Diuresis: 300 ml en 34 horas con balance positivo 200
Catarsis positiva del dia de la fecha
PVC= 6

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Mucosas perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid (hoy dia 3), con HMC negativos a la fecha.
*Sin familiar presente al momento del parte medico
*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
* TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)
*TAC de cerebro (20/01) (realizada con informe adjunto)
* Ecocardiograma (pendiente turno)
* Interconsulta con Geriatria (se aguarda evaluacion)
* Interconsulta con T. Social (PAMI) (realizada)
*PPD (pendiente)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

SEGUIMIENTO DE CULTIVOS

48

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	07/02/2020	Cama:	4	Días Int.	16

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 16
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 6, por rescate en urocultivo de EVR
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 4

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 130-70/ FC 80/FR 17/ T 36.5/ SAT 96% (0.21)
Diuresis: 400 ml en 4 horas con balance positivo 100
Catarsis positiva del dia de la fecha

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida. 2 ruidos en 4 focos, Sopio Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid (hoy dia 4), con HMC negativos a la fecha.
*Se solicita laboratorio de central
*Pendiente programacion de turno para ecocardiograma.
*Sin familiar presente al momento del parte medico
*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologías, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
* TAC Toraxl 21/01 (realizada con informe adjunto)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	10/02/2020	Cama:	4	Días Int.	19

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 19
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR (hoy ultimo dia de tratamiento)
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 7

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
tercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y
cultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde
escata EVR sensible a linezolid.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 110-80/ FC 70/FR 17/ T 35.7/ SAT 96% (0.21)
Diuresis: 300 ml en 4 horas con balance positivo 100
rsis negativa de 24 hs

gil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.
Acceso venoso central sin signos de flogosis.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid (hoy dia 7), con HMC negativos a la fecha, siendo hoy ultimo dia de tratamiento.
*Se espera resultado de laboratorio.
*Sin familiar presente al momento del parte medico
*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
* TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**11/02/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**20**

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 20
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 8

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

TERCURRENCIAS:
tercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
TA: 110-60/ FC 81/FR 17/ T 36.4/ SAT 96% (0.21)
Diuresis: 400 ml en 4 horas con balance positivo 200
Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.
Acceso venoso central sin signos de flogosis.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid finazilado.
*Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 10/02/2020
Hto= 32.3 Hemo= 10.3 Bcos= 4450 Plaq= 213.000 KPTT= 31 RIN= 1.14 Fibrin= 441 Gluc= 157 Urea= 8 Creat= 0.57 Colest= 172 Prot= 6 Albu= 3.3 Bili= 0.31 Bili.Di= 0.16 Bili.In= 0.15 F.Alca= 84 TGO= 15 TGP= 22 Calc= 8.8 Fosfat= 2.7 Magne= 1.64 Otros= Na= 137 Ka= 3.8 Cloro= 102
*Sin familiar presente al momento del parte medico
*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
* TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**12/02/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**21**

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 21
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO (04/02): 9, se retira el 12/02

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde escata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 120-60/ FC 74/FR 17/ T 35.8/ SAT 97% (0.21)
Diuresis: 300 ml en 4 horas con balance positivo 200
Catarsis negativa de 24 hs

, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.
Acceso venoso central sin signos de flogosis.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril que cursa internacion en clinica medica por una infeccion del tracto urinario por un EVR sensible a linezolid finalizado.
*Se retira acceso venoso central (yugular posterior derecha), se indica continuar plan de hidratacion por via subcutanea.
*Sin familiar presente al momento del parte medico
*Continua control evolutivo por clinica medica, en espera de derivacion a tercer nivel (por PAMI). Papeles entregados.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
* TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	13/02/2020	Cama:	4	Días Int.	22

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 22
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde escata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 110-60/ FC 74/FR 17/ T 35.8/ SAT 97% (0.21)
Diuresis: 200 ml en 4 horas
Catarsis negativa de 24 hs

, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.
Acceso venoso central sin signos de flogosis.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Se hace entrega informe medico por parte del servicio de Geriatria a PAMI.
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Se actualizan indicaciones medicas.
*Continua control evolutivo por clinica medica.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**14/02/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**23**

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 23
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se escata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 120-60/ FC 75/FR 17/ T 35.9/ SAT 97% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Diarrsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.
Acceso venoso central sin signos de flogosis.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal de piernas y en axila derecha , se aplica crema con corticoides y acido fusidico, mejorando cuadro.
*Se solicita laboratorio de central.
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Continua control evolutivo por clinica medica.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
* TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)
*TAC de cerebro (20/01) (realizada con informe adjunto)

María Celeste Granja
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

(54)

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	17/02/2020	Cama:	4	Días Int.	26

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 26
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
TA: 130-60/ FC 81/FR 16/ T 36.3/ SAT 95% (0.21)
Diuresis consevada
Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.
Acceso venoso central sin signos de flogosis.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Se espera resultado de laboratorio de central.
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Continua control evolutivo por clinica medica.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
* TAC Torax (31/01) (realizada con informe adjunto)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	18/02/2020	Cama:	4	Días Int.	27

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 27
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clinica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde escata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

...errogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 120-70/ FC 83/FR 16/ T 36/ SAT 96% (0.21)
Diuresis consevada
Catarsis negativa de 24 hs

...il, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
...perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Piel y partes blandas: Presenta pie en valgo con deformidad de tarso, onicomicosis de uñas de MMII.
Acceso venoso central sin signos de flogosis.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Se recibe laboratorio de central:
LABORATORIO DEL DÍA: 17/02/2020
Hto= 29 Hemo= 9.2 Bcos= 5570 Plaq= 200.000 KPTT= 27 RIN= 1.17 Fibrin= 365 Gluc= 97 Urea= 21 Creat= 0.63 Colest= 161 Prot= 5.8 Albu= 3.3 Bili= 0.31 Bili.Di= 0.16 Bili.In= 0.15 F.Alca= 78 TGO= 18 TGP= 25 Calc= 8.7 Fosfat= 3.3 Magne= 1.83 Otros= Na= 146 Ka= 4.1 Cloro= 109 Eritro= 29 Observaciones= pcr 17
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Continua control evolutivo por clinica medica.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
* TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

T6

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	19/02/2020	Cama:	4	Días Int.	28

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 28
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
tercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y cultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
V: TA: 120-70/ FC 92/FR 16/ T 36/ SAT 9% (0.21)
esis consevada
tarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Continua control evolutivo por clinica medica.

PLAN DE ESTUDIO:
* Laboratorio completo con serologias, VDRL, perfil lipidico, Perfil tiroideo. (realizado)
* TAC Torax (21/01) (realizada con informe adjunto)

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

17

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	20/02/2020	Cama:	4	Días Int.	29

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 29
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

OTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
tercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
/: TA: 130-70/ FC 82/FR 16/ T 35.6/ SAT 97% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con leve mejoria
Presenta conjuntivis en ojo izquierdo con enrojecimiento y secrecion.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Presenta secrecion, enrojecimiento, prurito en ojo izquierdo, se realiza interconsulta con oftalmologia quienes refieren evaluar en sala por imposibilidad de colaboracion de paciente en contexto de su enfermedad de base, a si mismo se inicia tratamiento con gotas oftalmicas.
*Por continar con dermatitis de contacto, se deja indicado crema con corticoides.
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Continua control evolutivo por clinica medica.

IDPTE506485IDCM7135IDCMED111796 IMPRESO EL 20/02/2020 14:10:15

María Celeste Gra...
MÉDICA
M.N. 16150...

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	21/2/2020	Cama:	4	Días Int.	30

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 30
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo de se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: S (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 120-60/ FC 81/FR 16/ T 35.6/ SAT 97% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Catarsis negativa de 24 hs

, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con leve mejoria
Presenta conjuntivis en ojo izquierdo con enrojecimiento y secrecion, en mejoria

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*se solicita laboratorio de central
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Continua control evolutivo por clinica medica.

IDPTES0648SIDCM7135IDCMED111837 IMPRESO EL 21/2/2020 11:37:17

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

59

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	26/02/2020	Cama:	4	Días Int.	35

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 35
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
. TA: 100-80/ FC 76/FR 16/ T 36.4/ SAT 97% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoria.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Se re solicita pedido de laboratorio por central.
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Continua control evolutivo por clinica medica.

IDPTES06485IDCM713SIDCMED111901 IMPRESO EL 26/02/2020 13:10:01

María Celeste Gramajo
MÉDICA
M.N. 161508

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

60

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	27/02/2020	Cama:	4	Días Int.	36

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INCONTINENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 100-80/ FC 76/FR 16/ T 36.4/ SAT 97% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoria.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Se re solicita pedido de laboratorio por central.
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Continua control evolutivo por clinica medica.
DR. SEBASTIAN GERVASONI CLINICA MEDICA MN 152.092

SEBASTIAN GERVASONI
ESP. MEDICINA INTERNA
Mat. Nº152092

IDPTE506485IDCM7135IDCMED111978 IMPRESO EL 27/02/2020 14:46:56

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	28/02/2020	Cama:	4	Días Int.	39

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 37
DIAS DE ATB: *AMS 3 por NAC de probable mecanismo aspirativo, se suspende 24/01
*PTZ: 7
*Linezolid: 7, por rescate en urocultivo de EVR, finalizo 10/02
DIAS DE AVC: YUGULAR POSTERIOR IZQUIERDO: 9 (se retira el 12/02)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

ERCURRENCIAS:
ntercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y ocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde escata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
: TA: 110-70/ FC 78/FR 16/ T 36/ SAT 98% (0.21)
esis consevada por sonda vesical
Catarsis negativa de 24 hs

igil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoria.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 27/02/2020
Hto= 32.4 Hemo= 10.1 Bcos= 5130 Plaq= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 86 Urea= 27 Creat= 0.69 Otros= Na= 137 Ka= 4.6 Cloro= 101 Eritro= 49
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender
*Continua control evolutivo por clinica medica.

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112000 IMPRESO EL 01/03/2020 7:44:18

María Celeste
MÉDIC
M.N.

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	02/03/2020	Cama:	4	Días Int.	40

DIAGNOSTICO:
NAC , DEMENCIA , KPC

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 40

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con ltivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
UCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 110-70/ FC 78/FR 16/ T 36/ SAT 98% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Catarsis POSITIVA

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoria.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 27/02/2020
Hto= 32.4 Hemo= 10.1 Bcos= 5130 Plaq= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 86 Urea= 27 Creat= 0.69 Otros= Na= 137 Ka= 4.6 Cloro= 101 Eritro= 49
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender
*Continua control evolutivo por clinica medica.

DR. CRISTIAN JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLÍNICA MÉDICA
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS P. PIÑERO

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**03/03/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**41**

DIAGNOSTICO:
demencia , causa social

EVOLUCION:
03/03/2020: DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 41

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 110-70/ FC 78/FR 16/ T 36/ SAT 98% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Catarsis POSITIVA

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoria.
Refiere dolor anal , al examen clinico sin particularidades

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 02/03/2020
Hto= 33,1 Hemo= 10.3 Bcos= 5310 Plaq= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 113 Urea= 24 Creat= 0.68 Otros= Na= 140 Ka= 4.4 Cloro= 102 Eritro= 59
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender
*Continua control evolutivo por clinica medica.
HISOPADO RECTAL 26/2 POSITIVO KPC , CONTINUA EN AISLAMIENTO DE CONTACTO

Dr. COPANI JORGE MARCELO
MEDICO CLINICO - GERIATRIA

DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112115 IMPRESO EL 03/03/2020 10:06:44

5/3/2020 Dermatología Karla y Margarita (64)

Paciente que cursa internación con diagnóstico de demencia, presenta dermatitis del pañal se coloca cambio de pañal y crema Nuocid cuando se requiera 2/día durante 4 días y Nuoderm cuando se drena secreción por los drenajes.

PAULA L. NIETO
DERMATÓLOGA
M.N. 123.616 M.P. 335.787

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

65

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**04/03/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**42**

DIAGNOSTICO:
demencia

EVOLUCION:
03/03/2020: DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 42

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 110-70/ FC 82/FR 15/ T 36/ SAT 96% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
arsis POSITIVA

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha en tratamiento con buena evoucion continua con igual tratamiento , interconsulta con dermatologia
Refiere dolor anal , al examen clinico sin particularidades

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 02/03/2020
Hto= 33,1 Hemo= 10.3 Bcos= 5310 Plaq= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 113 Urea= 24 Creat= 0.68 Otros= Na= 140 Ka= 4.4 Cloro= 102 Eritro= 59
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta.
*Continua control evolutivo por clinica medica , a espera de derivacion a tercer nivel .
HISOPADO RECTAL 26/2 POSITIVO KPC , CONTINUA EN AISLAMIENTO DE CONTACTO

04/03/2020: Paciente de 76 años
DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M.N. 86674
HOSP. GRAL. AGUDOS P. PIÑERO

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112156 IMPRESO EL 04/03/2020 9:36:44

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

(66)

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**05/03/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**43**

DIAGNOSTICO:
demencia

EVOLUCION:
03/03/2020: DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 43

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 110-70/ FC 82/FR 15/ T 36/ SAT 96% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Catarsis POSITIVA

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Apena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha en tratamiento con buena evoucion continua con igual tratamiento , interconsulta con dermatologia
Refiere dolor anal , al examen clinico local , dermatitis del pañal que se encuentra en tratamiento y a espera de Interconsulta con dermatologia

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 02/03/2020
Hto= 33,1 Hemo= 10.3 Bcos= 5310 Plaq= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 113 Urea= 24 Creat= 0.68 Otros= Na= 140 Ka= 4.4 Cloro= 102 Eritro= 59
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta.
*Continua control evolutivo por clinica medica , a espera de derivacion a tercer nivel . Se ajusta tratamiento por periodos de excitacion .
HISOPADO RECTAL 26/2 POSITIVO KPC , CONTINUA EN AISLAMIENTO DE CONTACTO
05/03/2020: Paciente de 76 años
DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

Dr. COPANI JORGE MARCELO
MEDICO CLINICO - GERIATRIA
M.N. 86.674

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112212 IMPRESO EL 05/03/2020 9:34:12

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**06/03/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**44**

DIAGNOSTICO:
DEMENCIA

EVOLUCION:
06/03/2020: 03/03/2020: DIAS DE INTERNACION DE CLINICA MEDCA: 43

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 110-70/ FC 82/FR 15/ T 36/ SAT 96% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Catarsis POSITIVA

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha en tratamiento con buena evoucion continua con igual tratamiento , interconsulta con dermatologia
Refiere dolor anal , al examen clinico local , dermatitis del pañal que se encuentra en tratamiento y a espera de interconsulta con dermatologia

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Se recibe laboratorio de central: LABORATORIO DEL DÍA: 02/03/2020
Hto= 33,1 Hemo= 10.3 Bcos= 5310 Plaq= 292.000 KPTT= 28 RIN= 1.01 Gluc= 113 Urea= 24 Creat= 0.68 Otros= Na= 140 Ka= 4.4 Cloro= 102 Eritro= 59
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta.
*Continua control evolutivo por clinica medica , a espera de derivacion a tercer nivel . Se ajusta tratamiento por periodos de excitacion .
HISOPADO RECTAL 26/2 POSITIVO KPC , CONTINUA EN AISLAMIENTO DE CONTACTO , A ESPERA DE INICIO DE EXPEDIENTE PARA DERIVACION A III NIVEL PAMI
DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112265 IMPRESO EL 06/03/2020 8:41:08

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M. N. 86674
HOSP. GRAL. AGUDOS P. PIÑERO

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**09/03/2020**	Cama:	**4**	Días Int.	**47**

DIAGNOSTICO:
Neumonía de la comunidad

EVOLUCION:
09/03/2020: Paciente de 76 años ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
*VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 110-70/ FC 80/FR 16/ T 36.4/ SAT 97% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoria.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender.
Control evolutivo.
DR. GASTON NASTRI CLINICA MEDICA MN:100101

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED112350 IMPRESO EL 09/03/2020 12:30:24 p.m.

GABRIELA PACE
MEDICA

14HS: Se presenta el hijo de la paciente aparte, se comenta lo que se le explica, "queja" de Misma clínica, se

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	10/3/2020	Cama:	4	Días Int.	48

DIAGNOSTICO:
demencia

EVOLUCION:
10/3/2020: 09/03/2020: ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

Interrogatorio realizado a familiar, hijo quien dice llamarse Nicolas.
VGI EN LA INTERNACION CON CAM NEGATIVO
ESFERA FUNCIONAL: dependiente total para las actividades de la vida diaria (Índice de Katz: 18) y dependiente total para AIVD (Escala Lawton Brody: cero)
ESFERA CLINICA: artrosis, medicada con Pregabalina y Tramadol, Osteoporosis, medicada con Calcimax, litiasis vesicular, pancreatitis (2015) TVP(2 episodios, ultimo en el 2016) anticoagulada con Sintrom; Deterioro cognitivo cronico; Patologia psiquiatrica (segun consta en historia clinica: Esquizofrenia, familiar lo niega)
ESFERA SOCIAL: vive con un hijo (Nicolas Horacio)con inadecuada red de contencion familiar. El hijo refiere que no esta capacitado para el cuidado de la misma . Actualmente cursando internacion en Servicio de clinica medica por Sindrome confusional hipoactivo asociado a NAC de probable mecanismo aspirativo con elevado riesgo social, falta de red de contension y la situacion clinica de la misma, lo que le impide a la paciente volver a su domicilio.
ESFERA COGNITIVA: Presenta deterioro cognitivo severo asociado a alucinaciones visuales y auditivas por sindrome demencial probablemente neurodegenerativo tipo Alzheimer. Frail: fagilidad Barthel: 5 (dependencia total).
*ESCALA DE NORTON: 10 riesgo elevado para ulcera por presión
*SINDROMES GERIATRICOS: INMOVILIDAD, INESTABILIDAD, INCOMPETENCIA INTELECTUAL, INCOMPETENCIA SENSORIAL, INANICION, INDIGENCIA , INFECCIONES.
*ANCIANA GERIATRICA con SINDROME DEMENCIAL Y ELEVADO RIESGO SOCIAL y perdida total de funcionalidad. NO GERIATRIZADA.

EXAMEN FISICO:
V: TA: 110-70/ FC 80/FR 16/ T 36.4/ SAT 97% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoria.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender. Conducta agresiva con el personal de salud
Control evolutivo. A espera de inicio de expediente de III nivel , se informa a servicio social.
DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112375 IMPRESO EL 10/3/2020 09:23:47

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M.N. 86674
HOSP. GRAL. AGUDOS P. PIÑERO

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 4 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	11/03/2020	Cama:	4	Días Int.	49

DIAGNOSTICO:
DEMENCIA

EVOLUCION:
11/03/2020: ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.
Sin referir otro antecedente patológico según consta en historia clínica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

EXAMEN FISICO:
CSV: TA: 110-70/ FC 80/FR 16/ T 36.4/ SAT 97% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical
Catarsis negativa de 24 hs

Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, el resto inevaluable por deterioro cognitivo cronico, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Presenta dermatitis de contacto en parte dorsal y en axila derecha con gran mejoria.

COMENTARIOS:
* Paciente en regular estado general, hemodinamicamente estable y afebril, sin intercurrencias infectologicas por el momento, a la espera derivacion a un tercer nivel por PAMI.
*Sin familiar presente al momento del parte medico.
*Familiar (hijo) medica por su cuenta con diferentes farmacos entre ellos benzodiacepinas, se le explica los riesgos de dicha conducta, refiere comprender. Conducta agresiva con el personal de salud
Control evolutivo. A espera de inicio de expediente de III nivel , se informa a servicio social.
DR. MARCELO COPANI MEDICO CLINICO UNIDAD 1 MN 86674

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112456 IMPRESO EL 11/03/2020 12:26:43 p.m.

DR. COPANI JORGE MARCELO
JEFE DE UNIDAD CLINICA MEDICA
M.N. 86674
HOSP. GRAL. AGUDOS P. PIÑERO

71

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	12/03/2020	Cama:	18	Días Int.	50

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION: 50

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02

EXAMEN FISICO:
SIGNOS VITALES: TA: 100/60mmHg - FC 75 LPM - FR:16 RPM - T 36.1/ SAT 98% (0.21)
Diuresis consevada por sonda vesical

Regular estado general, hidratada, afebril, sin signos de dificultad respiratoria, sin evidencia de dolor.
Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona,, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:
* Paciente que pasa de la sala 4 a sala 1 con motivo de requerimiento de camas en dicha unidad en el contexto epidemiologico actual.
*Paciente con internacion prolongada de causa social, en plan de derivacion a tercer nivel por su obra social.
*Se mantienen indicaciones medicas.
*Seguimiento por servicio social.
*Sin acompañante al momento del examen.

DR. JULIO SERNA CONCURRENTE CLINICA MEDICA MN 169132

IDPTE506485IDCM713SIDCMED112535 IMPRESO EL 12/03/2020 02:07:26 p.m.

Julio Cesar Serna
Médico
M.N. 169132

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	13/03/2020	Cama:	18	Días Int.	51

DIAGNOSTICO:
Causa Social

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION: Dia 51

AISLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO:
SIGNOS VITALES: TA: 100/60mmHg - FC 95 LPM - FR:16 RPM - T 36.4c SAT 95% (0.21)
Diuresis: conservada por pañal

Regular estado general, hidratada, afebril, sin signos de dificultad respiratoria, sin evidencia de dolor.
Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:
*Al momento asintomatica, se ecuentra estable clinicamente, afebril, hidratada, sin asistencia familair durante la mañana para su hidratacion y alimentacion.
*Presenta orina turbia por sonda vesical, se indica retiro de sonda vesical y toma de urocultivo.
*Paciente con internacion prolongada de causa social, en plan de derivacion a tercer nivel por su obra social, con alto riesgo de complicacines derivada de la misma.
*Seguimiento por servicio social.
*Sin acompañante al momento del informe medico.

DR. JULIO SERNA CONCURRENTE CLINICA MEDICA MN 169132

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112595 IMPRESO EL 13/03/2020 04:43:22 p.m.

Julio Cesar Serna
MEDICO
M.N. 169132

16/03/2020 Kinesiología.

Paciente hábil, poco colaboradora. Orientada parcialmente en persona, alterada en Tiempo y espacio. Recibe cuidados personales y valoración de la deglución: no se observan signos macroscópicos de aspiración con 5ml de semisólidos y líquidos, presenta disfagia con semisólidos (residuos en cavidad oral) no se evalúa con sólidos por lo mencionado anteriormente. Se sugiere alimentación vía oral con cabecera a 45° o más y alimentos semisólidos y líquidos en pequeñas cantidades con asistencia.

Lic. VETTESE ANDRES
Kinesiólogo Fisiatra – U.B.A.
M.N. 15276

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	16/03/2020	Cama:	18	Días Int.	54

DIAGNOSTICO:
Causa Social

EVOLUCION:
16/03/2020:
DIAS DE INTERNACION: Día 54

AISLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO:
SIGNOS VITALES: TA: 102/55 mmHg - FC 95 LPM - FR:16 RPM - T 36.5° SAT 95% (0.21)
Diuresis: conservada por pañal

Regular estado general, hidratada, afebril, sin signos de dificultad respiratoria, sin evidencia de dolor.
Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas,IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:
*Al momento asintomatica, se ecuentra estable clinicamente, afebril, hidratada, sin asistencia familair durante la mañana para su hidratacion y alimentacion.
*Presenta orina turbia por sonda vesical, se indica retiro de sonda vesical y toma de urocultivo.
*Paciente con internacion prolongada de causa social, en plan de derivacion a tercer nivel por su obra social, con alto riesgo de complicacines derivada de la misma.
*Seguimiento por servicio social.
*Recibo laboratorio con anemia Hb 10.5, resto sp.
*Se habla con kinesiologia quien realiza prueba de deglución a dieta blanda y líquidos, con buena tolerancia. Sugiere no dar sólidos porque mantiene contenido en la boca luego de comer.
Continúa igual tratamiento.
DR. SEBASTIAN CHERNY MEDICO CLINICO MN 129911

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112629 IMPRESO EL 16/03/2020 01:14:30 p.m.

SEBASTIAN CHERNY
ESP. EN MEDICINA INTERNA
M.N. 129911

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	17/03/2020	Cama:	18	Días Int.	55

DIAGNOSTICO:
Causa Social

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION: DÍA 55

--AISLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO:
SIGNOS VITALES: TA: 90/60 mmHg - FC 90 LPM - FR:16 RPM - T 36.0° SAT 93% (0.21)
Diuresis: 200 ml por sonda vesical

Regular estado general, hidratada, afebril, sin signos de dificultad respiratoria, sin evidencia de dolor.
Vigil, atenta, reactiva con orientacion en persona, reactiva, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:

*Evolucion aa la fecha sin intercurrencias clinicas a la fecha, no presencia conducta activa por clinica medica, en plan de derivacion a tercer nivel por su obra social.
*Urocultivo del dia 13/03 con FPM con sedimento urinario no inflamatorio, paciente asintomatica, se expecta conducta antibiotica.
*Paciente con internacion prolongada de causa social, con alto riesgo de complicacines derivada de la misma.
*Seguimiento por servicio social.

DR. JULIO SERNA CONCURRENTE CLINICA MEDICA MN 169132

IDPTE506485IDCM713SIDCMED112693 IMPRESO EL 17/03/2020 01:42:19 p.m.

Julio Cesar Serna
Médico
M.N. 169132

75

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**18/03/2020**	Cama:	**18**	Días Int.	**56**

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION: DÍA 56

--AISLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

TERCURRENCIAS:
Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO:
SIGNOS VITALES: TA: 90/60 mmHg - FC 92 LPM - FR:16 RPM - T 36.9° SAT 94% (0.21)
Diuresis: 300 ml por sonda vesical

Somnolienta, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable, afebril. Somnolienta en el día de hoy que se interpreta de origen farmacológico por excitación en la noche.
*Evolucion aa la fecha sin intercurrencias clinicas a la fecha, no presencia conducta activa por clinica medica, en plan de derivacion a tercer nivel por su obra social.
Urocultivo del dia 13/03 con FPM con sedimento urinario no inflamatorio, paciente asintomatica, se expecta conducta antibiotica.
*Paciente con internacion prolongada de causa social, con alto riesgo de complicacines derivada de la misma.
*Seguimiento por servicio social.

DRA. FLORENCIA VALENTI CLÍNICA MÉDICA MN 157163

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112733 IMPRESO EL 18/03/2020 12:14:41 p.m.

Florencia Valenti
Médica - U.B.A.
M.N.: 157.163

Kinesiología. 19-3-2020.

Paciente ingresa, controlada en persona en tiempo y espacio. No colaboradora. Moviliza 4 miembros, no realiza cambios de posición de manera independiente. Recibe asistencia kinésica motora: movilizaciones activo-pasivas de extremidades, se sienta al borde de la cama con máxima asistencia, buen control de tronco y pelvis, la parte activa del cuerpo por voluntad propia. Recibe cuidados personales.

Recibe ingreso de cuidados prof.

Lic. VETTESE ANDRES
Kinesiólogo Fisiatra – U.B.A.
M.N. 15216

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	19/03/2020	Cama:	18	Días Int.	57

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)
- CAUSA SOCIAL -

EVOLUCION:
19/03/2020:

DIAS DE INTERNACION: DÍA 57

--AISLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO
Paciente vigil con buena respuesta a ordenes simples, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
SIGNOS VITALES: TA: 100/60 mmHg - FC 89 - FR:17 - T 36.4° SAT 97% (0.21)

COMENTARIOS:
Paciente clínicamente estable, afebril. Al momento del examen.
*Evolucion a la fecha sin intercurrencias clinicas a la fecha, no presencia conducta activa por clinica medica, en plan de derivacion a tercer nivel por su obra social.
*Urocultivo del dia 13/03 con FPM con sedimento urinario no inflamatorio, paciente asintomatica, se expecta conducta antibiotica.
*Paciente con internacion prolongada de causa social, con alto riesgo de complicacines derivada de la misma.
*Seguimiento por servicio social.

ALTA COMORBILIDAD POR INTRNACION PROLONGADA

** SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HIJO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE ***
DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE506485IDCM713SIDCMED112783 IMPRESO EL 19/03/2020 11:22:05 a.m.

Dr. NESTOR SCHINOCCA
M.N. 104.860
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	20/03/2020	Cama:	18	Días Int.	58

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
DIAS DE INTERNACION: DÍA 57

--AISLAMIENTO KPC (por HISOPADO)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de artrosis en tratamiento crónico con tramadol y pregabalina, TVP con ACO prolongado sin control, deterioro cognitivo, gastritis crónica.

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO
TA 140/80 FC 78 FR 16 T° 36.2 SAT 96% (0.21)
Paciente vigil con buena respuesta a ordenes simples, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
Buena mecanica respiratoria, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.

COMENTARIOS:
Paciente clínicamente estable, afebril. Al momento del examen.
*Presenta piuria, por lo que se toma urocultivo. Conducta antibiotica expectante, segun resultados.
* Sin familiares presentes.

ALTA COMORBILIDAD POR INTRNACION PROLONGADA

** SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HIJO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE ***
DRA. FLORENCIA VALENTI CLÍNICA MÉDICA MN 157163

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112844 IMPRESO EL 20/03/2020 01:22:38 p.m.

Florencia Valenti
Medica UBA
M.N. 157.163

20/03/20 Clinica Medica Guardia
22:04hs Acudimos al llamado de enfermería refiriendo que el familiar de la pte estaba movilizando a la pte con su cama por los pasillos del 1er piso para su traslado a algun otro sector del Hospital; previo a esto informa el supervisor de enfermería que dicho familiar agredio verbalmente al personal de

enfermería de la Sala.
Pte vigil, demenciado, TA 100/60 FC 60 x'
SO_2 93%. BEAB RMV(-) sin ruidos
agregados, mucosidad en bases con
uso manejo de secreciones, con lago pulmón.
RR en 4 focos sin ruidos agregados
Abdomen S/P.
Presenta flebitis en MSD.
Se indica aspiración de lago pulmón,
toma vía periférica, colocar medios
físicos en miembro derecho. y
control térmico.
Conducta expectante
Se informa el estado de la pte al hijo.
El mismo se retira del Hospital sin
conflicto.

DANIELA PARERA
M.N. 101237
MEDICA

Andrea P. Guerrero
Médica - UBA
M.N. 130 638

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	25/03/2020	Cama:	18	Días Int.	63

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

MEROPENEM DIA 4
VANCOMICINA DIA 4

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO
TA 130/70 FC 82 FR 22 T° 36,4 SAT 97% (0.21)
Paciente vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, 2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba
aceptable mecanica ventilatoria por taquipnea, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin otros ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.

COMENTARIOS:
Paciente clínicamente estable, afebril. Ancia geriatrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la reanimación, cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Roto esquema a PTZ-Vancomicina.
Se realiza EAB (0.21): 7.42/26/103/17/-6.1/98% Lactico 0.73.
Se explica a familiar el cuadro clínico y el pronóstico reservado de la paciente como consecuencia de alta comorbiladad por internación prolongada en paciente añosa.

** SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HIJO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE ***
DRA. FLORENCIA VALENTI CLÍNICA MÉDICA MN 157163

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112896 IMPRESO EL 25/03/2020 11:50:55 a.m.

Florencia Valenti
Médica - U.B.A.
M.N.: 157.163

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

79

Nombre y Apellido	**KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**			HC Nº	**402454**
Fecha:	**25/03/2020**	Cama:	**18**	Días Int.	**63**

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION DE GUARDIA:
12 y 20 hs

Dejamos constancia que quien refiere ser su hijo presentas conductas inapropiadas en la sala conducta querellante con el personal medico.
En el dia de la fecha retira de el recipiente de residuos patologicos de la habitacion la comida de la internada distrubuyendola por la habitacion sobre camas y demas.
Ante esta situacion se llama a personal de seguridad quienes se presentan de inmediato y retiran al referido.
Me comunico con jefa de Departamente informando la situación para que tome conocimiento.
Enfermeria presente en el momento de dicho acto. Por lo que vuelco en su report lo acontencido. Dada la conducta desadaptada se sugiere limitar el ingreso.
Se deja constancia de lo acontecido.
R. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112896 IMPRESO EL 25/03/2020 01:10:14 p.m.

Dr. NESTOR SCHINOCCA
M.N. 104.860
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

AC

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	26/03/2020	Cama:	18	Dias Int.	64

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)
- CASO SOCIAL

EVOLUCION:
26/03/2020:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

MEROPENEM DIA 5
VANCOMICINA DIA 5

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.

EXAMEN FISICO

Paciente en mal estado genral, vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.
R1 / R2 ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, mecanica ventilatoria por taquipnea, hipoventilacion global por falta de colaboracion, roncus y sibilancias bilaterales como ruidos sobreagregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva.
TA 120/65 FC 74 FR 21 T° 36. 0 SAT 97% (0.21) AIRE AMBIENTE

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable, afebril.
Anciana geriatrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el dia 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a TERAPUETICA , cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Roto esquema a PTZ-Vancomicina.

** Se explica a familiar el pronostico reservado de la paciente dado la intercurrencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa ***

** SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HIJO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE, PRESENTA CONDUCTA NO ACORDE A LAS BUENAS COSTUMBRES , A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO ***
DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE506485IDCM7135IDCMED112935 IMPRESO EL 26/03/2020 12:02:15 p.m.

Dr. NESTOR SCHINOCCA
M.N. 104.860
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	27/03/2020	Cama:	18	Días Int.	65

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

PIPERACILINA TAZOBACTAM 6
VANCOMICINA DIA 6

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, en tratamiento con PTZ-Vancomicina

EXAMEN FISICO
TA 130/80 FC 96 FR 20 T° 35.5 SAT 96% (0.21)
Vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.
Bien perfundido, 2R ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.
Aceptable mecanica ventilatoria por taquipnea, hipoventilacion global por falta de colaboracion, rales de secreción alta.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.

COMENTARIOS:
Paciente clínicamente estable, afebril.
Anciana geriatrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica , cubriendose empíricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectología, Dra. Cabrera, que indica suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizan HMC control.
Pronostico reservado de la paciente dado la intercurrencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa

SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HIJO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE

DRA. FLORENCIA VALENTI CLÍNICA MÉDICA MN 157163

IDPTES06485IDCM7135IDCMED112971 IMPRESO EL 27/03/2020 12:53:52 p.m.

Valenti F
157163

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	30/03/2020	Cama:	18	Días Int.	68

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

VANCOMICINA DIA 9

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO
TA 150/80 FC 62 FR 18 T° 37.3 SAT 96% (0.21)
D: 150 ml/3 hs B: +350
Vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.
Bien perfundido, 2R ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba,
Buena mecanica ventilatoria por taquipnea, hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.

COMENTARIOS:
Paciente clínicamente estable, afebril.
Anciana geriatrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el dia 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica , cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectología, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.
Pronostico reservado de la paciente dado la intercurrencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa

SE DEJA CONSTANCIA QUE SU HIJO MANTIENE CONDUCTA HACIA EL PERSONAL DE SALUD QUERELLANTE Y DEMANDANTE INJUSTIFICADAMENTE
DRA. FLORENCIA VALENTI CLÍNICA MÉDICA MN 157163

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113007 IMPRESO EL 30/03/2020 09:55:29 a.m.



83

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	31/03/2020	Cama:	18	Días Int.	69

DIAGNOSTICO:
INFECCION URINARIA- CAUSA SOCIAL -

EVOLUCION:
31/03/2020:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

VANCOMICINA DIA 10

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina dia 8.

EXAMEN FISICO

Vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.
Bien perfundido, 2R ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba,
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.
TA 130/80 FC 65 FR 17 T° 36.7 SAT 96% (0.21)

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable, afebril, normotensa.
Anciana geriatrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el dia 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica , cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectologia, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.
Pronostico reservado de la paciente dado la intercurrencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa. Continua esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetologia.

Su familiar se hace presente en le dia de ayer en servicio social, este servicio se comunica con quien suscribe en horas de la tarde informamndome la posiblidad de vacante de la paciente en tercer nivel ,, solo se aguarda que se de aviso a serv social de pami , que la paciente a cumplido esquema antibiotico.**

***ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL ***
actaulizo indicaciones

DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113032 IMPRESO EL 31/03/2020 10:31:48 a.m.

Dr. NESTOR SCHINOCCA
M.N. 104.860
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

31/03/2020



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	01/04/2020	Cama:	18	Días Int.	70

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

VANCOMICINA DIA 11

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.
Bien perfundido, 2R ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba,
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.
TA 120/80 FC 72 FR 17 T° 36.7 SAT 96% (0.21)

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable, afebril, normotensa.
Anciana geriatrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica , cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectologia, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.
Pronostico reservado de la paciente dado la intercurrencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa. Continua esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetologia.

Su familiar se hace presente en le dia de ayer en servicio social, este servicio se comunica con quien suscribe en horas de la tarde informamndome la posiblidad de vacante de la paciente en tercer nivel ,, solo se aguarda que se de aviso a serv social de pami , que la paciente a cumplido esquema antibiotico.**

***ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL ***
actaulizo indicaciones

DRA. GRETEL BREVEDAN CLINICA MEDICA MN 89051

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113061 IMPRESO EL 01/04/2020 11:25:05 a.m.

2/4/2020 Kinesiología.

Paciente mujer, no colaboradora que no responde a ordenes simples. Puede incorporarse para a pulsos Espinos y de miembro inferior derecho. Mucho miedo al movimiento de pie a raíz de pulso. Puede realizar pequeños. Se continua en proximo tratamiento.

Lic. VETTESE ANDRES
Kinesiólogo Fisiatra – U.B.A.
M.N. 15216

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	02/04/2020	Cama:	18	Días Int.	71

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

VANCOMICINA DIA 12

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil con tendencia al sueño, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.
Bien perfundido, 2R ruidos en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba,
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.
TA 110/70 FC 72 FR 17 T° 36.7 SAT 96% (0.21)

COMENTARIOS:
*Paciente clínicamente estable, afebril, normotensa.
Anciana geriatrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica , cubriendose empíricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectología, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.
Pronostico reservado de la paciente dado la intercurrencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa. Continua esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetologia.

Su familiar se hace presente en le dia de ayer en servicio social, este servicio se comunica con quien suscribe en horas de la tarde informamndome la posiblidad de vacante de la paciente en tercer nivel ,, solo se aguarda que se de aviso a serv social de pami , que la paciente a cumplido esquema antibiotico.**

***ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL ***
actaulizo indicaciones

GRETEL BREVEDAN CLINICA MEDICA MP 89.051 - MP 446280

DRA. GRETEL BREVEDAN CLINICA MEDICA MN 89051

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	06/04/2020	Cama:	18	Días Int.	75

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

VANCOMICINA ------ cumplio tto por 14 dias

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil con tendencia al sueño, deterioro cognitivo cronico, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, edema en miembro inferior derecho 3/6
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.
TA 130/80 FC 78 FR 18 T° 36.2 SAT 96% (0.21) aire ambiente.

COMENTARIOS:
Paciente clínicamente estable, afebril, normotensa.
Anciana geriatrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el dia 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica , cubriendose empíricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectologia, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 dias efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.
Pronostico reservado de la paciente dado la intercurrencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa. Continua esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetologia dia 13 finalizando el dia domingo
Se evaluara el dia Lunes remitir a PAMI resumen de HC para tercer nivel.

***ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL ***
actaulizo indicaciones

GRETEL BREVEDAN CLINICA MEDICA MN 89051 - M.P.446.990

DRA. GRETEL BREVEDAN CLINICA MEDICA MN 89051

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113199 IMPRESO EL 06/04/2020 12:40:57 p.m.

89

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	14/04/2020	Cama:	18	Días Int.	83

EVOLUCION:
Evolucion diaria
Dias de internacion 83
KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina dia 8.

EXAMEN FISICO
SV= TA 100/60, FC 88, FR 18, T 36.2, SAT 95% (0.21)
Vigil , deterioro cognitivo cronico, se la encuentra mas reactiva, quuejosa, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, al momento del examen.
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.
persiste flebits en antebrazo con mejoria y respuesta a la terapeutica , dermatitis del pañal por lo que se indica MACRIL (betametasona - neomicina- antifungico). aplicar 2 veces por dia.
Continua en tramite lo enviado a servicio social, las intercurrencias detalladas van teniendo aparicion en forma ascedente en la medida que el paciente prolonga su estadia hospitalaria , por tal motivo se insite que la paciente este en el Nivel adecuado a su necesidad.

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable afebril, cursando itnernacion prolongada , sin cambios al examen fisico respecto a la evolucionanterior al momento del examen.
Paciente con pronostico reservado sin familaires al momento del parte medico
en plan de derivar a 3 nivel.

*** SE REMITE A ASIT SOCIAL DE PAMI RESUMEN DE H.C PARA TRAMITAR TERCER NIVEL ****
continua en seugimiento por la especialidad.
DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTES06485IDCM7135IDCMED113454 IMPRESO EL 14/04/2020 08:35:14 a.m.

Martiarena Ailen
MN 153107

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	20/04/2020	Cama:	18	Días Int.	89

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
EVOLUCION CLINICA MEDICA
Dias de internacion 89- KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 dias.
*16/04: ITU bacteremica por Klebsiella pneumoniae, pendiente tipificacion, en tratamiento con meropenem.

EXAMEN FISICO
SV= TA 90/60, FC 90, FR 20, T 36.3, SAT 95% (0.21)
Diuresis 200 ml en 2 hs. Orina clara.
Vigil, no responde a ordenes simples, en contexto de deterioro cognitivo cronico e infeccion, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.
Buena mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible dolor a la palpacion en puntos ureterales bilaterales, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.
Persiste flebits en antebrazo con mejoria y respuesta a la terapeutica , dermatitis del pañal en tratamiento topico.

COMENTARIOS:
Paciente en mal estado general, vgi geriatrica con multiples sindromes geriatricos, comorbilidades, internacion prolongada con intercurrencias de indole infecciosa por germenes resistentes. Al momento se encuentra cursando intercurrencia infecciosa por itu bacteremica pór klebsiella pneumoniae en estduio, en tratamiento con meropenem, tambien presenta hmc 1 de 2 para samr. UC con Kpneumonnia sensible a amikacina, Proteus mirabilis sensible a ptz. Se realiza ic con infectologia, quien indica nueva tomo de hemocultivos e iniciar vancomicina.
Paciente que no se alimenta por sus propios medios, hipoalbuminemica, poliescarada, se decide colocar sonda nasogastrica.
Paciente con pronostico reservado. No se presentan familiares para comuncarles el informe clinico de la paciente.
Se solicita laboratorio por central para el dia lunes.
Se actualizan indicaciones medicas.
Continua control evolutivo.
DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113682 IMPRESO EL 20/04/2020 12:15:34 p.m.

AILEN MARTIARENA
MEDICA U.B.A.
M.N. 153.107

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2146478**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 30/03/20 09:05

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

HEMOSTASIA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**			
APTT	23	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ana María Dorr
Bioquímica - M.N. 7951

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	81	mg/dl	70 - 110 mg/dl
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	26	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	0,86	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
HEPATOGRAMA Método: Automatizado			
Colesterol Total	116	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
Bilirrubina Total	0,34	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa	0,16	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta	0,18	mg/dl	
Fosfatasa Alcalina	101	UI/L	40 - 130 UI/L
TGO	27	UI/L	5 - 34 UI/L
TGP	18	UI/L	8 - 40 UI/L
Proteínas Totales	5,3	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
CALCIO, SANGRE Método: Colorimétrico	8,0	mg/dl	8.5 - 10.4 mg/dl
FOSFORO, SANGRE Método: UV	3,0	mg/dl	2,4 - 4,7 mg/dl
MAGNESIO Método: Colorimétrico	1,34	mg/dl	1,6 - 2,55 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	151	mmol/L	135 - 145 mmol/L

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2146478**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado		Fecha:	30/03/20 09:05
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 1 | Cama: 18		

QUIMICA CLINICA

Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**

	Resultados		Valores de Referencia
Potasio	3,0	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	111	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607

Silvia Graciela Oliveto
Bioquímica - M.N. 6677

DROGAS TERAPEUTICAS

Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**

	Resultados		Valores de Referencia
VANCOMICINA Método: Inmunoturbidimetría	12	µg/ml	Valle: 5 - 10 µg/ml Pico: 20 - 40 µg/ml

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2146478**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 30/03/20 09:05

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados			Valores de Referencia	
HEMOGRAMA					
Método: Automatizado. Abbott CD Sapphire					
SERIE ERITROCITARIA					
Eritrocitos	3,26	*10^12/L		3,88 - 4,99 *10^12/L	
Hemoglobina	9,1	g/dl		11,8 - 14,8 g/dl	
Hematocrito	28,5	%		36,0 - 44,0 %	
Indices Hematimétricos					
Volumen Corpuscular Medio	87,5	fL		80,5 - 100,0 fL	
Hemoglobina Corpuscular Media	27,8	pg		26,0 - 34,0 pg	
Concentración de Hb Corpuscular Media	31,8	g/dl		31,6 - 37,5 g/dl	
Amplitud de Distribución eritrocitaria	15,8	%		11,6 - 13,9 %	
SERIE PLAQUETARIA					
Plaquetas	267,0	*10^9/L		130,0 - 350,0 *10^9/L	
Volumen Plaquetario Medio	8,5	fL		7,6 - 11,0 fL	
Amplitud de ditribucion plaquetaria	16,3	%		15,0 - 17,2 %	
Plaquetocrito	0,226	%		0,100 - 0, 600 %	
SERIE LEUCOCITARIA					
Leucocitos	6,65	*10^9/L		3,90 - 11,10 *10^9/L	
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	74,30	%	4.94 *10^9/L	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 *10^9/L
Linfocitos	15,90	%	1.06 *10^9/L	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 *10^9/L
Monocitos	7,42	%	0.49 *10^9/L	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 *10^9/L
Eosinófilos	1,76	%	0.12 *10^9/L	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 *10^9/L
Basófilos	0,55	%	0.04 *10^9/L	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 *10^9/L
ERITROSEDIMENTACION	51	mm		1 - 16 mm	

Resultados validados electrónicamente por:

María Inés Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

HEMOSTASIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados	Valores de Referencia
COAGULOGRAMA		
Método: Coagulométrico | ACL Top 300		
RIN	2,41	0,90 - 1,20

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	03/04/2020	Cama:	18	Días Int.	72

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)
-Infeccion urinaria- HC + a foco endovascular

EVOLUCION:
03/04/2020:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

VANCOMICINA DIA 13

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoiuciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil con tendencia al sueño, deterioro cognitivo cronico, sin foco motor ni meningeo al momento del examen.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba,
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
Edema en antebrazo derecho, en región de flebitis.
TA 120/75 FC 70 FR 17 T° 36.2 SAT 96% (0.21) aire ambiente.

COMENTARIOS:
Paciente clínicamente estable, afebril, normotensa.
Anciana geriatrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el día 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica , cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a infectologia, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.
Pronostico reservado de la paciente dado la intercurrencia intrahospitalaria en contexto de paciente añosa. Continua esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetologia dia 13 finalizando el dia domingo
Se evaluara el dia Lunes remitir a PAMI resumen de HC para tercer nivel.

***ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL ***
actaulizo indicaciones

DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113120 IMPRESO EL 03/04/2020 09:32:49 a.m.



7/4/20 Kinesiología: ~~Respiratoria~~

Paciente vigil, desorientada globalmente, sonidos incomprensibles. Se ubica con cabecera a 60° en cama. Se evalua deglución, no presenta signos macroscópicos de aspiración con alimentos pero si con líquidos tos en repetidas veces. No se evalua con sólidos por falta de piezas dentarias. Dentadura con dos posteriores.

Lic. Luciana Prieto
Kinesióloga Fisiatra
M.N. 14408

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	07/04/2020	Cama:	18	Días Int.	76

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)
-infeccion urinarioa- deteerioro cognitivo cronico- causa social

EVOLUCION:
07/04/2020:

EVOLUCION DIARIA CLINICA MEDICA

AISLAMIENTO KPC

VANCOMICINA ---- cumplio tto por 14 dias

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil , deterioro cognitivo cronico, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, edema en miembro inferior derecho 2/6. al momento del examen.
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
disminucion de lesion edematosa por flebits en antebrazo
TA 120/70 FC 88 FR 18 T° 36.1 SAT 96% (0.21) aire ambiente.

COMENTARIOS:
Paciente clínicamente estable, afebril, normotensa. Con alta comorbilidad por estada prolongada en medio nosocomial
Anciana geriatrica, postrada, cursando internación por causa social. Intercurrió el dia 22/03 con fiebre e hipotensión, con buena respuesta a la terapeutica , cubriendose empiricamente con Meropenem-Vancomicina. Se obtienen rescate de HMC 2/2 SAMR y UC con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina. Se Roto esquema a PTZ-Vancomicina. Se realiza IC a Infectologia, Dra. Cabrera, que decidió suspender PTZ por haber cumplido 5 días efectivos y continuar con Vancomicina. Se realizaron HMC controles, negativos a la fecha.
Continua esquema con Vancomicina tal lo indicado por infetologia dia 13 finalizando el dia domingo

****Se remite a PAMI resumen de HC para tercer nivel.****

***ALTA COMORBILIDAD EN CONTEXTO DE PACIENTE AÑOSA EN MEDIO NOSOCOMIAL ***
actaulizo indicaciones
DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113246 IMPRESO EL 07/04/2020 11:21:25 a.m.



HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	08/04/2020	Cama:	18	Días Int.	77

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
Evolucion diaria
Dias de internacion 77

AISLAMIENTO KPC

VANCOMICINA ---- cumplio tto por 14 dias

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
tercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO
TA 120/80 Fc 82 Fr 20 T 36.2 SAt 985 0.21

Vigil , deterioro cognitivo cronico, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, edema en miembro inferior derecho 2/6. al momento del examen.
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
disminucion de lesion edematosa por flebits en antebrazo

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable afebril, cursando itnernacion prolongada , sin cambios al examen fisico, presenta mimenro inferior izquierdo edematizado, lugar donde rpevio presento acceso venoso periferico, no HOMMAN no pai
piente con pronostico reservado sin familaires al momento del parte medico
en plan de derivar a 3 nivel
continua en seugimiento por la especialidad.

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113320 IMPRESO EL 08/04/2020 01:45:51 p.m.

Gustavo A. Martinez Soto
Médico
M.P.N. 158.672

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	09/04/2020	Cama:	18	Días Int.	78

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)
- infeccion urinaria - causa social -

EVOLUCION:
09/04/2020:

Evolucion diaria
Dias de internacion 78

AISLAMIENTO KPC

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil , deterioro cognitivo cronico, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, IY 1/3 con colapso sin reflujo, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, edema en miembro inferior derecho 2/6, al momento del examen.
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva.
disminucion de lesion edematosa por flebitis en antebrazo
TA 125/80 Fc 80 Fr 17 T 36.3 SAt 985 0.21

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable afebril, cursando internacion prolongada , sin cambios al examen fisico respecto a la evolucionanterior al momento del examen.
Paciente con pronostico reservado sin familiares al momento del parte medico
en plan de derivar a 3 nivel.

*** SE REMITE A ASIT SOCIAL DE PAMI RESUMEN DE H.C PARA TRAMITAR TERCER NIVEL ****
continua en seugimiento por la especialidad.
DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTES06485IDCM7135IDCMED113941 IMPRESO EL 09/04/2020 10:00:51 a.m.

DR. NESTOR SCHINOCCA
M.N. 104.860
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	13/04/2020	Cama:	18	Días Int.	82

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonia Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)
- infeccion urinaria - causa social -

EVOLUCION:
13/04/2020:

Evolucion diaria
Dias de internacion 82

KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y actualmente con Vancomicina día 8.

EXAMEN FISICO

Vigil , deterioro cognitivo cronico, se la encuentra mas reactiva, quuejosa, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, al momento del examen.
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.
persiste flebits en antebrazo con mejoria y respuesta a la terapeutica , dermatitis del pañal por lo que se indica MACRIL (betametasona - neomicina- antifungico). aplicar 2 veces por dia.
Continua en tramite lo enviado a servicio social, las intercurrencias detalladas van teniendo aparicion en forma ascedente en la medida que el paciente prolonga su estadia hospitalaria , por tal motivo se insite que la paciente este en el Nivel adecuado a su necesidad.

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable afebril, cursando itnernacion prolongada , sin cambios al examen fisico respecto a la evolucionanterior al momento del examen.
Paciente con pronostico reservado sin familaires al momento del parte medico
en plan de derivar a 3 nivel.

*** SE REMITE A ASIT SOCIAL DE PAMI RESUMEN DE H.C PARA TRAMITAR TERCER NIVEL ****
continua en seugimiento por la especialidad.
ACUALIZO INDICACIONES.
DR. NESTOR SCHINOCCA MEDICO CLINICA MEDICA MN 104860

IDPTES06485IDCM7135IDCMED113425 IMPRESO EL 13/04/2020 10:34:39 a.m.

Dr. NESTOR SCHINOCCA
M.N. 104.860
ESP. EN CLINICA MEDICA
ESP. EN TERAPIA INTENSIVA

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

94

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	15/04/2020	Cama:	18	Días Int.	84

EVOLUCION:
Evolucion diaria
Dias de internacion 84
KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 dias.

EXAMEN FISICO
SV= TA 110/60, FC 80, FR 18, T 36.1, SAT 95% (0.21)
Vigil , deterioro cognitivo cronico, se la encuentra mas reactiva, quuejosa, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, al momento del examen.
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible e indoloro, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados.
Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.
persiste flebits en antebrazo con mejoria y respuesta a la terapeutica , dermatitis del pañal por lo que se indica MACRIL (betametasona - neomicina- antifungico). aplicar 2 veces por dia.
Continua en tramite lo enviado a servicio social, las intercurrencias detalladas van teniendo aparicion en forma ascedente en la medida que el paciente prolonga su estadia hospitalaria , por tal motivo se insite que la paciente este en el Nivel adecuado a su necesidad.

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable afebril, cursando itnernacion prolongada , sin cambios al examen fisico respecto a la evolucionanterior al momento del examen.
Paciente con pronostico reservado sin familaires al momento del parte medico
en plan de derivar a 3 nivel.

*** SE REMITE A ASIT SOCIAL DE PAMI RESUMEN DE H.C PARA TRAMITAR TERCER NIVEL ****
continua en seugimiento por la especialidad.
DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTES06485IDCM7135IDCMED113547 IMPRESO EL 15/04/2020 01:12:37 p.m.

Martiarena Ailin
MN 153107

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	16/04/2020	Cama:	18	Días Int.	85

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
16/04/2020: Paciente de 76 años

Dias de internacion 85
KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*Intercurre registros subfebriles en dia 4 de AMS, por lo que se realizan HMC- UC escalando esquema antibiotico a PTZ. Evoluciona con cultivos negativos y urocultivo con fpm, continuando con registros subfebriles en contexto de un tratamiento suboptimo con PTZ., por lo que se recultiva HMC y urocultivo donde se rescata EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
* Intercurre el 21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 dias.
*Intercurre el dia de hoy (16/04) con hipotension, mala perfusion distal y equovalentes febriles, taquicradia y taquipnea, a probable foco urinario por presencia de sedimento purulento por sv y puntos ureterales +.Salen HMC por dos, uro cultivo y labo de guardia.

EXAMEN FISICO
SV= TA 80/60, FC 100, FR 25, T 38, SAT 92% (0.21)
Vigil , deterioro cognitivo cronico, se la encuentra mas reactiva, quuejosa, sin foco motor ni meningeo al momento del examen semiologico.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba, al momento del examen.
Aceptable mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible dolor a la palpacion en puntos ureterales bilaterales, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.
persiste flebits en antebrazo con mejoria y respuesta a la terapeutica , dermatitis del pañal por lo que se indica MACRIL (betametasona - neomicina- antifungico). aplicar 2 veces por dia.
Continua en tramite lo enviado a servicio social, las intercurrencias detalladas van teniendo aparicion en forma ascedente en la medida que el paciente prolonga su estadia hospitalaria , por tal motivo se insite que la paciente este en el Nivel adecuado a su necesidad.

COMENTARIOS:
Paciente clinicamente estable afebril, cursando itnernacion prolongada , sin cambios al examen fisico respecto a la evolucionanterior al momento del examen.
Paciente con pronostico reservado sin familaires al momento del parte medico
en plan de derivar a 3 nivel.
Debido a sepsis a foco urinario se inicia tratamiento con meropenem 1 gr cada 8 hs.

Pendiente:
-Seguimiento de cultivos y laboratorio de guardia.

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113596 IMPRESO EL 16/04/2020 02:33:19 p.m.

Tratante Area

89

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	17/04/2020	Cama:	18	Días Int.	86

EVOLUCION CLINICA MEDICA
Dias de internacion 86
KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 dias.
*16/04: ITU bacteremica por BGN, pendiente tipificacion, en tratamiento con meropenem.

EXAMEN FISICO
SV= TA 90/60, FC 92, FR 20, T 36.1, SAT 95% (0.21)
Diuresis 100 ml en 2 hs. Orina clara.
Vigil, no responde a ordenes simples, en contexto de deterioro cognitivo cronico e infeccion, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.
Buena mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando , depresible dolor a la palpacion en puntos ureterales bilaterales, cicatriz mediana infra umbilical, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.
Persiste flebits en antebrazo con mejoria y respuesta a la terapeutica , dermatitis del pañal en tratamiento topico.

COMENTARIOS:
Paciente en mal estado general, vgi geriatrica con multiples sindromes geriatricos, comorbilidades, internacion prolongada con intercurrencias de indole infecciosa por germenes resistentes. Al momento se encuentra cursando intercurrencia infecciosa por itu bacteremica, al momento por bgn, en estduio, en tratamiento con meropenem, pendiente tipificacion para ajustar atb a germen.
Paciente con pronostico reservado sin familaires al momento del parte medico.
Se solicita laboratorio por central para el dia lunes.
Se actualizan indicaciones medicas.
Continua control evolutivo.

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED113627 IMPRESO EL 17/04/2020 10:49:13 a.m.

AILEN MARTIARENA
MEDICA U.B.A.
M.N. 153.107

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	21/04/2020	Cama:	18	Días Int.	90

EVOLUCION CLINICA MEDICA
Dias de internacion 90- KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.

INTERCURRENCIAS:
*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 dias.
*16/04: ITU bacteremica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajsutado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina.

EXAMEN FISICO
SV= TA 100/60, FC 92, FR 20, T 36.2, SAT 96% (0.21)
Diuresis 500 ml en 3 hs. Orina clara.
Vigil, no responde a ordenes simples, en contexto de deterioro cognitivo cronico e infeccion, sin foco motor ni meningeo.
Bien perfundida, R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, sin edemas, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.
Buena mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando, impresiona no doloroso, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.
Persiste flebits en antebrazo con mejoria y respuesta a la terapeutica , dermatitis del pañal en tratamiento topico.

COMENTARIOS:
Paciente en mal estado general, vgi geriatrica con multiples sindromes geriatricos, comorbilidades, internacion prolongada con intercurrencias de indole infecciosa por germenes resistentes. Al momento se encuientra cursando intercurrencia infecciosa por itu bacteremica pór klebsiella pneumoniae sensible a piperacilina-tazobactam, UC: Kpneumonnia sensible a amikacina, Proteus mirabilis sensible a ptz. Ademas HMC positivo para SAMR. Se realiza ic con infectologia, quien indica nueva tomo de hemocultivos e iniciar vancomicina, asociado a piperacilina-tazobactam.
HEMOCUTLIVOS CONTROL DEL DIA 20/04: Negativos a la fecha.
Se recibe laboratorio de central:
Hto= 26.2 Hemo= 7.6 Bcos= 10600 Plaq= npf KPTT= 28 RIN= 3.08 Gluc= 99 Urea= 165 Creat= 3.23 Clear crea: 20 Colest= 82 Prot= 4.7 Albu= 1.8 Bili= 0.23 F.Alca= 82 TGO= 27 TGP= 13 Calc= 7.5 Fosfat= 3.9 Magne= 2.2 Otros= Na= 179 Ka= 3.6 Cloro= 139 Calcio.C= 9.26
Por hipernatremia se inicia agua libre por sonda nasogastrica. Por insuficienica renal de probable etiologia prerrenal, se aumenta aporte y se ajustan antibiotico a clearance. Pendiente resultado de laboratorio control para el dia de la fecha.
Paciente con pronostico reservado.
No se presentan familiares para comuncarles el informe clinico de la paciente.
Se actualizan indicaciones medicas.
Continua control evolutivo.
DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE506485IDCM713SIDCMED113736 IMPRESO EL 21/04/2020 10:58:04 a.m.

Martiarena Ailen
MN 153107

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	22/04/2020	Cama:	18	Dias Int.	91

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
EVOLUCION CLINICA MEDICA
Dias de internacion 90- KPC (+)
MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.
INTERCURRENCIAS:
*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 dias.
*16/04: ITU bacteremica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajsutado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina.

EXAMEN FISICO
SV= FR 18, T 35.7
Diuresis 500 ml en 3 hs. Orina clara.
Apertura ocular espontanea, sin contendio de conciencia, posicion viciosa en flexion.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, edema leve generalizado por hipoalbuminemia, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.
Buena mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando, impresiona no doloroso, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.
Persiste flebits en antebrazo con mejoria y respuesta a la terapeutica , dermatitis del pañal en tratamiento topico. Escara sacra grado 2 sin flogosis, escaras talicas grado 1.

COMENTARIOS:
Paciente en mal estado general, vgi geariatrica con multiples sindromes geriatricos, comorbilidades, internacion prolongada con intercurrencias de indole infecciosa por germenes resistentes, por lo cual presenta alta morbi-mortalidad, con pronostico ominoso a corto plazo. Al momento se encuientra cursando intercurrencia infecciosa por itu bacteremica pór klebsiella pneumoniae sensible a piperacilina-tazobactam, UC: Kpneumonnia sensible a amikacina, Proteus mirabilis sensible a ptz. Ademas HMC positivo para SAMR. Se realiza ic con infectologia, quien indica nueva tomo de hemocultivos e iniciar vancomicina, asociado a piperacilina-tazobactam.
MOCUTLIVOS CONTROL DEL DIA 20/04: positivo para cocos en racimo, pendiente tipificacion.
Por hipernatremia se inicia agua libre por sonda nasogastrica. Por insuficienica renal de probable etiologia prerrenal, se aumenta aporte y se ajustan antibiotico a clearance. Pendiente resultado de laboratorio control para el dia de la fecha.
Paciente con pronostico reservado.
No se presentan familiares para comuncarles el informe clinico de la paciente. Se intenta comunicacion telefonica en varias oportunidades con telefono contacto (hijo) para dar aviso de la situacion critica de su madre. Ante antecedente conocido de transtorno psiquiatrico del hijo, con episodios de violencia hacia medicos y enfermeros en previas visitas e informe medicos, se da aviso a Directora de Departamento, Dra Gasset y se coordina con servicio de psiquiatria el manejo llegado el caso de tener que dar informe presencial del desceso de la paciente.
Se actualizan indicaciones medicas.
Continua control evolutivo.
DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113799 IMPRESO EL 22/04/2020 01:22:42 p.m.

Martiarena Ailen

102

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	23/04/2020	Cama:	18	Días Int.	92

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION:
EVOLUCION CLINICA MEDICA
Dias de internacion 92 - KPC (+)

MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.
INTERCURRENCIAS:
*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 dias.
*16/04: ITU bacteremica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajsutado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina.

EXAMEN FISICO
SV= FR 10 T 36.9
ECAF: 0

Apertura ocular espontanea, sin contendio de conciencia, posicion viciosa en flexion.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, edema leve generalizado por hipoalbuminemia, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.
Buena mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando, impresiona no doloroso, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.
Persiste flebits en antebrazo con mejoria y respuesta a la terapeutica , dermatitis del pañal en tratamiento topico. Escara sacra grado 2 sin flogosis, escaras talicas grado 1.

COMENTARIOS:
Pacietne cursando itnernacion prolongada en clinica medica, de causa social, con multiples itnercurrencias infectologicas, en el contexto de internacion prolongada.
Pacietne que el dia 16/4 presento otina piurica, motivo por el que se realizaron HCT por dos y urocultivo, con rescate de s. aurus y bacilo gram negativo.
se recibe llamado de baceteriologia de presentar SAMR, por lo que continua entratmaeitno ATB con vancomicna
se actualin indicaciones.
Se intenda comunicacion telefonica con el hijo para avisarle de forma telefonica,
se comunica a salud emtnal sobre el contexto del hijo quienes sugieren dar parte medico en forma conjunat

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113807 IMPRESO EL 23/04/2020 09:12:46 a.m.

Gustavo J. Martínez Suzo
Médico
M.N. 158.573

24/04/2020 Infectología

Paciente curso internación prolongada. Actualmente en tratamiento por bacteriemia por SAMR / Kl pneumoniae. con PTZ / VAN ajustado a función renal.

- Hemo (16/4) SAMR + Kl pneumoniae ⑤ PTZ.
- Hemo (20/4) SAMR.

Se sugiere:
- realizar hemocultivos control.
- solicitar urocultivo
- suspender PTZ.
- ecocardiograma / FO.

CABRERA M. CONSTANZA
MEDICA INFECTÓLOGA
M.N. 128126

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	24/04/2020	Cama:	18	Días Int.	93

EVOLUCION CLINICA MEDICA
Dias de internacion 93- KPC (+)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Mujer, 75 años de edad, sindrome demencial, esquizofrenia, VGI previo a internacion: anciana geriatrica.
MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.
INTERCURRENCIAS:
*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 dias de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 dias.
*16/04: ITU bacteremica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajsutado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina. Finaliza en el dia de la fecha PTZ, continua con vancomicina.

EXAMEN FISICO
SV= FR 18, T 35.7
Diuresis 300 ml en 3 hs. Orina clara.
Apertura ocular espontanea, sin contendio de conciencia, posicion viciosa en flexion.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, edema leve generalizado por hipoalbuminemia, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.
Buena mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando, impresiona no doloroso, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.
Persiste flebits en antebrazo con mejoria y respuesta a la terapeutica , dermatitis del pañal en tratamiento topico. Escara sacra grado 2 sin flogosis, escaras talicas grado 1.

COMENTARIOS:
Paciente en mal estado general, VGI previa geriatrica con multiples sindromes geriatricos, comorbilidades, internacion prolongada con intercurrencias de indole infecciosa por germenes resistentes, por lo cual presenta alta morbi-mortalidad- Al momento se encuentra cursando intercurrencia infecciosa por itu bacteremica pór klebsiella pneumoniae sensible a piperacilina-tazobactam, UC: Kpneumonnia sensible a amikacina, Proteus mirabilis sensible a ptz. Ademas HMC positivo para SAMR que se jerarquizan por multiples puertas de entrada a nivel de piel, presenta HMCX2 control del dia 20/4 que continuan positivos para SAMR. Paciente con pronostico ominoso a corto plazo, por lo cual se adecua la intencion terapeurtica a manejo de sintomas y confort, asociado a continuar con antibioticoterapia. No se realizara plan de estudio de bacteremia persistente.
-No se presentan familiares para comuncarles el informe clinico de la paciente.
-Se intenta comunicacion telefonica en varias oportunidades con telefono contacto (hijo) para dar aviso de la situacion critica de su madre. Ante antecedente conocido de transtorno psiquiatrico del hijo, con episodios de violencia hacia medicos y enfermeros en previas visitas e informe medicos, se da aviso a Directora de Departamento, Dra Gasset y se coordina con servicio de psiquiatria el manejo llegado el caso de tener que dar informe presencial del desceso de la paciente.
Se actualizan indicaciones medicas.
Continua control evolutivo.
DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113863 IMPRESO EL 24/04/2020 10:36:34 a.m.

AILEN MARTIARENA
MEDICA U.B.A.
M.N. 153.107

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	27/04/2020	Cama:	18	Días Int.	96

EVOLUCION CLINICA MEDICA
Dias de internacion 96- KPC (+)

ANTECEDENTES PERSONALES:
Mujer, 75 años de edad, sindrome demencial, esquizofrenia, VGI previo a internacion: anciana geriatrica.
MOTIVO DE INTERNACION: Neumonia adquirida de la Comunidad por mecanismo aspirativo, con tratamiento antibiotico con AMS con HMC negativos.
INTERCURRENCIAS:
*ITU por EVR sensible a linezolid finalizado 10/02.
*21/3 con sepsis a foco endovascular con rescate de SAMR y a foco urinario con rescate de Pseudomona Aeruginosa sensible a PTZ-Ceftazidima y E. Coli sensible a PTZ-Ceftazidima-Gentamicina, habiendo cumplido 7 días de tratamiento con PTZ y finalizando vancomicina por 14 dias.
*16/04: ITU bacteremica por Klebsiella pneumoniae sensible a ptz y SAMR, en tratamiento ajsutado a sensibilidad con piperacilina-tazobactam y vancomicina. Finaliza en el dia de la fecha PTZ, continua con vancomicina.

EXAMEN FISICO
SV= FR 18, T 35.2
Apertura ocular espontanea, sin contendio de conciencia, posicion viciosa en flexion.
R1 /R2 en 4 focos, Soplo Sistolico 3/6 audibles en 4 focos con irradiacion a cuello, edema leve generalizado por hipoalbuminemia, tolerando decubito y sin signos de falla aguda de bomba.
Buena mecanica ventilatoria , hipoventilacion global por falta de colaboracion, sin ruidos agregados.
Abdomen globoso, blando, impresiona no doloroso, no se palpan visceromegalias con RHA conservados. Catarsis positiva, ritmo diuretico conservado.
Persiste flebits en antebrazo con mejoria y respuesta a la terapeutica , dermatitis del pañal en tratamiento topico. Escara sacra grado 2 sin flogosis, escaras talicas grado 1.

COMENTARIOS:
Paciente en mal estado general, VGI previa geriatrica con multiples sindromes geriatricos, comorbilidades, internacion prolongada con intercurrencias de indole infecciosa por germenes resistentes, por lo cual presenta alta morbi-mortalidad- Al momento se encuentra cursando intercurrencia infecciosa por itu bacteremica pór klebsiella pneumoniae sensible a piperacilina-tazobactam, UC: Kpneumonnia sensible a amikacina, Proteus mirabilis sensible a ptz. Ademas HMC positivo para SAMR que se jerarquizan por multiples puertas de entrada a nivel de piel, presenta HMCX2 control del dia 20/4 que continuan positivos para SAMR. Paciente con pronostico ominoso a corto plazo, por lo cual se adecua la intencion terapeurtica a manejo de sintomas y confort, asociado a continuar con antibioticoterapia. No se realizara plan de estudio de bacteremia persistente.
-No se presentan familiares para comuncarles el informe clinico de la paciente.
-Se intenta comunicacion telefonica en varias oportunidades con telefono contacto (hijo) para dar aviso de la situacion critica de su madre. Ante antecedente conocido de transtorno psiquiatrico del hijo, con episodios de violencia hacia medicos y enfermeros en previas visitas e informe medicos, se da aviso a Directora de Departamento, Dra Gasset y se coordina con servicio de psiquiatria el manejo llegado el caso de tener que dar informe presencial del desceso de la paciente.
Se actualizan indicaciones medicas.
Continua control evolutivo.
DRA. AILEN MARTIARENA CLINICA MEDICA MN 153107

IDPTE506485IDCM7135IDCMED113910 IMPRESO EL 27/04/2020 10:41:15 a.m.

AILEN MARTIARENA
MEDICA U.B.A.
M.N. 153.107

105

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

UNIDAD 1 DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

Nombre y Apellido	KUCHASKY, MARGARITA LEONOR			HC Nº	402454
Fecha:	28/04/2020	Cama:	18	Días Int.	97

DIAGNOSTICO:
*Infección a foco respiratorio por una Neumonía Adquirida de la Comunidad Bilateral
*Anemia sin criterios transfusionales (crónica vs carencial)

EVOLUCION DE GUARDIA:
Siendo las 00:20 hs , se acude a llamado de enfermeria por encontrase a la paciente sin signos vitales.
Se constata paciente sin ruidos cardiacos, ni pulsos centrales por lo que siendo las 00:30 hs , se constata obito de la paciente KUCHASKY MARGARITA LEONOR , DNI 4214110 con HC 402454.
Se intenta comunicacion telefonica con familiar (hijo) sin exito, se deja mensaje en buzon de llamadas.
Se llenan formularios pertinentes
Se traslada obito a la morgue de este hospital.

IDPTE50648SIDCM7135IDCMED113945 IMPRESO EL 28/04/2020 01:24:33 a.m.



106

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2150030**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado		Fecha:	20/04/20 14:32
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 1 | Cama: 18		**Página 1 de 1**

MICROBIOLOGIA

Resultados

Jefe de Sección: **Juan Andres Stupka | Bioquímico | M.N. 7528**

HEMOCULTIVO, MUESTRA 1

Coloración de Gram	**Cocos Gram positivos**		
Cultivo	**Se obtuvo desarrollo**		
Identificación del Germen	***Staphylococcus aureus***		
ANTIBIOGRAMA	**CIM**		**Interpretación**
Vancomicina	1,0	µg/ml	Sensible
Observaciones	**Este microorganismo es METICILINO RESISTENTE, lo cual implica Resistencia a todos los B-lactámicos (excepto Ceftarolina) incluidos todas las combinaciones con inhibidores de B-lactamasas.**		

HEMOCULTIVO, MUESTRA 2

Coloración de Gram	**Cocos Gram positivos**
Cultivo	**Se obtuvo desarrollo**
Identificación del Germen	***Staphylococcus coagulasa-negativo***

Resultados validados electrónicamente por:

Flavia Alejandra Arnalfa
Bioquímica - M.N. 9641

(107)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2150156**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado		Fecha:	21/04/20 09:52
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 1 | Cama: 18		**Página 1 de 2**

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados			Valores de Referencia	
HEMOGRAMA					
Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire					
SERIE ERITROCITARIA					
Eritrocitos	**3,09**	*10^12/L		3,88 - 4,99 *10^12/L	
Hemoglobina	**8,3**	g/dl		11,8 - 14,8 g/dl	
Hematocrito	**27,7**	%		36,0 - 44,0 %	
Indices Hematimétricos					
Volumen Corpuscular Medio	**89,8**	fL		80,5 - 100,0 fL	
Hemoglobina Corpuscular Media	**26,8**	pg		26,0 - 34,0 pg	
Concentración de Hb Corpuscular Media	**29,8**	g/dl		31,6 - 37,5 g/dl	
Amplitud de Distribución eritrocitaria	**17,5**	%		11,6 - 13,9 %	
Eritroblastos	**1,00**	%			
NRBC	**0,125**	*10^9/L			
SERIE PLAQUETARIA					
Plaquetas	**AGLUTINACION PLAQUETARIA PLAQUETAS NORMALES EN FROTIS**			130,0 - 350,0 *10^9/L	
SERIE LEUCOCITARIA					
Leucocitos	**12,50**	*10^9/L		3,90 - 11,10 *10^9/L	
Fórmula Leucocitaria					
Metamielocitos	**1,00**	%		0%	
Neutrófilos Segmentados	**86,00**	%	**10.75** *10^9/L	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 *10^9/L
Linfocitos	**11,00**	%	**1.38** *10^9/L	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 *10^9/L
Monocitos	**2,00**	%	**0.25** *10^9/L	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 *10^9/L
Eosinófilos	**0,00**	%	**0.00** *10^9/L	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 *10^9/L
Basófilos	**0,00**	%	**0.00** *10^9/L	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 *10^9/L
Relación Neutrófilos / Linfocitos	**7,82**				
Observaciones	**HIPOCROMIA LEVE ANISOCROMIA ANISOCITOSIS LEVE POIQUILOCITOSIS LEVE: ELIPTOCITOS ROULEAUX POLIMORFONUCLEARES CON GRANULACIONES GROSERAS POLIMORFONUCLEARES HIPERSEGMENTADOS**				
ERITROSEDIMENTACION	**99**	mm		1 - 16 mm	

Resultados validados electrónicamente por:

María Inés Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

108

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**	N° Orden:	**2150156**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha:	21/04/20 09:52
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18		**Página 2 de 2**

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	**128**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	**184**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	**3,08**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	175	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	3,5	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	134	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquimico - M.N. 11028

[PÁGINA SUPRIMIDA]

(Página 203 del documento original)

Laboratorio de NE con DNI terminado en 2

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2149829**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 20/04/20 09:17

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados			Valores de Referencia	
HEMOGRAMA					
Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire					
SERIE ERITROCITARIA					
Eritrocitos	**2,91**	*10^12/L		3,88 - 4,99 *10^12/L	
Hemoglobina	**7,6**	g/dl		11,8 - 14,8 g/dl	
Hematocrito	**26,2**	%		36,0 - 44,0 %	
Indices Hematimétricos					
Volumen Corpuscular Medio	**89,8**	fL		80,5 - 100,0 fL	
Hemoglobina Corpuscular Media	**26,0**	pg		26,0 - 34,0 pg	
Concentración de Hb Corpuscular Media	**29,0**	g/dl		31,6 - 37,5 g/dl	
Amplitud de Distribución eritrocitaria	**17,5**	%		11,6 - 13,9 %	
SERIE PLAQUETARIA					
Plaquetas	**AGLUTINACION PLAQUETARIA PLAQUETAS NORMALES EN FROTIS**			130,0 - 350,0 *10^9/L	
SERIE LEUCOCITARIA					
Leucocitos	**10,60**	*10^9/L		3,90 - 11,10 *10^9/L	
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	**80,80**	%	**8.56** *10^9/L	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 *10^9/L
Linfocitos	**15,80**	%	**1.67** *10^9/L	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 *10^9/L
Monocitos	**1,60**	%	**0.17** *10^9/L	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 *10^9/L
Eosinófilos	**1,58**	%	**0.17** *10^9/L	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 *10^9/L
Basófilos	**0,23**	%	**0.02** *10^9/L	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 *10^9/L
Relación Neutrófilos / Linfocitos	**5,11**				
Observaciones	**POLIMORFONUCLEARES CON GRANULACIONES GROSERAS HIPOCROMIA LEVE ANISOCROMIA ANISOCITOSIS LEVE POIQUILOCITOSIS REGULAR: ELIPTOCITOS ROULEAUX**				

Resultados validados electrónicamente por:

María Inés Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

QUIMICA CLINICA

Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**

	Resultados		Valores de Referencia
GLUCEMIA	**99**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa			

111

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2149829**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 20/04/20 09:17

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	**165**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	**3,23**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
HEPATOGRAMA Método: Automatizado			
Colesterol Total	**82**	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
Bilirrubina Total	**0,23**	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa	**0,17**	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta	**0,06**	mg/dl	
Fosfatasa Alcalina	**82**	UI/L	40 - 130 UI/L
TGO	**27**	UI/L	5 - 34 UI/L
TGP	**13**	UI/L	8 - 40 UI/L
Proteinas Totales	**4,7**	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
PROTEINAS TOTALES, SANGRE Método: Colorimétrico	**4,7**	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
ALBUMINA Método: Colorimétrico	**1,8**	g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
CALCIO, SANGRE Método: Colorimétrico	**7,5**	mg/dl	8.5 - 10.4 mg/dl (2c 9.26
FOSFORO, SANGRE Método: UV	**3,9**	mg/dl	2,4 - 4,7 mg/dl
MAGNESIO Método: Colorimétrico	**2,28**	mg/dl	1,6 - 2,55 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	**179**	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	**3,6**	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L

112

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2149829**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado		Fecha:	20/04/20 09:17
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 1 | Cama: 18		**Página 3 de 3**

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
Cloro	**139**	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

(113)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**5030013**
DNI	: 4214110	Profesional Solicitante:	MARTINEZ SUSO GUSTAVO	Fecha:	20/04/20 14:33
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 1 | Cama: 11		

HEMATOLOGIA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
HEMOGRAMA			
Método: Automatizado			
Hematocrito	**26,0**	%	36,0 - 44,0 %
Hemoglobina	**7,6**	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
VCM	**88,7**	fL	80,5 - 100,0 fL
Leucocitos	**10,69**	*10^9/L	3,90 - 11,10 *10^9/L
Fórmula Leucocitaria			
Neutrófilos	**87,0**	%	36 - 66 %
Linfocitos	**10,6**	%	22 - 40 %
Monocitos	**1,1**	%	4 - 11 %
Eosinófilos	**0,9**	%	1 - 5 %
Basófilos	**0,4**	%	0 - 1 %
Plaquetas	**182,2**	*10^9/L	130,0 - 350,0 *10^9/L
COAGULOGRAMA			
Método: Automatizado			
RIN	**3,08**		0,90 - 1,20
APTT	**28**	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Analia Gonzalez
Bioquimica - M.N. 9052

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
GLUCEMIA	**109**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa			
UREA, SANGRE	**172**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
Método: Cinético UV			
CREATININA, SANGRE	**3,11**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
Método: Cinético Colorimétrico			
ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO)	**31**	UI/L	5 - 34 UI/L
Método: Cinético UV			
ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP)	**14**	UI/L	8 - 40 UI/L
Método: Cinético UV			

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687
Coordinadora del Laboratorio de Guardia. Dra. Rosana Russo | M.N. 6695

Buenos Aires Ciudad

114

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **5030013**

DNI : 4214110 Profesional Solicitante: MARTINEZ SUSO GUSTAVO Fecha: 20/04/20 14:33

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 11

QUIMICA CLINICA	Resultados		Valores de Referencia
FOSFATASA ALCALINA Método: Cinético Colorimétrico	87	UI/L	40 - 130 UI/L
BILIRRUBINA TOTAL Método: Colorimétrico	0,37	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
BILIRRUBINA DIRECTA Método: Colorimétrico	0,24	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
PROTEINAS TOTALES, SANGRE Método: Colorimétrico	4,9	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
ALBUMINA Método: Colorimétrico	2,0	g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	178	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	3,4	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	137	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Analia Gonzalez
Bioquimica - M.N. 9052

Material remitido al Laboratorio

Fecha de impresión: 20/04/2020 18:26

(116)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2145724**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 20/03/20 13:47

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

MICROBIOLOGIA

Resultados

Jefe de Sección: **Juan Andres Stupka | Bioquímico | M.N. 7528**

UROCULTIVO

Tipo de Muestra	Orina Recambio Sonda		
Sedimento	/Escasa muestra		
Examen Bacteriológico			
Cultivo	Positivo		
Recuento de colonias	Mayor a 100.000 U.F.C./ml		
Identificación del Germen	*Pseudomonas aeruginosa*		
ANTIBIOGRAMA	**CIM**		**Interpretación**
Ceftazidima	2	µg/ml	Sensible
Ciprofloxacina	0.,25	µg/ml	Sensible
Gentamicina	<=2	µg/ml	Sensible
Piperacilina Tazobactam	<=4/4	µg/ml	Sensible
Observaciones	//*Citrobacter koseri presenta Resistencia natural a las amino y carboxipenicilinas.		
Identificación del Germen	*Escherichia coli*		
ANTIBIOGRAMA	**CIM**		**Interpretación**
Ampicilina	>16	µg/ml	Resistente
Ampicilina Sulbactam	16/8	µg/ml	Intermedio
Ceftazidima	<=1	µg/ml	Sensible
Ciprofloxacina	>2	µg/ml	Resistente
Gentamicina	<=2	µg/ml	Sensible
Piperacilina Tazobactam	<=4/4	µg/ml	Sensible
Trimetoprima Sulfametoxazol	>2/38	µg/ml	Resistente
Identificación del Germen	*Citrobacter koseri*		
ANTIBIOGRAMA	**CIM**		**Interpretación**
Amoxicilina/Acido Clavulánico	<=4/2	µg/ml	Sensible
Ceftazidima	<=1	µg/ml	Sensible
Ciprofloxacina	<=0,125	µg/ml	Sensible
Gentamicina	<=2	µg/ml	Sensible
Piperacilina Tazobactam	<=4/4	µg/ml	Sensible
Trimetoprima Sulfametoxazol	<=0,5/9,5	µg/ml	Sensible

Resultados validados electrónicamente por:

Romina Daniela Volcovich
Bioquímica - M.N. 10140

(117)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2146277**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 27/03/20 09:34

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados			Valores de Referencia	
HEMOGRAMA					
Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire					
SERIE ERITROCITARIA					
Eritrocitos	3,45	*10^12/L		3,88 - 4,99 *10^12/L	
Hemoglobina	9,6	g/dl		11,8 - 14,8 g/dl	
Hematocrito	29,9	%		36,0 - 44,0 %	
Indices Hematimétricos					
Volumen Corpuscular Medio	86,5	fL		80,5 - 100,0 fL	
Hemoglobina Corpuscular Media	27,8	pg		26,0 - 34,0 pg	
Concentración de Hb Corpuscular Media	32,1	g/dl		31,6 - 37,5 g/dl	
Amplitud de Distribución eritrocitaria	16,2	%		11,6 - 13,9 %	
SERIE PLAQUETARIA					
Plaquetas	270,0	*10^9/L		130,0 - 350,0 *10^9/L	
Volumen Plaquetario Medio	7,4	fL		7,6 - 11,0 fL	
Amplitud de ditribucion plaquetaria	15,6	%		15,0 - 17,2 %	
Plaquetocrito	0,200	%		0,100 - 0, 600 %	
SERIE LEUCOCITARIA					
Leucocitos	5,30	*10^9/L		3,90 - 11,10 *10^9/L	
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	69,60	%	**3.69** *10^9/L	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 *10^9/L
Linfocitos	21,30	%	**1.13** *10^9/L	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 *10^9/L
Monocitos	6,11	%	**0.32** *10^9/L	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 *10^9/L
Eosinófilos	2,60	%	**0.14** *10^9/L	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 *10^9/L
Basófilos	0,44	%	**0.02** *10^9/L	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 *10^9/L
ERITROSEDIMENTACION	25	mm		1 - 16 mm	

Resultados validados electrónicamente por:

Maria Ines Zanotto
Bioquimica - M.N. 6669

HEMOSTASIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados	Valores de Referencia
COAGULOGRAMA		
Método: Coagulométrico | ACL Top 300		
RIN	2,93	0,90 - 1,20

118

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2146277**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 27/03/20 09:34

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

HEMOSTASIA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**			
APTT	38	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ana Maria Dorr
Bioquimica - M.N. 7951

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	81	mg/dl	70 - 110 mg/dl
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	25	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	0,81	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
HEPATOGRAMA Método: Automatizado			
Colesterol Total	108	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
Bilirrubina Total	0,25	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa	0,16	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta	0,09	mg/dl	
Fosfatasa Alcalina	110	UI/L	40 - 130 UI/L
TGO	20	UI/L	5 - 34 UI/L
TGP	17	UI/L	8 - 40 UI/L
Proteinas Totales	5,1	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	147	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	3,7	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	111	mmol/L	90 - 110 mmol/L

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2146277**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 27/03/20 09:34

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
PROTEINA C REACTIVA (PCR) Método: Inmunoturbidimetría	65	mg/l	0 - 5 mg/l

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607

ANALISIS PENDIENTES

VANCOMICINA

[PÁGINA SUPRIMIDA]

(Página 223 del documento original)

Laboratorio de FM con DNI terminado en 0

121

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687
Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **5027377**

DNI : 4214110 Profesional Solicitante: VALENTI FLORENCIA Fecha: 25/03/20 09:52

Origen : **GUARDIA** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

MEDIO INTERNO	**Resultados**		**Valores de Referencia**
ESTADO ACIDO BASE			
pH Método: Automatizado	7,427		7.350 a 7.450
pCO2	26,7	mmHg	35,0 - 45,0 mmHg
pO2	103	mmHg	83.0 - 108.0 mmHg
cHCO3	17,2	mmol/L	22,0 - 26,0 mmol/L
EB	-6,1	mmol/L	-3 / +3
sO2	98	%	94 - 98 %
O2Hb	96	%	80 - 97 %
Lactato Método: ISE Indirecto	0,73	mmol/L	0,20 - 2,00mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Maricel Alejandra Lugo
Bioquímica - M.N. 10466

Material remitido al Laboratorio

Fecha de impresión: 25/03/2020 10:18

122

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687
Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **5027067**

DNI : 4214110 Profesional Solicitante: MARTIARENA AILEN Fecha: 21/03/20 22:08

Origen : **GUARDIA** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

MEDIO INTERNO	**Resultados**		**Valores de Referencia**
ESTADO ACIDO BASE			
pH Método: Automatizado	7,374		7.350 a 7.450
pCO2	14,3	mmHg	35,0 - 45,0 mmHg
pO2	114	mmHg	83.0 - 108.0 mmHg
cHCO3	8,1	mmol/L	22,0 - 26,0 mmol/L
EB	-13,8	mmol/L	-3 / +3
sO2	98	%	94 - 98 %
O2Hb	97	%	80 - 97 %
Lactato Método: ISE Indirecto	1,90	mmol/L	0,20 - 2,00mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Juan Alberto Guzman
Bioquimico - M.N. 3651

Material remitido al Laboratorio

Fecha de impresión: 21/03/2020 22:44

123

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687
Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **5027067**

DNI : 4214110 Profesional Solicitante: MARTIARENA AILEN Fecha: 21/03/20 22:08

Origen : **GUARDIA** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

QUIMICA CLINICA	Resultados		Valores de Referencia
FOSFATASA ALCALINA Método: Cinético Colorimétrico	85	UI/L	40 - 130 UI/L
BILIRRUBINA TOTAL Método: Colorimétrico	0,23	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
BILIRRUBINA DIRECTA Método: Colorimétrico	0,14	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
ALBUMINA Método: Colorimétrico	2,2	g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
CALCIO, SANGRE Método: Colorimétrico	7,8	mg/dl	8.5 - 10.4 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	124	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	3,9	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	89	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Juan Alberto Guzman
Bioquimico - M.N. 3651

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO DE GUARDIA
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester M.N. 7687
Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**	N° Orden:	**5027067**
DNI	: 4214110	Profesional Solicitante: MARTIARENA AILEN	Fecha:	21/03/20 22:08
Origen	: **GUARDIA**	CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18		

HEMATOLOGIA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
HEMOGRAMA			
Método: Automatizado			
Hematocrito	**25,6**	%	36,0 - 44,0 %
Hemoglobina	**8,3**	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
VCM	**82,7**	fL	80,5 - 100,0 fL
Leucocitos	**7,93**	*10^9/L	3,90 - 11,10 *10^9/L
Fórmula Leucocitaria			
Neutrófilos	**87,2**	%	36 - 66 %
Linfocitos	**8,3**	%	22 - 40 %
Monocitos	**2,7**	%	4 - 11 %
Eosinófilos	**1,0**	%	1 - 5 %
Basófilos	**0,8**	%	0 - 1 %
Plaquetas	**181,6**	*10^9/L	130,0 - 350,0 *10^9/L
COAGULOGRAMA			
Método: Automatizado			
RIN	**2,07**		0,90 - 1,20
APTT	**23**	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Juan Alberto Guzman
Bioquímico - M.N. 3651

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
GLUCEMIA	**247**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa			
UREA, SANGRE	**42**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
Método: Cinético UV			
CREATININA, SANGRE	**1,05**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
Método: Cinético Colorimétrico			
ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO)	**28**	UI/L	5 - 34 UI/L
Método: Cinético UV			
ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP)	**16**	UI/L	8 - 40 UI/L
Método: Cinético UV			

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**	N° Orden: **2143847**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha: 13/03/20 08:46
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18	

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados		Valores de Referencia	
HEMOGRAMA				
Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire				
SERIE ERITROCITARIA				
Eritrocitos	3,76 -	*10^12/L	3,88 - 4,99 *10^12/L	
Hemoglobina	10,5 -	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl	
Hematocrito	33,2	%	36,0 - 44,0 %	
Indices Hematimétricos				
Volumen Corpuscular Medio	88,3	fL	80,5 - 100,0 fL	
Hemoglobina Corpuscular Media	27,8	pg	26,0 - 34,0 pg	
Concentración de Hb Corpuscular Media	31,5	g/dl	31,6 - 37,5 g/dl	
Amplitud de Distribución eritrocitaria	15,2	%	11,6 - 13,9 %	
SERIE PLAQUETARIA				
Plaquetas	265,0 -	*10^9/L	130,0 - 350,0 *10^9/L	
Volumen Plaquetario Medio	7,7	fL	7,6 - 11,0 fL	
Amplitud de ditribucion plaquetaria	16,1	%	15,0 - 17,2 %	
Plaquetocrito	0,203	%	0,100 - 0, 600 %	
SERIE LEUCOCITARIA				
Leucocitos	8,26	*10^9/L	3,90 - 11,10 *10^9/L	
Fórmula Leucocitaria				
Neutrófilos Segmentados	76,30	% **6.30** *10^9/L	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 *10^9/L
Linfocitos	12,10	% **1.00** *10^9/L	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 *10^9/L
Monocitos	9,57	% **0.79** *10^9/L	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 *10^9/L
Eosinófilos	1,52	% **0.13** *10^9/L	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0.67 *10^9/L
Basófilos	0,42	% **0.03** *10^9/L	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 *10^9/L
ERITROSEDIMENTACION	50	mm	1 - 16 mm	

Resultados validados electrónicamente por:

María Inés Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

HEMOSTASIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados		Valores de Referencia
COAGULOGRAMA			
Método: Coagulométrico | ACL Top 300			
RIN	1,22		0,90 - 1,20
Fibrinógeno	585	mg/dl	216 - 448 mg/dl

(125)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2143847**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 13/03/20 08:46

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 1 | Cama: 18

HEMOSTASIA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**			
APTT	**27**	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ana Maria Dorr
Bioquímica - M.N. 7951

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	**110**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	**20**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	**0,67**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
HEPATOGRAMA Método: Automatizado			
Colesterol Total	**152**	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
Bilirrubina Total	**0,50**	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa	**0,21**	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta	**0,29**	mg/dl	
Fosfatasa Alcalina	**88**	UI/L	40 - 130 UI/L
TGO	**15**	UI/L	5 - 34 UI/L
TGP	**10**	UI/L	8 - 40 UI/L
Proteinas Totales	**6,1**	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
PROTEINAS TOTALES, SANGRE Método: Colorimétrico	**6,1**	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
ALBUMINA Método: Colorimétrico	**3,3**	g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
CALCIO, SANGRE Método: Colorimétrico	**9,0**	mg/dl	8.5 - 10.4 mg/dl
FOSFORO, SANGRE Método: UV	**4,3**	mg/dl	2,4 - 4,7 mg/dl

(126)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2143847**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado		Fecha:	13/03/20 08:46
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 1 | Cama: 18		**Página 3 de 3**

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
MAGNESIO	**1,81**	mg/dl	1,6 - 2,55 mg/dl
Método: Colorimétrico			
IONOGRAMA			
Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	**141**	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	**4,1**	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	**101**	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

(129)

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2140258**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 02/03/20 09:11

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados			Valores de Referencia	
HEMOGRAMA					
Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire					
SERIE ERITROCITARIA					
Eritrocitos	**3,74**	*10^12/L		3,88 - 4,99 *10^12/L	
Hemoglobina	**10,3**	g/dl		11,8 - 14,8 g/dl	
Hematocrito	**33,1**	%		36,0 - 44,0 %	
Indices Hematimétricos					
Volumen Corpuscular Medio	**88,6**	fL		80,5 - 100,0 fL	
Hemoglobina Corpuscular Media	**27,6**	pg		26,0 - 34,0 pg	
Concentración de Hb Corpuscular Media	**31,2**	g/dl		31,6 - 37,5 g/dl	
Amplitud de Distribución eritrocitaria	**15,8**	%		11,6 - 13,9 %	
SERIE PLAQUETARIA					
Plaquetas	**292,0**	*10^9/L		130,0 - 350,0 *10^9/L	
Volumen Plaquetario Medio	**8,1**	fL		7,6 - 11,0 fL	
Amplitud de ditribucion plaquetaria	**16,2**	%		15,0 - 17,2 %	
Plaquetocrito	**0,236**	%		0,100 - 0, 600 %	
SERIE LEUCOCITARIA					
Leucocitos	**5,31**	*10^9/L		3,90 - 11,10 *10^9/L	
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	**56,40**	%	**2.99** *10^9/L	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 *10^9/L
Linfocitos	**30,40**	%	**1.61** *10^9/L	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 *10^9/L
Monocitos	**8,77**	%	**0.47** *10^9/L	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 *10^9/L
Eosinófilos	**3,76**	%	**0.20** *10^9/L	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 *10^9/L
Basófilos	**0,71**	%	**0.04** *10^9/L	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 *10^9/L
ERITROSEDIMENTACION	**59**	mm		1 - 16 mm	

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustín Migliore
Bioquímico - M.N. 11408

QUIMICA CLINICA

Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**

	Resultados		Valores de Referencia
GLUCEMIA	**113**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa			
UREA, SANGRE	**24**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
Método: Cinético UV			

128

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2140258**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado		Fecha:	02/03/20 09:11
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 4 | Cama: 4		

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
CREATININA, SANGRE	**0,68**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
Método: Cinético Colorimétrico			
IONOGRAMA			
Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	**140**	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	**4,4**	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	**102**	mmol/L	90 - 110 mmol/L
PROTEINA C REACTIVA (PCR)	**39**	mg/l	0 - 5 mg/l
Método: Inmunoturbidimetría			

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

129

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2139126**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado		Fecha:	26/02/20 10:28
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 4 | Cama: 4		**Página 1 de 1**

MICROBIOLOGIA **Resultados**

Jefe de Sección: **Juan Andres Stupka | Bioquímico | M.N. 7528**

HISOPADO RECTAL

Cultivo	**Positivo**
Observaciones	**Con antecedentesprevios de KPC (+)**

Resultados validados electrónicamente por:

Flavia Alejandra Amalfa
Bioquímica - M.N. 9641

130

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2139618**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 27/02/20 10:23

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados			Valores de Referencia	
HEMOGRAMA					
Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire					
SERIE ERITROCITARIA					
Eritrocitos	**3,59**	*10^12/L		3,88 - 4,99 *10^12/L	
Hemoglobina	**10,1**	g/dl		11,8 - 14,8 g/dl	
Hematocrito	**32,4**	%		36,0 - 44,0 %	
Indices Hematimétricos					
Volumen Corpuscular Medio	**90,3**	fL		80,5 - 100,0 fL	
Hemoglobina Corpuscular Media	**28,1**	pg		26,0 - 34,0 pg	
Concentración de Hb Corpuscular Media	**31,1**	g/dl		31,6 - 37,5 g/dl	
Amplitud de Distribución eritrocitaria	**15,8**	%		11,6 - 13,9 %	
SERIE PLAQUETARIA					
Plaquetas	**292,0**	*10^9/L		130,0 - 350,0 *10^9/L	
Volumen Plaquetario Medio	**8,0**	fL		7,6 - 11,0 fL	
Amplitud de ditribucion plaquetaria	**16,1**	%		15,0 - 17,2 %	
Plaquetocrito	**0,233**	%		0,100 - 0, 600 %	
SERIE LEUCOCITARIA					
Leucocitos	**5,13**	*10^9/L		3,90 - 11,10 *10^9/L	
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	**59,20**	%	**3.04** *10^9/L	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 *10^9/L
Linfocitos	**25,30**	%	**1.30** *10^9/L	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 *10^9/L
Monocitos	**10,00**	%	**0.51** *10^9/L	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 *10^9/L
Eosinófilos	**4,86**	%	**0.25** *10^9/L	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 *10^9/L
Basófilos	**0,56**	%	**0.03** *10^9/L	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 *10^9/L
ERITROSEDIMENTACION	**49**	mm		1 - 16 mm	

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustin Migliore
Bioquímico - M.N. 11408

HEMOSTASIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados	Valores de Referencia
COAGULOGRAMA		
Método: Coagulométrico | ACL Top 300		
RIN	**1,01**	0,90 - 1,20

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2139618**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 27/02/20 10:23

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

HEMOSTASIA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**			
APTT	**28**	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ana Maria Dorr
Bioquimica - M.N. 7951

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	**86**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	**27**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	**0,69**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	**137**	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	**4,6**	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	**101**	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquimica - M.N. 8607

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**	N° Orden:	**2137074**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha:	17/02/20 09:23
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4		

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados			Valores de Referencia	
HEMOGRAMA					
Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire					
SERIE ERITROCITARIA					
Eritrocitos	**3,27**	*10^12/L		3,88 - 4,99 *10^12/L	
Hemoglobina	**9,2**	g/dl		11,8 - 14,8 g/dl	
Hematocrito	**29,0**	%		36,0 - 44,0 %	
Indices Hematimétricos					
Volumen Corpuscular Medio	**88,7**	fL		80,5 - 100,0 fL	
Hemoglobina Corpuscular Media	**28,2**	pg		26,0 - 34,0 pg	
Concentración de Hb Corpuscular Media	**31,8**	g/dl		31,6 - 37,5 g/dl	
Amplitud de Distribución eritrocitaria	**15,9**	%		11,6 - 13,9 %	
SERIE PLAQUETARIA					
Plaquetas	**200,0**	*10^9/L		130,0 - 350,0 *10^9/L	
Volumen Plaquetario Medio	**7,8**	fL		7,6 - 11,0 fL	
Amplitud de ditribucion plaquetaria	**15,5**	%		15,0 - 17,2 %	
Plaquetocrito	**0,156**	%		0,100 - 0, 600 %	
SERIE LEUCOCITARIA					
Leucocitos	**5,57**	*10^9/L		3,90 - 11,10 *10^9/L	
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	**59,00**	%	**3.29** *10^9/L	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 *10^9/L
Linfocitos	**24,40**	%	**1.36** *10^9/L	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 *10^9/L
Monocitos	**11,00**	%	**0.61** *10^9/L	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 *10^9/L
Eosinófilos	**4,95**	%	**0.28** *10^9/L	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 *10^9/L
Basófilos	**0,64**	%	**0.04** *10^9/L	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 *10^9/L
ERITROSEDIMENTACION	**29**	mm		1 - 16 mm	

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustin Migliore
Bioquimico - M.N. 11408

HEMOSTASIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados		Valores de Referencia
COAGULOGRAMA			
Método: Coagulométrico | ACL Top 300			
RIN	**1,17**		0,90 - 1,20
Fibrinógeno	**365**	mg/dl	216 - 448 mg/dl

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**	N° Orden:	**2137074**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha:	17/02/20 09:23
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4		

HEMOSTASIA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**			
APTT	**27**	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustin Migliore
Bioquimico - M.N. 11408

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	**97**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	**21**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	**0,63**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
HEPATOGRAMA Método: Automatizado			
Colesterol Total	**161**	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
Bilirrubina Total	**0,31**	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa	**0,16**	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta	**0,15**	mg/dl	
Fosfatasa Alcalina	**78**	UI/L	40 - 130 UI/L
TGO	**18**	UI/L	5 - 34 UI/L
TGP	**25**	UI/L	8 - 40 UI/L
Proteinas Totales	**5,8**	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
PROTEINAS TOTALES, SANGRE Método: Colorimétrico	**5,8**	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
ALBUMINA Método: Colorimétrico Cor 9,26	**3,3**	g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
CALCIO, SANGRE Método: Colorimétrico	**8,7**	mg/dl	8.5 - 10.4 mg/dl
FOSFORO, SANGRE Método: UV	**3,3**	mg/dl	2,4 - 4,7 mg/dl

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**	N° Orden:	**2137074**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha:	17/02/20 09:23
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4		**Página 3 de 3**

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
MAGNESIO Método: Colorimétrico	**1,83**	mg/dl	1,6 - 2,55 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	**146**	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	**4,1**	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	**109**	mmol/L	90 - 110 mmol/L
PROTEINA C REACTIVA (PCR) Método: Inmunoturbidimetría	**17**	mg/l	0 - 5 mg/l

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**	N° Orden:	**2135161**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha:	10/02/20 10:29
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4		

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados			Valores de Referencia	
HEMOGRAMA					
Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire					
SERIE ERITROCITARIA					
Eritrocitos	**3,59**	*10^12/L		3,88 - 4,99 *10^12/L	
Hemoglobina	**10,3**	g/dl		11,8 - 14,8 g/dl	
Hematocrito	**32,3**	%		36,0 - 44,0 %	
Indices Hematimétricos					
Volumen Corpuscular Medio	**90,0**	fL		80,5 - 100,0 fL	
Hemoglobina Corpuscular Media	**28,8**	pg		26,0 - 34,0 pg	
Concentración de Hb Corpuscular Media	**32,0**	g/dl		31,6 - 37,5 g/dl	
Amplitud de Distribución eritrocitaria	**16,4**	%		11,6 - 13,9 %	
SERIE PLAQUETARIA					
Plaquetas	**213,0**	*10^9/L		130,0 - 350,0 *10^9/L	
Volumen Plaquetario Medio	**7,1**	fL		7,6 - 11,0 fL	
Amplitud de ditribucion plaquetaria	**16,6**	%		15,0 - 17,2 %	
Plaquetocrito	**0,152**	%		0,100 - 0, 600 %	
SERIE LEUCOCITARIA					
Leucocitos	**4,45**	*10^9/L		3,90 - 11,10 *10^9/L	
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	**69,60**	%	**3.10** *10^9/L	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 *10^9/L
Linfocitos	**19,60**	%	**0.87** *10^9/L	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 *10^9/L
Monocitos	**5,30**	%	**0.24** *10^9/L	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 *10^9/L
Eosinófilos	**4,58**	%	**0.20** *10^9/L	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 *10^9/L
Basófilos	**0,88**	%	**0.04** *10^9/L	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 *10^9/L
ERITROSEDIMENTACION	**34**	mm		1 - 16 mm	

Resultados validados electrónicamente por:

Maria Ines Zanotto
Bioquimica - M.N. 6669

HEMOSTASIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados		Valores de Referencia
COAGULOGRAMA			
Método: Coagulométrico | ACL Top 300			
RIN	1,14		0,90 - 1,20
Fibrinógeno	441	mg/dl	216 - 448 mg/dl

136

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2135161**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado		Fecha:	10/02/20 10:29
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 4 | Cama: 4		

HEMOSTASIA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**			
APTT	**31**	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Monica Viviana Zarfino
Bioquimica - M.N. 3402

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	**157**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	**8**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	**0,57**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
HEPATOGRAMA Método: Automatizado			
Colesterol Total	**172**	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
ilirrubina Total	**0,31**	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa	**0,16**	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta	**0,15**	mg/dl	
Fosfatasa Alcalina	**84**	UI/L	40 - 130 UI/L
TGO	**15**	UI/L	5 - 34 UI/L
TGP	**22**	UI/L	8 - 40 UI/L
Proteinas Totales	**6,0**	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
PROTEINAS TOTALES, SANGRE Método: Colorimétrico	**6,0**	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
ALBUMINA Método: Colorimétrico	**3,3**	g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
CALCIO, SANGRE Método: Colorimétrico	**8,8**	mg/dl	8.5 - 10.4 mg/dl
FOSFORO, SANGRE Método: UV	**2,7**	mg/dl	2,4 - 4,7 mg/dl

138

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2133427**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado		Fecha:	04/02/20 08:08
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 4 | Cama: 4		**Página 1 de 1**

MICROBIOLOGIA

Resultados

Jefe de Sección: **Juan Andres Stupka | Bioquímico | M.N. 7528**

HISOPADO RECTAL

Cultivo	**Positivo**
Identificación del Germen	***klebsiella pneumoniae***
Enterobacteria productora de Carbapenemasa (KPC)	**Positivo**
Enterobacteria productora de Carbapenemasa (MBL)	**Negativo**

Resultados validados electrónicamente por:

Flavia Alejandra Amalfa
Bioquimica - M.N. 9641

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**	N° Orden:	**2132752**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha:	31/01/20 10:07
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4		

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados			Valores de Referencia	
HEMOGRAMA					
Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire					
SERIE ERITROCITARIA					
Eritrocitos	**2,97**	*10^12/L		3,88 - 4,99 *10^12/L	
Hemoglobina	**8,5**	g/dl		11,8 - 14,8 g/dl	
Hematocrito	**26,6**	%		36,0 - 44,0 %	
Indices Hematimétricos					
Volumen Corpuscular Medio	**89,7**	fL		80,5 - 100,0 fL	
Hemoglobina Corpuscular Media	**28,5**	pg		26,0 - 34,0 pg	
Concentración de Hb Corpuscular Media	**31,8**	g/dl		31,6 - 37,5 g/dl	
Amplitud de Distribución eritrocitaria	**16,5**	%		11,6 - 13,9 %	
SERIE PLAQUETARIA					
Plaquetas	**341,0**	*10^9/L		130,0 - 350,0 *10^9/L	
Volumen Plaquetario Medio	**7,8**	fL		7,6 - 11,0 fL	
Amplitud de ditribucion plaquetaria	**16,7**	%		15,0 - 17,2 %	
Plaquetocrito	**0,267**	%		0,100 - 0, 600 %	
SERIE LEUCOCITARIA					
Leucocitos	**6,11**	*10^9/L		3,90 - 11,10 *10^9/L	
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	**72,20**	%	**4.41** *10^9/L	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 *10^9/L
Linfocitos	**15,30**	%	**0.93** *10^9/L	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 *10^9/L
Monocitos	**6,41**	%	**0.39** *10^9/L	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 *10^9/L
Eosinófilos	**5,44**	%	**0.33** *10^9/L	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 *10^9/L
asófilos	**0,68**	%	**0.04** *10^9/L	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 *10^9/L
ERITROSEDIMENTACION	**86**	mm		1 - 16 mm	

Resultados validados electrónicamente por:

María Inés Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

HEMOSTASIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados		Valores de Referencia
COAGULOGRAMA			
Método: Coagulométrico | ACL Top 300			
RIN	**1,26**		0,90 - 1,20
Fibrinógeno	**717**	mg/dl	216 - 448 mg/dl

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA
Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR	Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943	N° Orden:	2132752
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha:	31/01/20 10:07
Origen	: INTERNADOS	CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4		Página 2 de 3

HEMOSTASIA Jefe de Sección: Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791	Resultados		Valores de Referencia
APTT	25	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustin Migliore
Bioquimico - M.N. 11408

QUIMICA CLINICA Jefe de Sección: Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677	Resultados		Valores de Referencia
GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	99	mg/dl	70 - 110 mg/dl
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	7	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	0,41	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
HEPATOGRAMA Método: Automatizado			
Colesterol Total	168	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
Bilirrubina Total	0,36	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa	0,21	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta	0,15	mg/dl	
Fosfatasa Alcalina	85	UI/L	40 - 130 UI/L
TGO	29	UI/L	5 - 34 UI/L
TGP	32	UI/L	8 - 40 UI/L
Proteínas Totales	5,0	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
PROTEINAS TOTALES, SANGRE Método: Colorimétrico	5,0	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
ALBUMINA Método: Colorimétrico	2,8	g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
CALCIO, SANGRE Método: Colorimétrico	8,0	mg/dl	8.5 - 10.4 mg/dl
FOSFORO, SANGRE Método: UV	2,3	mg/dl	2,4 - 4,7 mg/dl

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**	N° Orden:	**2132752**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha:	31/01/20 10:07
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4		

QUIMICA CLINICA

Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**

	Resultados		Valores de Referencia
MAGNESIO Método: Colorimétrico	1,49	mg/dl	1,6 - 2,55 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	142	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	3,1	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	103	mmol/L	90 - 110 mmol/L
PROTEINA C REACTIVA (PCR) Método: Inmunoturbidimetría	154	mg/l	0 - 5 mg/l

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

142

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Buenos Aires Ciudad

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **2131257**

DNI : 4214110 Médico: Sin médico asignado Fecha: 27/01/20 10:23

Origen : **INTERNADOS** CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados			Valores de Referencia	
HEMOGRAMA					
Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire					
SERIE ERITROCITARIA					
Eritrocitos	**2,92**	*10^12/L		3,88 - 4,99 *10^12/L	
Hemoglobina	**8,4**	g/dl		11,8 - 14,8 g/dl	
Hematocrito	**26,5**	%		36,0 - 44,0 %	
Indices Hematimétricos					
Volumen Corpuscular Medio	**90,6**	fL		80,5 - 100,0 fL	
Hemoglobina Corpuscular Media	**28,8**	pg		26,0 - 34,0 pg	
Concentración de Hb Corpuscular Media	**31,8**	g/dl		31,6 - 37,5 g/dl	
Amplitud de Distribución eritrocitaria	**16,2**	%		11,6 - 13,9 %	
SERIE PLAQUETARIA					
Plaquetas	**216,0**	*10^9/L		130,0 - 350,0 *10^9/L	
Volumen Plaquetario Medio	**8,4**	fL		7,6 - 11,0 fL	
Amplitud de ditribucion plaquetaria	**16,4**	%		15,0 - 17,2 %	
Plaquetocrito	**0,181**	%		0,100 - 0, 600 %	
SERIE LEUCOCITARIA					
Leucocitos	**8,65**	*10^9/L		3,90 - 11,10 *10^9/L	
Fórmula Leucocitaria					
Neutrófilos Segmentados	**78,80**	%	**6.82** *10^9/L	36,00 - 66,00 %	1,80 - 7,40 *10^9/L
Linfocitos	**10,40**	%	**0.90** *10^9/L	22,00 - 40,00 %	1,10 - 3,50 *10^9/L
Monocitos	**4,91**	%	**0.42** *10^9/L	4,00 - 11,07 %	0,21 - 0,92 *10^9/L
Eosinófilos	**5,27**	%	**0.46** *10^9/L	0,15 - 5,07 %	0,02 - 0,67 *10^9/L
Basófilos	**0,57**	%	**0.05** *10^9/L	0,00 - 1,36 %	0,00 - 0,13 *10^9/L
ERITROSEDIMENTACION	**105**	mm		1 - 16 mm	

Resultados validados electrónicamente por:

María Ines Zanotto
Bioquímica - M.N. 6669

HEMOSTASIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados	Valores de Referencia
COAGULOGRAMA		
Método: Coagulométrico | ACL Top 300		
RIN	**1,24**	0,90 - 1,20

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**	N° Orden:	**2131257**
DNI	: 4214110	Médico: Sin médico asignado	Fecha:	27/01/20 10:23
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4		

HEMOSTASIA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**			
APTT	**26**	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ezequiel Agustin Migliore
Bioquímico - M.N. 11408

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
GLUCEMIA Método: Hexoquinasa	**83**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
UREA, SANGRE Método: Cinético UV	**21**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
CREATININA, SANGRE Método: Cinético Colorimétrico	**0,44**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	**145**	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	**3,2**	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	**107**	mmol/L	90 - 110 mmol/L
PROTEINA C REACTIVA (PCR) Método: Inmunoturbidimetría	**269**	mg/l	0 - 5 mg/l

Resultados validados electrónicamente por:

Alejandro Esteban Burgos
Bioquímico - M.N. 11528

144

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**5020784**
DNI	: 4214110	Profesional Solicitante:	Sin médico asignado	Fecha:	24/01/20 14:41
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 1 | Cama: 4		**Página 1 de 2**

HEMATOLOGIA	Resultados		Valores de Referencia
HEMOGRAMA			
Método Automatizado			
Hematocrito	**24,5**	%	36,0 - 44,0 %
Hemoglobina	**8,2**	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
VCM	**87,3**	fL	80,5 - 100,0 fL
Leucocitos	**6,17**	*10^9/L	3,90 - 11,10 *10^9/L
Formula Leucocitaria			
Neutrófilos	**76,3**	%	36 - 66 %
Linfocitos	**12,8**	%	22 - 40 %
Monocitos	**9,2**	%	4 - 11 %
Eosinófilos	**1,3**	%	1 - 5 %
Basófilos	**0,4**	%	0 - 1 %
Plaquetas	**144,1**	*10^9/L	130,0 - 350,0 *10^9/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Luciano Picone
Bioquímico - M.N. 12136

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO DE GUARDIA
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687
Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**5020784**
DNI	: 4214110	Profesional Solicitante:	Sin médico asignado	Fecha:	24/01/20 14:41
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 1 | Cama: 4		

MEDIO INTERNO	**Resultados**		**Valores de Referencia**
ESTADO ACIDO BASE			
pH Método: Automatizado	7,377		7.350 a 7.450
pCO2	43,0	mmHg	35,0 - 45,0 mmHg
pO2	54	mmHg	83.0 - 108.0 mmHg
cHCO3	24,7	mmol/L	22,0 - 26,0 mmol/L
EB	-0,5	mmol/L	-3 / +3
sO2	86	%	94 - 98 %
O2Hb	85	%	80 - 97 %
Lactato Método: ISE Indirecto	0,93	mmol/L	0,20 - 2,00mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dr. Luciano Picone
Bioquímico - M.N. 12136

Material remitido al Laboratorio

Fecha de Impresión: 24/01/2020 [illegible]:43

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**	N° Orden:	**2130509**
DNI	: 4214110	Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE	Fecha:	23/01/20 09:57
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA Sala: 4 | Cama: 4		

HEMATOLOGIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados		Valores de Referencia
HEMOGRAMA			
Método: Automatizado, Abbott CD Sapphire			
Observaciones	HEMOGRAMA COAGULADO		
ERITROSEDIMENTACION	**61**	mm	1 - 16 mm

Resultados validados electrónicamente por:

María Ines Zanotto
Bioquimica - M.N. 6669

HEMOSTASIA

Jefe de Sección: **Luis Scigliano | Bioquímico | M.N. 2791**

	Resultados		Valores de Referencia
COAGULOGRAMA			
Método: Coagulométrico | ACL Top 300			
RIN	**1,15**		0,90 - 1,20
Fibrinógeno	**637**	mg/dl	216 - 448 mg/dl
APTT	**24**	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Ana María Dorr
Bioquimica - M.N. 7951

QUIMICA CLINICA

Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**

	Resultados		Valores de Referencia
GLUCEMIA	**87**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa			
UREA, SANGRE	**14**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
Método: Cinético UV			
CREATININA, SANGRE	**0,52**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
Método: Cinético Colorimétrico			
HEPATOGRAMA			
Método: Automatizado			
Colesterol Total	**153**	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2130509**
DNI	: 4214110	Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE		Fecha:	23/01/20 09:57
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 4 | Cama: 4		**Página 2 de 5**

QUIMICA CLINICA

Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**

	Resultados		Valores de Referencia
Bilirrubina Total	0,42	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
Bilirrubina Directa	0,20	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
Bilirrubina Indirecta	0,22	mg/dl	
Fosfatasa Alcalina	73	UI/L	40 - 130 UI/L
TGO	20	UI/L	5 - 34 UI/L
TGP	16	UI/L	8 - 40 UI/L
Proteinas Totales	5,2	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
ÁCIDO URICO, SANGRE Método: Colorimétrico	3,9	mg/dl	2,4 - 7,0 mg/dl
COLESTEROL TOTAL Método: Colorimétrico	153	mg/dl	Deseable <200 mg/dl Moderado 200 - 239 Alto >240
COLESTEROL HDL Método: Directo - Colorimétrico	66	mg/dl	40 - 100 mg/dl
COLESTEROL LDL Método: Directo - Colorimétrico	60	mg/dl	Deseable: Menor a 100 mg/dl Límite: 100 - 130 mg/dl Moderado: 130 - 160 mg/dl Alto: mayor a 160 mg/dl
COLESTEROL NO HDL Método: Cálculo	87	mg/dl	Deseable: Menor a 130 mg/dl Límite: 130 - 160 mg/dl Moderado: 160 - 190 mg/dl Alto: Mayor a 190 mg/dl
ÍNDICE DE CASTELLI (RIESGO ATEROGÉNICO) Método: Cálculo	2,3		Valor deseable: menor a 4,5
TRIGLICERIDOS Método: Colorimétrico	90	mg/dl	10 - 150 mg/dl
PROTEINAS TOTALES, SANGRE Método: Colorimétrico	5,2	g/dl	6,0 - 8,7 g/dl
FERREMIA Método: Colorimétrico	40	µg/dl	50 - 156 µg/dl
TRANSFERRINA Método: Inmunoturbidimetría	157	mg/dl	200 - 400 mg/dl
% DE SATURACIÓN DE TRANSFERRINA Método: Inmunoturbidimetría	20	%	15 - 45 %

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2130509**
DNI	: 4214110	Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE		Fecha:	23/01/20 09:57
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 4 | Cama: 4		

QUIMICA CLINICA

Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**

	Resultados		Valores de Referencia
ALBUMINA Método: Colorimétrico	2,9	g/dl	3,9 - 4,9 g/dl
CALCIO, SANGRE Método: Colorimétrico	8,0	mg/dl	8.5 - 10.4 mg/dl
FOSFORO, SANGRE Método: UV	2,2	mg/dl	2,4 - 4,7 mg/dl
MAGNESIO Método: Colorimétrico	1,86	mg/dl	1,6 - 2,55 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	146	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	3,5	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	108	mmol/L	90 - 110 mmol/L
PROTEINA C REACTIVA (PCR) Método: Inmunoturbidimetría	148	mg/l	0 - 5 mg/l

Resultados validados electrónicamente por:

Nicolas Ramallo
Bioquímico - M.N. 11028

HORMONAS TIROIDEAS

Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**

	Resultados		Valores de Referencia
TIROTROFINA (TSH) Método: ECLIA	3,14	µUI/ml	0,27 - 5,00 µUI/ml
TIROXINA LIBRE (T4L) Método: ECLIA	1,20	ng/dl	0,9 - 1,7 ng/dl

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA
Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2130509**
DNI	: 4214110	Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE		Fecha:	23/01/20 09:57
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 4 | Cama: 4		

ENDOCRINOLOGÍA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
25-HIDROXICOLECALCIFEROL - VITAMINA D3 Método: ECLIA	**30,67**	ng/mL	Valor deseable: 30 - 100 ng/ml Hipovitaminosis : 20- 29 ng/mL Insuficiencia: <20 ng/ml

Resultados validados electrónicamente por:

Sabastian Gabriel Garcia
Bioquimico - M.N. 10168

SEROLOGIA	**Resultados**	**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**		
VDRL Método: Floculación	**No Reactivo**	No reactiva
CHAGAS Método: Hemoaglutinación Indirecta	**No Reactivo**	
CHAGAS Método: Electroquimioluminiscencia	**No Reactivo**	

Resultados validados electrónicamente por:

Sabastian Gabriel Garcia
Bioquimico - M.N. 10168

MARCADORES VIRALES	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
TOXOPLASMOSIS, ANTICUERPOS IgG Método: ECLIA	**51,0**	UI/mL	Reactivo: > 30,5 UI/ml Indeterminado: 1,0 y <30,0 UI/ml No Reactivo: <1,0 UI/ml
TOXOPLASMOSIS, ANTICUERPOS IgM Método: ECLIA	**No Reactivo**		Reactivo: >1,0
HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBs Ag) Método: ECLIA	**No Reactivo**		Interpretación: Mayor a 1 REACTIVO

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA
Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2130509**
DNI	: 4214110	Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE		Fecha:	23/01/20 09:57
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 4 | Cama: 4		

MARCADORES VIRALES	**Resultados**	**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**		
HEPATITIS C, ANTICUERPOS Método: ECLIA	**No Reactivo**	Interpretación: Mayor a 1 REACTIVO

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607

Sabastian Gabriel Garcia
Bioquímico - M.N. 10168

VITAMINAS	**Resultados**		**Valores de Referencia**
Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**			
VITAMINA B12 Método: ECLIA	**465,10**	pg/ml	197 - 771 pg/mL
ACIDO FOLICO Método: ECLIA	**16,58**	ng/ml	3,89 - 26,80 ng/mL

Resultados validados electrónicamente por:

Sabastian Gabriel Garcia
Bioquímico - M.N. 10168

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO CENTRAL

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: FMAKU12051943**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**2130509**
DNI	: 4214110	Médico: GRAMAJO MARIA CELESTE		Fecha:	23/01/20 09:57
Origen	: **INTERNADOS**	CLINICA MEDICA	Sala: 4 | Cama: 4		**Página 1 de 1**

DIAGNOSTICO DE HIV	**Resultados**	**Valores de Referencia**

Jefe de Sección: **Silvia Oliveto | Bioquímica | M.N. 6677**

ANTICUERPOS ANTI HIV

Método: ECLIA - Ensayo de 4ta generacion.
El ensayo detecta en forma conjunta Ac. contra el virus de HIV I/II y Antigeno P24.

Resultado:	**No Reactivo**	Interpretación: Menor a 1: No Reactivo Mayor o igual a 1 : Reactivo

Resultados validados electrónicamente por:

Mariela Mercuri
Bioquímica - M.N. 8607

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO DE GUARDIA

Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687
Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695

Buenos Aires Ciudad

151

PACIENTE : **KUCHASKY, MARGARITA LEONOR** **Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943** N° Orden: **5020579**

DNI : 4214110 Profesional Solicitante: Sin médico asignado Fecha: 22/01/20 09:41

Origen : **GUARDIA** GUARDIA INTERNADOS

HEMATOLOGIA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
HEMOGRAMA			
Método: Automatizado			
Hematocrito	**28,6**	%	36,0 - 44,0 %
Hemoglobina	**9,0**	g/dl	11,8 - 14,8 g/dl
VCM	**89,1**	fL	80,5 - 100,0 fL
Leucocitos	**8,38**	*10^9/L	3,90 - 11,10 *10^9/L
Fórmula Leucocitaria			
Neutrófilos	**74,1**	%	36 - 66 %
Linfocitos	**12,3**	%	22 - 40 %
Monocitos	**10,7**	%	4 - 11 %
Eosinófilos	**2,2**	%	1 - 5 %
Basófilos	**0,7**	%	0 - 1 %
Plaquetas	**160,8**	*10^9/L	130,0 - 350,0 *10^9/L
COAGULOGRAMA			
Método: Automatizado			
RIN	**1,51**		0,90 - 1,20
APTT	**30**	seg	21 - 34 seg

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Lilian Valeria Llanos
Bioquímica - M.N. 10991

IIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
GLUCEMIA	**103**	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Hexoquinasa			
UREA, SANGRE	**18**	mg/dl	10 - 50 mg/dl
Método: Cinético UV			
CREATININA, SANGRE	**0,50**	mg/dl	0,50 - 0,90 mg/dl
Método: Cinético Colorimétrico			
ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO)	**23**	UI/L	5 - 34 UI/L
Método: Cinético UV			
ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP)	**15**	UI/L	8 - 40 UI/L
Método: Cinético UV			

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
LABORATORIO DE GUARDIA
Av. Varela 1301 | Tel.: 4630-7300 | CABA

Jefa de División: Dra. Daniela Ballester | M.N. 7687
Coordinadora del Laboratorio de Guardia: Dra. Rosana Russo | M.N. 6695

Buenos Aires Ciudad

PACIENTE	**: KUCHASKY, MARGARITA LEONOR**	**Edad: 76 Años F.N.: 12-05-1943**		N° Orden:	**5020579**
DNI	: 4214110	Profesional Solicitante:	Sin médico asignado	Fecha:	22/01/20 09:41
Origen	: **GUARDIA**	GUARDIA INTERNADOS			

QUIMICA CLINICA	**Resultados**		**Valores de Referencia**
FOSFATASA ALCALINA Método: Cinético Colorimétrico	**73**	UI/L	40 - 130 UI/L
BILIRRUBINA TOTAL Método: Colorimétrico	**0,41**	mg/dl	0,10 - 1,00 mg/dl
BILIRRUBINA DIRECTA Método: Colorimétrico	**0,17**	mg/dl	0,01 - 0,25 mg/dl
IONOGRAMA Método: Electrodo Ión Selectivo			
Sodio	**141**	mmol/L	135 - 145 mmol/L
Potasio	**3,8**	mmol/L	3,5 - 5,2 mmol/L
Cloro	**104**	mmol/L	90 - 110 mmol/L

Resultados validados electrónicamente por:

Dra. Lilian Valeria Llanos
Bioquímica - M.N. 10991